ISCODD-CI
Initiative de la Société Civile pour les ODD en Côte d'Ivoire

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

Institut National de la Statistique

PNUD

RAPPORT SUR LA SITUATION DES ODD, PRENANT EN COMPTE LES PERSONNES VULNERABLES ET LE GENRE EN COTE D'IVOIRE, 2017-2020



Janvier 2022

SOMMAIRE

PREFACE 3

REMERCIEMENTS 4

Liste des graphiques 5

Liste des tableaux 5

Liste des cartes 6

Sigles et Abréviations 6

Chapitre I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION 8

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 8

1.2 OBJECTIFS 8

Chapitre II : APPROCHE METHODOLOGIQUE ET CARTOGRAPHIE INDICATEURS 9

2.1 PROCESSUS DE REVUE DES INDICATEURS DES ODD EN COTE D'IVOIRE 9

2.2 CARTOGRAPHIE DES INDICATEURS 10

Chapitre III : SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD 13

3.1 PILIER POPULATION 15

3.2 PILIER PROPERITE 31

3.3 PILIER PLANETE 40

3.4 PILIER PAIX 42

3.5 PILIER PARTNARIAT

Chapitre IV : PERSONNES VULNERABLES, LAISSEES POUR COMPTE ET LE GENRE A TRAVERS LES ODD 44

4.1. CONCEPTS DE GENRE, VBG, VULNERABILITES ET LAISSEES POUR COMPTE 44

4.2. ANALYSE SITUATIONNELLE DU GENRE 42

4.3. CARTOGRAPHIE DES PERSONNES VULNERABLES, LAISSEES POUR COMPTE OU A RISQUE D'ETRE LAISSEES POUR COMPTE 47

4.4. TRANSVERSALISASSION DU GENRE DANS LES ODD 61

PREFACE

En s'engageant à réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, les États membres reconnu que la dignité des individus est fondamentale et que les objectifs et les cibles de l'Agenda doivent être remplies pour toutes les nations et tous les peuples et pour tous les segments de la société. S'assurer que ces les engagements se traduisent en actions effectives nécessite une compréhension précise de la cible populations et les progrès réalisés pour répondre à leurs priorités particulières. Pour bien mesurer cela, les statistiques doivent être présentées pour différents groupes de population et zones géographiques.

Le cadre d'indicateurs des objectifs mondiaux de développement durable (ODD) comprend un principe général de désagrégation des données : les indicateurs des objectifs de développement durable ventilées, le cas échéant, par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap et situation géographique, ou d'autres caractéristiques, conformément aux Principes fondamentaux de Statistiques. La pandémie de COVID-19 a encore démontré l'importance des données désagrégées ainsi qu'intégration de plusieurs sources de données lorsque l'entretien en face à face a été interrompu pendant un certain temps dans la plupart des pays.

Conscient que les statistiques sont le fondement d'un meilleur suivi des programmes et politiques des ODD, la Côte d'Ivoire a entrepris la première revue des Statistiques des ODD pour mettre à disposition des autorités des informations nécessaires pour la mise en œuvre de la feuille de route sur les ODD. Ce premier exercice a permis de disposer de la situation de référence, avec plusieurs défauts de désagrégation, et un faible ciblage/identification des populations laissées pour compte,

C'est la raison pour laquelle, nous nous réjouissons de la rédaction de ce deuxième rapport, réalisée conjointement par l'INS et l'ONG Initiative de la Société Civile pour les ODD (ISC ODD) qui a bénéficié d'un fonds du PNUD dans le cadre du projet New deal, qui mettra une emphase sur le genre et les personnes vulnérables, dont l'identification est plus que nécessaire dans la dernière décennie de mise en œuvre des ODD que nous abordons. Ce rapport sur les objectifs de développement durable donne un aperçu des efforts de mise en œuvre en Côte d'Ivoire, en soulignant les domaines dans lesquels des progrès ont été réalisés et les domaines dans lesquels des mesures supplémentaires doivent être prises pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte.

Il marque une évolution conséquente de la série de publication sur le suivi des indicateurs ODD en Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les acteurs du SSN, et les différents partenaires techniques et financiers à s'impliquer davantage dans le processus de suivi des indicateurs des ODD.

Enfin, la diffusion de ce nouveau rapport vient enrichir la gamme de publications faites par l'ISC ODD sur les ODD. Nous exhortons donc les usagers à en faire une bonne exploitation.

REMERCIEMENTS

L'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), est une nécessité pour l'ensemble des pays du monde d'ici 2030. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, s'est engagée à suivre les indicateurs du développement durable dans un cadre institutionnel approprié. A travers un partenariat entre l'INS et l'ISC_ODD. Aussi saisit-elle cette opportunité qui lui est offerte pour adresser ses remerciements aux différents acteurs internes et externes qui lui ont toujours témoigné leur soutien et appui dans les nouveaux défis, comme celui du nouvel agenda 2030.

C'est le lieu pour nous de saluer les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le Système des Nations Unies (SNU) en général, plus particulièrement le PNUD pour leur appui dans la conduite de cette nouvelle activité : « le suivi des indicateurs des ODD ». Nous remercions également les différents acteurs du SSN et les différentes parties prenantes du processus des ODD en Côte d'Ivoire qui ont apporté leur concours pour la conduite de l'activité et plus singulièrement dans la rédaction du rapport.

Ce rapport a bénéficié d'une large phase de consultation avec les divers acteurs du SSN. A ce titre, nous remercions tous les acteurs du SSN de leurs conseils, de leurs temps et leurs retours fort appréciés lors des phases de large consultation.

Liste des graphiques

Graphique 1 :	Disponibilité globale des indicateurs	11
Graphique 2 :	Disponibilité globale des indicateurs en lien avec les cibles priorisées	11
Graphique 3 :	Répartition des indicateurs sexo-spécifiques	12
Graphique 4 :	Cartographie de la pauvreté monétaire par région Cartographie de la pauvreté monétaire par régions administrative 2015 et 2018)	14
Graphique 5 :	Répartition de la pauvreté par groupe d'âge	15
Graphique 6 :	Prévalence de la malnutrition aigüe au niveau national	16
Graphique 7 :	Situation nutritionnelle des femmes enceintes et non allaitante	17
Graphique 8 :	Proportion des personnes vivant en situation d'insécurité par catégorie	18
Graphique 9 :	Ratio de décès maternels pour 100000 naissantes vivantes en 2019	20
Graphique 10 :	Effectif des décès maternels	20
Graphique 11 :	Evolution des nouvelles infections et décès (estimation spectrum 2018)	22
Graphique 12 :	Nombre d'années de scolarité entre 2015 et 20195 et 2019	24
Graphique 13 :	Evolution des taux bruts de scolarisation par niveau d'enseignement 2012 et 2019	25
Graphique 14 :	Répartition des VBG selon le type	26
Graphique 15 :	Evolution du nombre moyen de village électrifié par an de 1994 à 2019	30
Graphique 16 :	PIB par travailleurs exprimé en US à valeur constante en 2011	31
Graphique 17 :	Proportion des jeunes (15-24 ans) ni e emploi, ni en formation, ni scolarisés	33
Graphique 18 :	Volume annuel du fret (2015-2019)	34
Graphique 19 :	Volume de passager, secteur aérien	34
Graphique 20 :	Répartition des emplois selon les 4 principales branches d'activités	35
Graphique 21 :	Répartition des emplois dans l'industrie selon les caractéristiques socio-démographiques	36
Graphique 22 :	Proportion des victimes ayant porté plaintes	42
Graphique 23 :	Répartition des VBG selon l type des personnes survivantes	45
Graphique 24 :	Répartition des VBG selon le type et l'incidence, ou non	46
Graphique 25 ;	Catégorisation des types de VBG	46
Graphique 26 :	Répartition des personnes handicapés selon le type	51
Graphique 27 :	Evolution des personnes handicapées recrutées à la fonction publique	52
Graphique 28 :	Evolution des personnes marginalisées et pauvres prises en charges	54
Graphique 29 :	Evolution des marginalisées et prise en charge selon le sexe	54
Graphique 30 :	Pourcentage total des malades selon l'âge et le site de traitement	55
Graphique 31 :	Pourcentage total de malades selon le niveau d'instruction et le site de traiteement	56
Graphique 32 :	Effectifs des enfants (0-14 ans) handicapés psychique scolarisés	57
Graphique 33 :	Répartition des effectifs des personnes du 3 ème âge selon le sexe	60
Graphique 34:	Source d'approvisionnement du ménage (individu) en saison sèche en eau de boisson selon sexe	61
Graphique 35 :	Type d'éclairage utilisés selon le genre du chef de ménage	63
Graphique 36 :	Répartition de la population par branche d'activités d'activité	65
Graphique 37 :	Utilisation des TIcs en fonction du sexe	65

Liste des tableaux

Tableau 1 :	Répartition des NEETS	50
Tableau 2 :	Effectif des personnes en situation de Handicap	53
Tableau 3 :	Répartition des élevés aveugles par établissements externes	57
Tableau 4 :	Effectif des apprenants en situation de handicap de la FP :	58
Tableau 5 :	Effectif des apprenants en situation de handicap par sexe, et diplômes préparés	58

Liste des cartes

Carte 1:	Cartographie de la pauvreté monétaire selon les régions administrative (2015-2018)	14
Carte 2 :	Cartographie de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans	17
Carte 3 :	Répartition des ménages dirigées par les femmes et pauvres en milieu rural	49
Carte 4 :	Répartition des jeunes de 15-24 ans ni en emploi, ni en formation, ni en éducation ni en emploi, par district	50
Carte 5 :	Distribution spatiale de la prévalence de l'apatridie	59
Carte 6 :	Salaire mensuel moyen des emplois en FCFA selon le sexe	64

Sigles et Abréviations

ARTCI	Autorité de Régulation des Télécommunication en CI
BAD	Banque Africaine de Développement
CCDD	Cadre de Coopération du Développement Durable
CEA	Commission Economique de l'Union Afrique
CEDEAO	Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CHU	Centre Hospitalier Universitaire
CITRANS	Côte d'Ivoire Transport
CMU	Couverture Maladie Universel
CNDP	Comité National de la Dette Publique
CNRA	Centre Nationale de Recherche Agronomique
CNUCED	Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
CPPE	Centre de Protection de la Petite Enfance
CSU	Couverture Sanitaire Universelle
DPS	Direction de la Planification des Statistiques
ECA	Enquête sur la Corruption à Abidjan
EEE	Enquête sur l'Evaluation de l'Etat Nutritionnel
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENA	Ecole Nationale d'Administration
ENE	Enquête Nationale sur la situation de l'Emploi
ENV	Enquête du Niveau de Vie des Ménages
EPU	Examen Périodique Universel
ERI-ESI	Enquête Régionale sur l'Emploi et le Secteur Informel
FBP	Financement Basé sur la Performance
FDAL	Fin de la Défécation à l'Air Libre
GAB	Guichet Automatique de Banque
GPS	Gouvernance Paix et Sécurité
HCNUDH	Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Droits de l'Homme
IDE	Investissement Direct Etranger
IMC	Indice Mondiale Corporel
INS	Institut National de la Statistique
IST	Infection Sexuellement Transmise
IUDH	Index Universel des Droits de l'Homme
MAC	Maisons d'Arrêt et de Correction
MFFE	Ministère de la Femme, de la Famille et de l'enfant
MGF	Maladie Génitale Féminine

MICS	Enquête par grappes à Indicateurs Multiples
MINTOUR	Ministère du Tourisme et de Loisirs
NEET	Ni en Emploi Ni en Formation
ODD	Objectifs du Développement Durable
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PARFACI	Projet d'Appui à la Relance des Filières Agricoles en CI
PGPM	Plan Général de Passation de Marché
PGSPM	Plan Général Simplifié de Passation de Marché
PIB	Produit Intérieur Brut
PND	Plan National de Développement
PNUD	Programme des Nations Unis pour le Développement
PPM	Plan de Passation de Marché
PPN	Petit Poids de Naissance
PPTE	Pays Pauvres Très Endettés
PRONER	Programme National d'Electrification Rurale
PSGouv	Programme Social du Gouvernement
RASS	Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAJ	Santé Adolescent et Jeune
SAVA	Saison Agricole de la Vulnérabilité Alimentaire
SLCP	Stratégie de Lutte contre les Polluants
SNAIC	Stratégie Nationale pour l'Agriculture Intelligente face au Climat
SOTRA	Société de Transport Abidjanais
SSR	Santé Sexuelle et Reproductive
STL	Société de Transport Lagunaire
TA	Taux d'Achèvement
TBS	Taux Brut de Scolarisation
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TPCM	Taux de Prévalence de la Contraception Moderne
TS	Travailleuses de Sexes
UD	Usager de Drogues
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africain
VBG	Violence Basée sur le Genre

RESUME

Ce rapport présente les résultats de la seconde revue des statistiques sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) prenant en compte le genre et les personnes vulnérables pour les années 2015-2022. Il est le fruit d'une collaboration étroite entre l'Initiative de la Société Civile pour les ODD (ISC ODD), l'Institut National de la Statistique (INS) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans le cadre de la mise en œuvre du New deal. La revue s'est appuyée sur les résultats des enquêtes réalisées par l'INS (EHCVM_2018, ENE_2019, MICS2016, Comptes Nationaux, etc.), les données administratives ou de routine collectées auprès des institutions étatiques et non étatiques, principalement des ONG en charge des personnes vulnérables et ou laissées pour compte.

Après un bref état des lieux sur la disponibilité globale des indicateurs de suivi de l'agenda 2030, la revue s'est appesantie sur les **63 indicateurs**, en lien avec les **40 cibles** priorisées retenues dans le cadre de la mise en cohérence de l'agenda 2030 avec le Plan National de Développement (PND 2016-2020) et les plans/stratégies de ministères. Au terme de ce processus, Cent vingt-deux (122) indicateurs, soit **52.5%** sur les deux cent trente-**deux (232),** ont pu (en cours) être renseignés ; **53** indicateurs, sur les 63, que comporte les 40 cibles priorisées ont été renseignés, soit un taux de renseignement de **84.12%.** Sur les **54 indicateurs Sexo-spécifiques des ODD, cette revue a permis de ne renseigner que 16 indicateurs.**

Des progrès non négligeables ont été faits en matière de réduction de la pauvreté, la faisant baisser de 5 points de pourcentage **(44.4% à 39.4%) entre 2015 et 2018.** Elle reste toutefois élevée, avec une prédominance observée chez les femmes. La prévalence nationale de la malnutrition aigüe en 2019 est de 6,8% selon l'EEN et est considéré comme « précaire » selon la classification de l'OMS, la prévalence pour la malnutrition aigüe sévère est très élevée, **1,9%.** Ce taux devrait nous interpeler sur l'efficacité des stratégies mis en place pour le dépistage et la prise en charge des cas de malnutrition aigues modérées et sévère.

L'accès aux infrastructures de bases s'est fortement amélioré. Le taux de couverture en électricité est passé de **33% en 2011 à 69% en fin 2019, puis à 73.6%** en fin juin 2020. Dans le milieu rural, le nombre de localités électrifiées est passé de **4 537 en 2016 à 4 614 en 2017 sur un total de 8 513** localités à électrifier, soit un taux de réalisation de 54,2%. En 2018, le nombre de villages électrifiés est **de 4940 portant le taux à 58,02%. Pour ce qui et de l'Eau, le taux s'élevait à 84.7%.**

La proportion d'accouchement assistées par du personnel de santé qualifié observe une tendance haussière entre 2016 et 2019. Il est passé est de à **57.4% en 2016, à 64.1% en 2018**, puis à **69,4%en 2020,** soit une légèrement en hausse **de 5 points de pourcentage entre 2018 et 2019 et de 2021.**

On a une plus grande exposition au VIH (4.8%) chez les femmes que chez les hommes (1.7%), en 2018. Dans l'Administration Publique ivoirienne le taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision n'atteint pas encore la proportion **(30%)** avec des taux respectifs de **17,46% et 15,19%** pour les années **2018 et 2019.**

Quant 'aux indicateurs d'emplois, le chômage reste plus élevé chez les femmes **(3.7%)** que chez les Hommes **(2.4%) en 2019**, le pourcentage des jeunes est **6,2% (20 à 24 ans**), pour les NEET, on a **38,4%** d'hommes et **16,7%** de femmes. En considérant le revenu mensuel moyen, obtenu à l'issu d'une durée moyenne de formation de 8 ans, est de **107 748 FCFA.** On observe une 'inégalité de revenus au profit des hommes qui reçoivent en moyenne **128 016 FCFA,** tandis que les femmes, **78 541 FCFA.** Quel que soit le district, le milieu, le niveau d'instruction ou la catégorie socioprofessionnelle, le revenu des femmes reste toujours inférieur à celui des hommes, 31,4% des femmes ont un bas salaire, contre 20,2% pour les hommes. De manière générale, cette inégalité demeure, quel que soit le secteur ou le domaine d'activité.

Le Pilier Paix, sur l'ODD 16 est relatif à l'édification de sociétés sûres et pacifiques et la mise en place d'institutions solides. Si des efforts sont faits pour l'amélioration de la gouvernance, et la fourniture de services, ils demeurent toutefois faibles par rapport aux attentes des populations. On observe une persistance des pots de vins versés : 16,8% (12,3% d'hommes et 4,5% e femmes), 18% des chefs d'entreprises. Pour ce qui concerne la dernière expérience avec les services publics, on 7,1% pour les tentatives de vols, 30% harcèlements sexuels et 42,18% pour viol ou tentative de viol. Le pourcentage des enfants de moins de 05 ans enregistré est passé à 75% en 2017.

Pour ce qui des Violences Basées sur le Genre, les femmes sont les plus exposées 92,24% avec 34,98% de filles en 2018, en 2019, 8 femmes sur 10 en été victimes. Les VBG sont plus concentrées en milieu urbain 74,4%. Concernant les personnes vulnérables **54,7%** des ménages sont pauvres et dirigés majoritairement par des hommes (**85,2%).** La prévalence du risque d'apatridie est de **6.57 %** des personnes vivant sur le territoire ivoirien, soit une estimation de **1 656 330** personnes à risque d'apatridie

Parmi les NEET, **on a 27,9% d'enfants de 15-24 ans, 27,5% 15-35 ans et 26,1% 15-40** ans.de filles et 25,2% de garçons. 74% des femmes sont beaucoup plus a atteint par le VIH et 7,4% d'enfant de 0 à 14 ans en 2020. Concernant les types de handicap, on remarque une forte prédominance des handicap moteurs (38,8%) dont la majorité est de sexe féminin, au niveau des handicaps psychique, le nombre de personne de sexe masculin est supérieur. Nous constatons également une légère croissance des personnes dont l'âge varient de 74 à 79 ans avec une majorité de femme, au niveau des plus de 80 ans, et une baisse en 2019, les femmes sont également les plus nombreuses.

Introduction

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

En 2015, les états membres des nations unis adoptent l'agenda 2030, programme de développement durable à l'horizon 2030. Il a pour objectif d'éradiquer la pauvreté et de permettre la transition vers le développement durable. Cet agenda est structuré autour de 17 objectifs, regroupés en 5 piliers : population, prospérité, planète, paix et partenariat.

Afin de pouvoir mesurer les progrès des différents pays dans chacun des objectifs, l'ONU a mis en place un dispositif de suivi organisé et coordonné par le Groupe d'Experts des Nations Unies chargé des indicateurs relatifs au développement durable (IAEG-SDG). Pour chacun des ODD, des cibles ont été définies, celles-ci sont mesurables à travers des indicateurs. Ce sont donc 17 objectifs pour 169 cibles et 231 indicateurs qui sont mis en place pour assurer le suivi des ODD.

Par ailleurs, il est recommandé aux pays d'alignés les ODD sur leurs priorités nationales. A cet effet, la Côte d'Ivoire a priorisé 63 indicateurs en lien avec le PND 2016-2020. En outre, chaque pays s'est engagé à faire à produire des rapports annuels sur l'état des avancées et les efforts qu'il reste à fournir pour l'atteinte de ces objectifs.

Ainsi, la Côte d'Ivoire à travers l'Institut National de la Statistique (INS) a réalisé sa première revue des statistiques des ODD en 2018 portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Cette revue a bénéficié de l'appui financier du PNUD, elle s'est appuyée sur les données issues des différentes enquêtes de l'INS et les données de sources administratives ou de routine. Sur 231 indicateurs 101 ont pu être renseigner, dont 44 sur les 63 en lien avec les priorités nationales PND 2016-2020. L'un des constats de ce premier exercice a été le manque de désagrégation des données selon le genre, le type de handicap.

En s'engageant à réaliser l'agenda 2030, chaque Etat membre a reconnu que la dignité de l'individu est fondamentale et il ne saurait avoir de développement durable sans égalité entre les sexes. D'où l'inscription de l'égalité des sexes en tant qu'objectif de développement durable (ODD 5) et la ventilation de manière transversale des 16 autres ODD selon le sexe.

Pour sa deuxième revue portant sur les années 2018, 2019 et 2020, l'Institut National de la Statistique (INS) en collaboration avec la Société Civile pour les Objectifs du Développement Durable en Côte d'Ivoire (ISCODD-CI) ouvre une lucarne sur les questions du genre et les personnes laissées pour compte (les porteurs d'handicaps, les personnes âgées, les personnes à risque d'apatridie, etc.). Dans ce processus, l'ISCODD-CI a bénéficié de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Cette deuxième revue s'inscrit dans un contexte marqué par plusieurs faits : **i)** la préparation du VNR de juillet 2022, pour lequel la Côte d'Ivoire est éligible, **ii)** l'amorce d'un nouveau quinquennat, marqué par le renouvellement de tous les documents de planification, et de politiques sectorielles, aussi bien au niveau national (PND 2021-2025) qu'au niveau des nations unies (Cadre de Coopération pour le Développement Durable_2021-2025).

1.2 OBJECTIFS

Ce rapport a pour objectif principal de faire le suivi des indicateurs ODD, tout en améliorant le niveau de désagrégation de ces indicateurs (sexe et niveau de vulnérabilité).

De façon spécifique, il s'agit de :

- Faire un état des lieux de la disponibilité des indicateurs ;
- Présenter la situation de chacun des indicateurs des ODD, afin d'évaluer les efforts qu'il reste à fournir pour l'atteinte des cibles ;
- Désagréger les différents indicateurs selon les huit formes de désagrégation, en mettant un accent particulier sur le genre et les personnes vulnérables ;
- Identifier les personnes laissées pour compte dans le processus des ODD.

1.3 Structure du rapport

Ce rapport est structuré en trois chapitres. Le chapitre 1 attrait à la méthodologie et dresse la cartographie des indicateurs. Le chapitre 2 présente la situation de la mise en œuvre des ODD. Le chapitre 3 quant à lui est consacré aux personnes vulnérables et laissées pour compte.

Chapitre I : APPROCHE METHODOLOGIQUE ET CARTOGRAPHIE INDICATEURS

Ce chapitre permet de décrire la méthodologie utilisée pour la production de ce rapport. Il décrit à cet effet, les différentes étapes suivies et présentent les sources de données. Il dresse par ailleurs l'état de la disponibilité des indicateurs des ODD.

1.1 APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA REVUE DES INDICATEURS DES ODD

L'approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude se résume en trois (3) phases : **(i)** la collecte les données **(ii) et** le calcul les indicateurs.

En outre, afin de répondre à l'un des objectifs de ce document qui est de tenir compte du genre et des personnes vulnérables dans l'évaluation des ODD, une série d'actions a été menée. Ces actions ont consisté à (i) mener une enquête auprès des structures (faitières) au service des personnes vulnérables, (ii) étendre la désagrégation des indicateurs des ODD aux personnes vulnérables et (iii) faire à travers diverses bases de données, l'examen des conditions des personnes vulnérables (handicapés, albinos, apatrides...).

1.1.1 Collecte des données

Elle s'est déroulée en 2 phases, à savoir la collecte intra et extra INS.

Elle a d'abord consisté en l'exploitation des rapports et annuaires statistiques de certains ministères et les rapports des enquêtes de l'INS. Le rapport Annuaire des Structures Sanitaires (RASS 2018, 2019, 2020), le Rapport annuel de performance du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Energie et de l'Energie Renouvelables (RAP2020), le rapport sur la mise en œuvre du PND 2016-2020, le Rapport Volontaire National (VNR 2017), le Rapport sur la situation de référence des ODD de l'INS 2017 ont donc été utilisés pour renseigner les indicateurs.

Pour les indicateurs ne pouvant être renseignés après exploitation de ces rapports et annuaires statistiques, une collecte de données a été organisée.

- **Collecte intra INS**

Elle a consisté en l'exploitation des données de l'EHCVM 2018 et des rapports d'enquêtes habituelles de l'INS. Il s'agit :

- des enquêtes CoviD_2020,
- l'enquête Nationale sur la situation de l'Emploi (ENE_2019),
- l'enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM_2018),
- l'enquête sur l'Evaluation de l'Etat Nutritionnel (EEN_2019),
- l'enquête de Suivi de la Saison Agricole et de la Vulnérabilité Alimentaire (SAVA_2018),

- les Comptes Nationaux annuels_2015 à 2019,
- l'enquête auprès des Professionnels du Sexe 2018,
- l'enquête CIPHIA_2018,
- l'enquête sur les Indicateurs Gouvernance Paix et Sécurité (GPS_2017),
- l'Enquête Régionale sur l'Emploi et le Secteur Informel (ERI_ESI_2017),
- l'enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS_2016),
- le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2014).

Cette collecte a permis de renseigner le maximum d'indicateur qui sont du ressort de l'INS, cependant, d'autres données n'étant du ressort de l'institut, une enquête extra INS a été éffectuée.

➢ **Collecte extra INS**

Elle s'est faite en deux étapes à savoir l'une auprès des directions de planifications statistiques des ministères et l'autres auprès des faitières en charge des personnes vulnérables et laissées pour compte.

Collecte auprès des directions de planifications statistiques

A ce niveau, des outils de collecte de données ont été élaboré et soumis à ces différentes directions. Ces outils ont été produits de sorte à répondre à la méthodologie présentée dans les métadonnées. Les différents ministères auprès desquels une collecte de données a été effectués sont données ci-dessous :

- la Direction de Planification Statistique du ministère des transport (DPS);
- la Direction de l'Informatique et de l'Information Sanitaire (DIIS) ;
- la Direction de Planification Statistique de l'ANAGED ;
- la Direction de Planification Statistique du ministère des ressources halieutiques…

Cette étape a fourni des informations autres que celles fournies par l'INS, et qui sont nécessaires pour la rédaction du rapport. Par ailleurs, afin de tenir compte des personnes vulnérables et laissées pour compte, une collecte auprès des faitières en charge des personnes vulnérables a été entreprise.

Collecte auprès des faitières en charge des personnes vulnérables et laissées pour compte

La collecte des données auprès des personnes vulnérables est l'innovation de ce présent rapport, elle s'est faite en deux étapes, à savoir : le regroupement des structures en fonction des handicaps spécifiques qu'elles prennent en charge et l'élaboration de questionnaires spécifiques à chaque structure.

Pami les ONG et structures approchées dans cet exercice, nous pouvons citer. :

- Centre psychiatrique de Bingerville ;
- Ecole des sourds ;
- Centre Abel de Grand Bassam ;
- Institut Ivoirien pour la Promotion des Aveugles ;
- Direction de la promotion des personnes Handicapées ;
- Page Blanche ;
- Programme de Santé mère-enfant...

1.1.2 Calcul des indicateurs des ODD

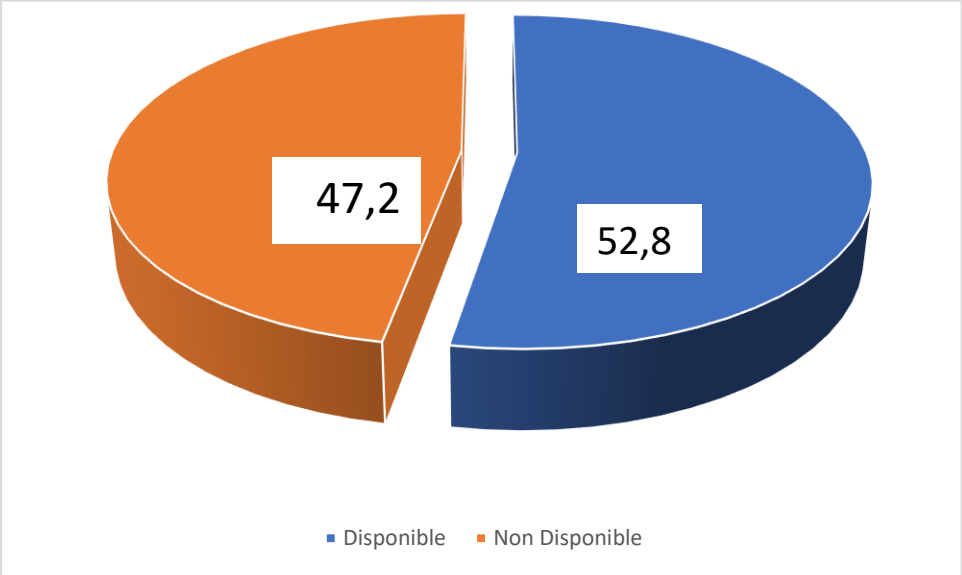
Elle s'est appuyée sur les métadonnées produites par le Groupe d'Experts des Nations Unies et a concerné les données collectées auprès des ministères technique et la base EHCVM 2018. Toutefois, pour certains indicateurs, le système statistique n'est pas en mesure de les renseignés de façon exacte. Pour ces indicateurs et pour les indicateurs du tiers 3 dont aucune méthodologie n'existe, un ou plusieurs indicateurs proxys ont été calculés. Les métadonnées sont sur le site de la Division des Statistique des Nations Unies à l'adresse unstats.un.org/sdgs.

1.2 CARTOGRAPHIE DES INDICATEURS

Cette partie présente la disponibilité des indicateurs des ODD, la disponibilité des indicateurs priorisés et celle des indicateurs sexo-spécifiques.

1.2.1 Disponibilité globale des indicateurs

Pour la deuxième revue des statistiques ODD, **cent vingt-deux (122)** indicateurs sur deux cent trente-deux **(231) soit 52.8%** des indicateurs des ODD ont pu par le Système Statistique National (SSN). Ce taux est en hausse par rapport au premier rapport qui dressait l'état des lieux. Lors de la première revue,**101** indicateurs avaient pu être renseignés sur un total de 230, soit **43,9%.**



Source : ins

2.2.2. Disponibilité des indicateurs en liens avec les cibles priorisées

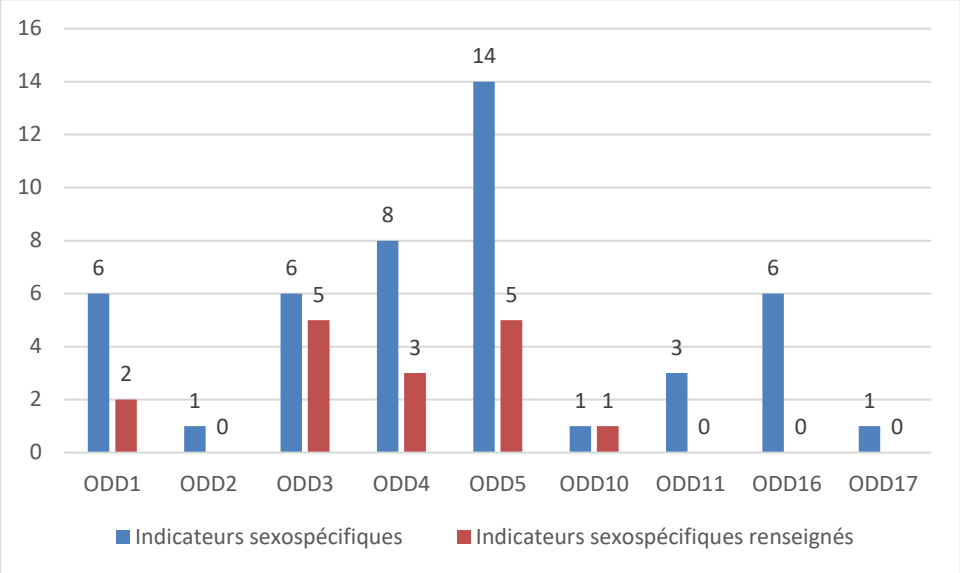
Concernant les indicateurs priorisés, le taux de renseignement s'est également amélioré. En effet, pour ce second rapport, **53 (84.1%)** indicateurs priorisés sur **63** ont été renseignés, contre **44 (69,8%)** lors de la première édition.

2.2.3 Disponibilité des indicateurs en lien avec les indicateurs sexospécifiques

Un indicateur sexospécifique se définie comme un indicateur ODD, exigeant une désagrégation selon le genre, de façon explicite dans le libellé, ou se prêtant à une désagrégation selon le sexe. En se référant à cette définition, **54** des indicateurs des ODD sont dits indicateurs sexospécifiques. Sur ces indicateurs, seulement **16** ont pu être désagrégés selon le genre tel que recommandé par l'indicateur, soit un taux de **29,6%.**

Le graphique ci-dessous présente par ODD le nombre d'indicateurs sexospécifique et le nombre d'indicateurs sexospécifiques renseignés. Il montre que pour certains ODD comme les **ODD 11, 16** et **17**, des efforts énormes restent à faire pour le renseignement des indicateurs sexospécifiques. Toutefois, pour les **ODD 8 et 10** le taux de renseignements des indicateurs sexospécifiques est important.

Graphique 3 : Répartition des indicateurs sexo-spécifiques


16
14
12
10
8
6
4
2
0
6
2
1
0
6
5
8
3
14
5
1
1
3
0
6
0
1
0
ODD1
ODD2
ODD3
ODD4
ODD5
ODD10
ODD11
ODD16
ODD17
Indicateurs sexospécifiques
Indicateurs sexospécifiques renseignés

Source : INS

Chapitre II : SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD

En Côte d'ivoire, le processus d'alignement et de priorisation des 105 cibles considérées dans le cadre du MAPS (Mainstreaming, Acceleration and Policy Support) a permis premièrement d'identifier soixante-quatorze (74) cibles dont 52 sont pris en compte dans le Plan National de Développement (PND 2016-2020) et les plans/stratégies de ministères et deuxièmement de retenir quarante (40) cibles prioritaires pour la Côte d'ivoire. Les indicateurs concernés par les cibles retenues sont au nombre de soixante-trois (63).

Ce Chapitre présente l'état de la mise en œuvre des ODD en Côte d'Ivoire, en se concentrant sur les 63 indicateurs des 40 cibles priorisées.

3.1 PILIER POPULATION



Objectif 1 : Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Cible 1.2 : D'ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges souffrant d'une forme ou l'autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays.

Indicateur 1.2.1 : Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté, par sexe et âge

En 2018, l'EHCVM estimait à **10 064 128** le nombre de personnes appartenant à des ménages vivant avec une dépense de consommation en dessous du seuil[1] national de pauvreté en Côte d'Ivoire, soit **39,4%** de taux de pauvreté. Il est en recul de 5 points de pourcentage par rapport à 2015, où il était de **44,4%.**

1 ***Seuil de pauvreté alimentaire.*** Le seuil de pauvreté alimentaire est le montant qu'il faut à une personne pour se procurer des biens alimentaires lui permettant de renouveler sa force de travail (2 300 kcal). Ainsi, le panier de biens alimentaires est constitué des aliments les plus consommés par la population et représentant 90% de la dépense alimentaire totale des déciles de consommation inter- médiaire (3ème au 7ème décile). Le panier est constitué de 48 produits alimentaires sur les 138, dont principalement l'igname, la viande de bœuf, le riz local, le riz importé dénicachia, le riz importé de luxe, la banane plantain, le poisson fumé et le poisson frais. Le seuil de pauvreté alimentaire est de 238 226 F CFA ou 653 F CFA par jour et par tête.

Seuil de pauvreté non alimentaire. Le seuil de pauvreté non alimentaire est une fraction du seuil de pauvreté alimentaire indispensable à l'acquisition de biens non alimentaires. Elle est calculée en utilisant comme population de référence la population dont la dépense totale correspond au seuil de pauvreté alimentaire (seuil minimum) ou celle dont la dépense alimentaire est égale au seuil de pauvreté alimentaire (seuil maximal). Pour la Côte d'Ivoire il a été retenu d'utiliser le seuil minimum ce qui représente un montant annuel de 113 431F CFA. Pourquoi on n'en parle aucun des indicateurs n'utilise ce seuil.

Seuil de pauvreté national. Le seuil de pauvreté national est la somme du seuil de pauvreté alimentaire et du seuil de pauvreté non alimentaire. Il était de 345 520F CFA l'an en 2018. Ce seuil correspond à une dépense individuelle et journalière de 947 F CFA

Pauvreté en Milieu urbain



L'incidence de la pauvreté est Faible en milieu urbain, **24,7%.**

Alors qu'en

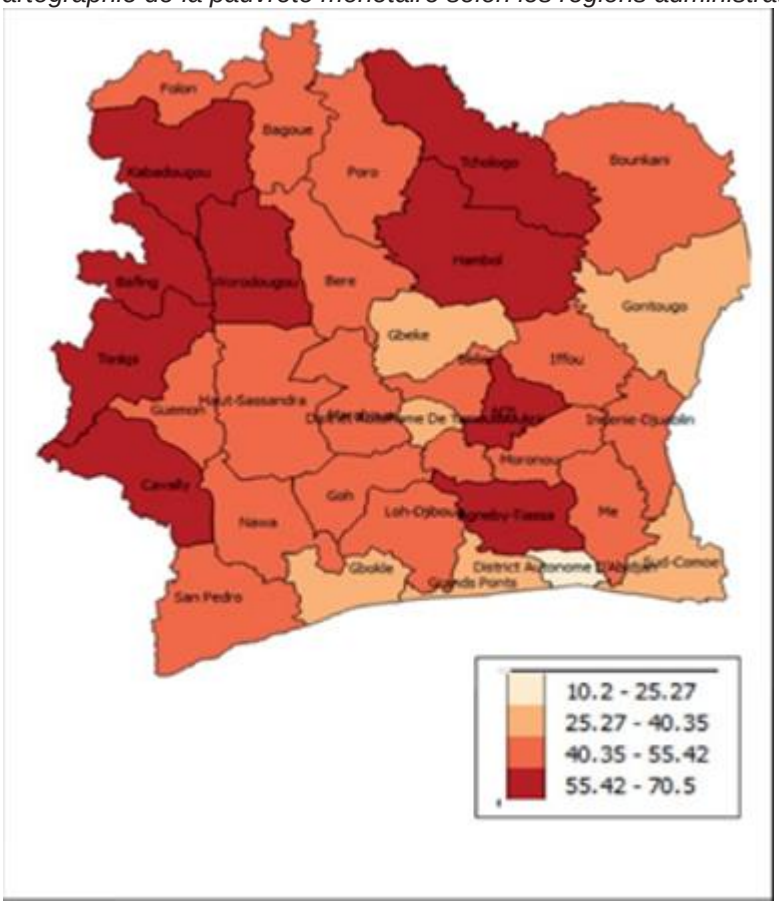
Pauvreté en milieu rural



milieu rural, ce sont **54,7%** de personnes qui vivent avec moins de **947 FCFA/jour**

Pauvreté selon la région

Carte 1 : Cartographie de la pauvreté monétaire selon les régions administrative (2018)



Source : EHCVM 2018

Les tendances générales de la pauvreté monétaire cachent de profondes disparités régionales.

En effet, selon l'EHCVM, en 2018 **plus de trois régions sur quatre** ont leur taux de pauvreté supérieur au taux national **(39,4%)**.
Les régions du Bafing **(67,8%)**, du Kabadougou **(66,4%)**, du Tonkpi **(66,1%)**, du Cavally **(65,8%**), du N'zi **(62,8%)** et du Tchologo **(62,8%)** ont les niveaux de pauvreté les plus élevés. Les autres régions ont un niveau de pauvreté qui varie entre **40** et **60%**.

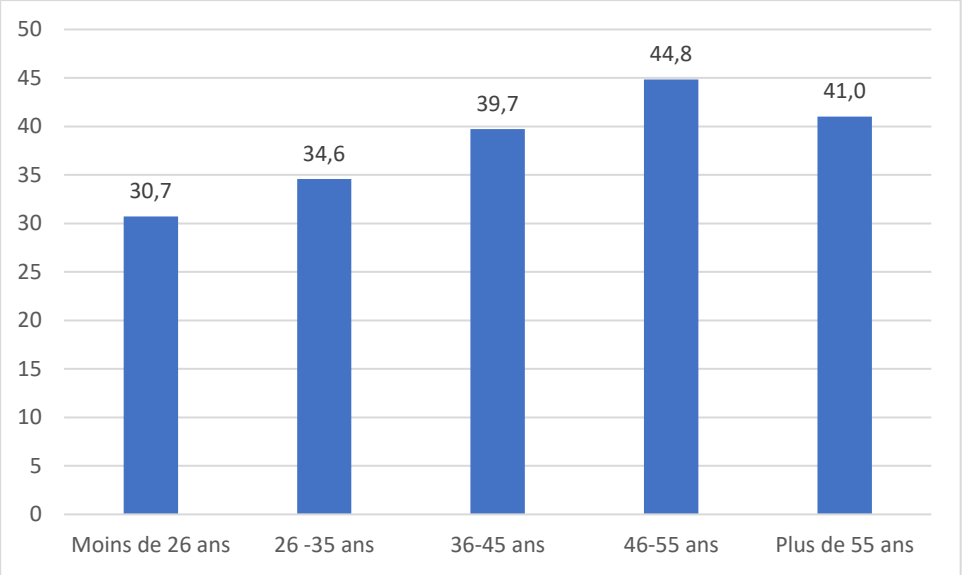
Le District autonome d'Abidjan est la zone ayant le niveau de pauvreté le plus faible du pays environ **10%.**

Pauvreté selon les caractéristiques du chef de ménage

Au niveau national, les ménages dirigés par les hommes sont relativement plus pauvres. Ils regroupent 40**%** de ménages pauvre contre **36,8%** pour les ménages dont le chef est une femme. Cette situation est inverse en milieu urbain et particulièrement à Abidjan. La pauvreté y touche beaucoup plus les femmes par rapport aux hommes (**8,8** contre **15,8 à Abidjan** et **34,1** contre **36,4 dans les autres villes**).

La pauvreté touche plus les individus vivant dans des ménages dont l'âge du chef se situe entre **46 et 55 ans (44,8%).** Les individus appartenant à des ménages dont le chef sont jeunes (**moins de 25 ans**) sont les moins exposés à la pauvreté **(30,7%).**

Graphique 5 : Répartition de la pauvreté par groupe d'âge



Source : EHCVM 2018

Indicateur 1.2.2 : Proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges vivant dans une situation de pauvreté sous toutes ses formes, telles que définies par chaque pays.

Cet indicateur est approximé par le taux d'extrême pauvreté. Celui-ci était de 11,6 % en 2018 selon l'EHCVM.

Objectif 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable

Cible 2.1: D'ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante.

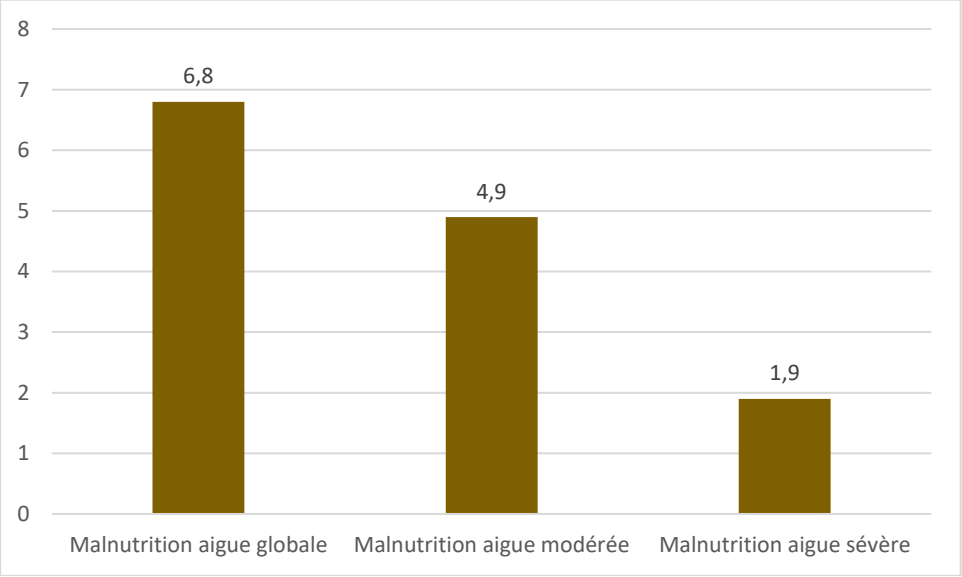
Indicateur 2.1.1 : Prévalence de la sous-alimentation

Une prévalence de la malnutrition aiguë et modérée de plus en plus élevée chez les moins de 5 ans.

Cet indicateur a été approximé par la prévalence de la malnutrition chez les moins de 5 ans et l'état nutritionnel des femmes non enceintes et non allaitantes.

La prévalence nationale de la malnutrition aigüe globale est en baisse entre 2012 et 2016 si on se réfère à l'enquête MICS 2016. Elle est passée de 8% en 2012 à 6% en 2016. La prévalence de la malnutrition aigüe sévère est très élevée (**1,9%**). En **2019** elle se situe à **6,8% selon l'EEN 2019.**

Graphique 6 : Prévalence de la malnutrition aigüe au niveau national

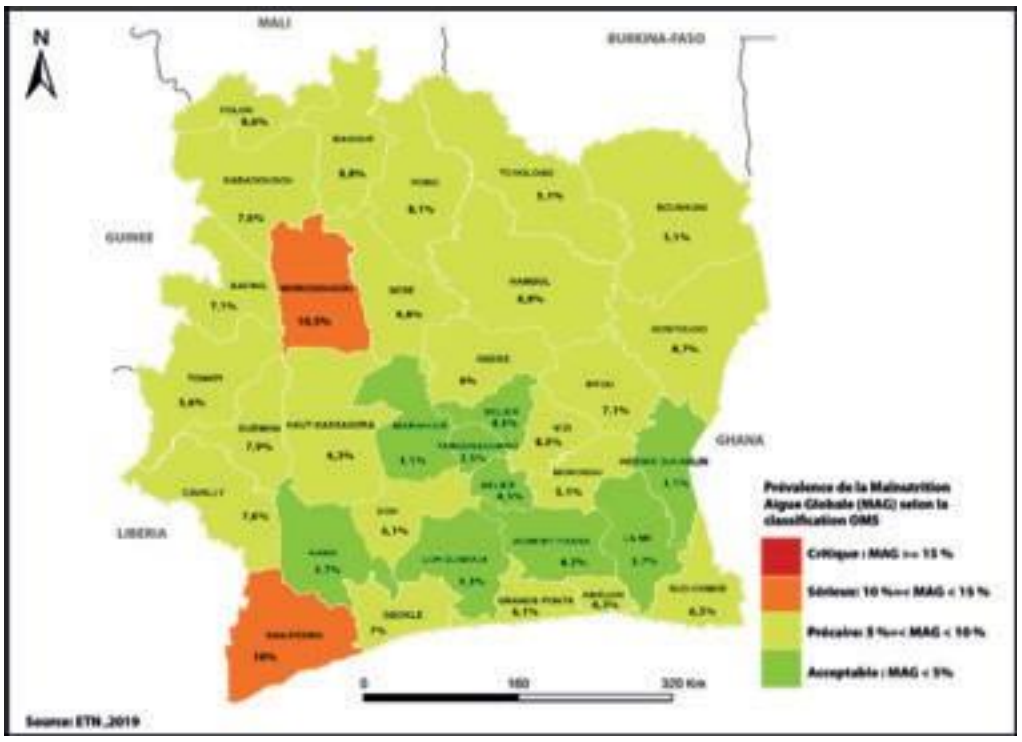


Source : Enquête sur l'Evaluation de l'Etat Nutritionnel : EEN 2019

Au niveau régional

La figure ci-dessous présente la répartition de la malnutrition selon la région en 2019. On observe une prévalence élevée de malnutrition aigüe dans le nord du pays et dans les régions de l'ouest et sud-ouest, en 2019. La situation est jugée précaire selon la classification de l'OMS. Les résultats de l'enquête montrent un niveau de malnutrition aigüe considéré comme « **sérieux** » dans les régions de San-Pedro **(10%)** et du Worodougou **(10,5%)**. Vingt-deux régions ont un niveau de malnutrition aigüe considérer comme « **précaire** » (supérieur au seuil de **5%)**. Le niveau de malnutrition aigüe globale est considéré comme « acceptable » dans huit régions (inférieur au seuil de 5%).

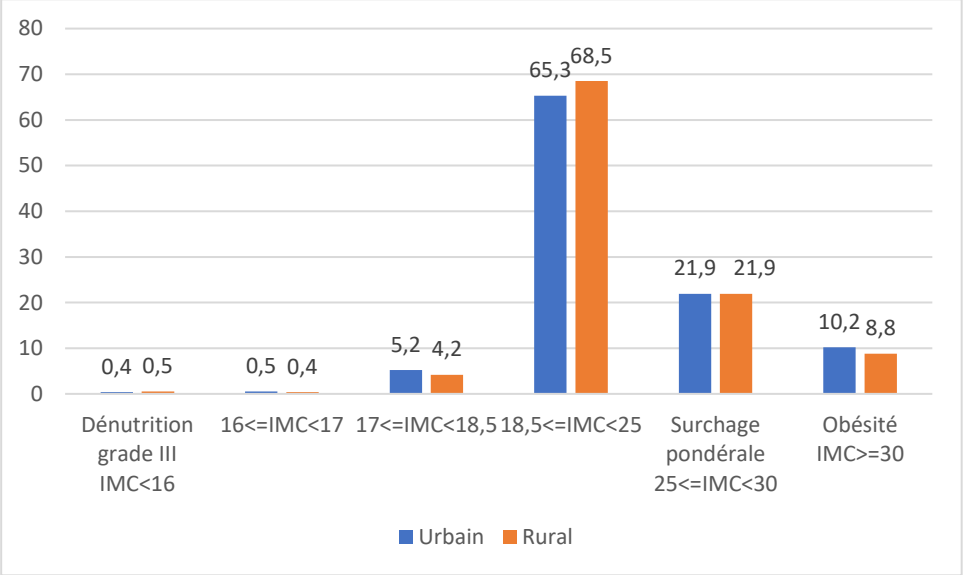
Carte 2 : Cartographie de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans



Source : Enquête sur l'Evaluation de l'Etat Nutritionnel : EEN 2019

L'état nutritionnel des femmes non enceintes et non allaitantes a été mesuré à l'aide de l'Indice de Masse corporelle (IMC). La prévalence des femmes non enceinte en état de surpoids est de **21,9%** largement au-dessus du seuil **10%** défini l'OMS. De même taux d'obésité est de **12,9 % et se situe** au-dessus du seuil de 5**%, fixé par l'OMS**. Le taux d'obésité reste très élevé en milieu urbain (10,2%). Ce qui pourrait s'expliquer par le régime alimentaire hyper-énergétique en milieu urbain.

Graphique 7 : Situation nutritionnelle des femmes enceintes et non allaitante selon le milieu de résidence



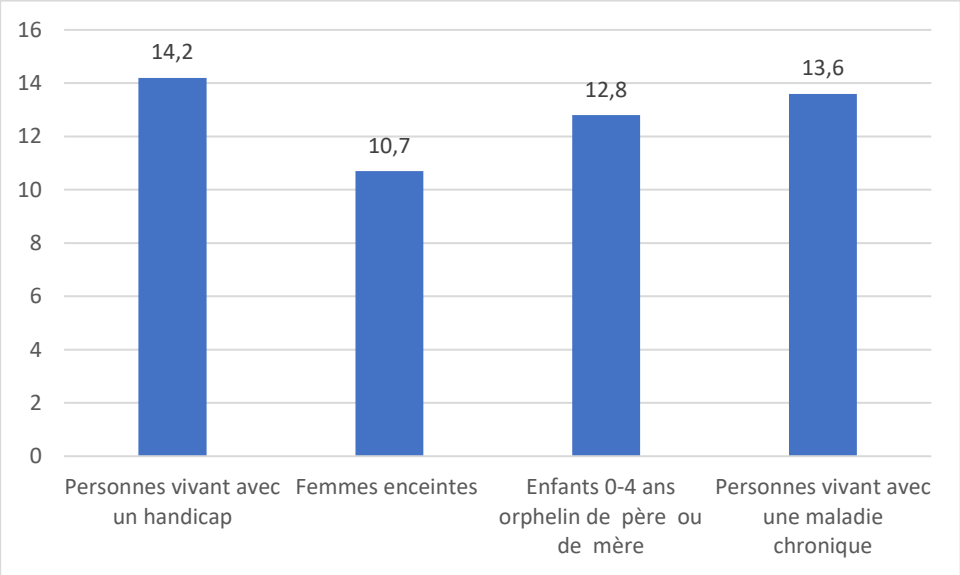
Source : Enquête sur l'Evaluation de l'Etat Nutritionnel : EEN 2019

Indicateur 2.1.2 : Prévalence d'une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l'échelle de l'insécurité alimentaire fondée sur l'expérience

L'enquête sur le suivi de la saison agricole et de la vulnérabilité alimentaire (SAVA) réalisée en 2018 en milieu rural, a permis de disposer des indicateurs pour apprécier la prévalence de l'insécurité alimentaire dans le milieu rural. Ce rapport analyse l'insécurité alimentaire en utilisant deux méthodes : la méthode CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of food security)

Le graphique ci-dessous présente la situation d'insécurité alimentaire des ménages selon la vulnérabilité des membres du ménage, avec l'usage de la méthode CARI. Il ressort de son analyse que les ménages contenant des personnes vivant avec un handicap, ceux contenant des personnes vivant avec une maladie chronique et les ménages ayant des enfants 0-4 ans orphelin de père ou de mère sont plus exposés à l'insécurité alimentaire avec des taux respectifs de **14,20%, 13,60% et 12,80**%. Les femmes enceintes sont les moins exposées à l'insécurité alimentaire **(10,7%).**

Graphique 8 : Niveau d'insécurité alimentaire par catégories de vulnérabilité des membres du ménage



Source : SAVA 2018

Les résultats de la prévalence de l'insécurité alimentaire calculée selon l'échelle de l'insécurité alimentaire fondée sur l'expérience (FIES) montrent quant à eux que **59.3%** de la population rurale en Côte d'Ivoire ont été touchés par une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2018**.**
Ainsi, en 2018, au sein de la population rurale, 59,3% des personnes vivaient dans des ménages où au moins un membre a été forcée, à certains moments de l'année, de réduire la qualité de leur régime, en raison d'un manque d'argent ou d'autres ressources, ou avaient au moins une probabilité de cinquante pour cent d'avoir également réduit la quantité de nourriture consommée.

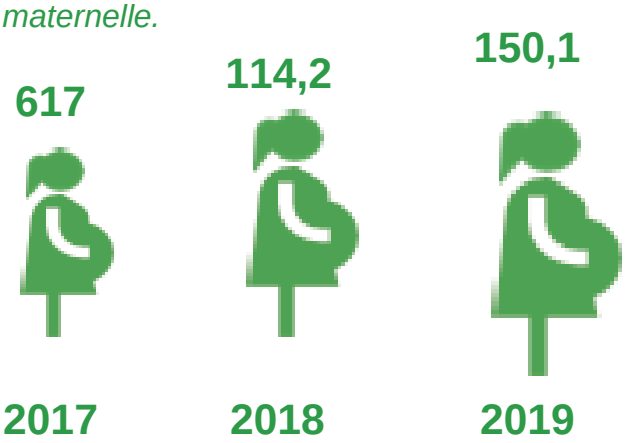


Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

L'objectif 3 vise à assurer la santé et le bien-être des populations à travers : (i) l'amélioration de la santé procréative, maternelle et infantile ; (ii) l'éradication des épidémies et des principales maladies transmissibles, (iii) la réduction des maladies non transmissibles et environnementales ; (iv) la mise en place d'une assurance santé universelle et (v) la garantie de l'accès pour tous à des médicaments et des vaccins sûrs, abordables et efficaces.

Cible 3.1 D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en-dessous de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes

Indicateur 3.1.1 : Taux de mortalité maternelle.

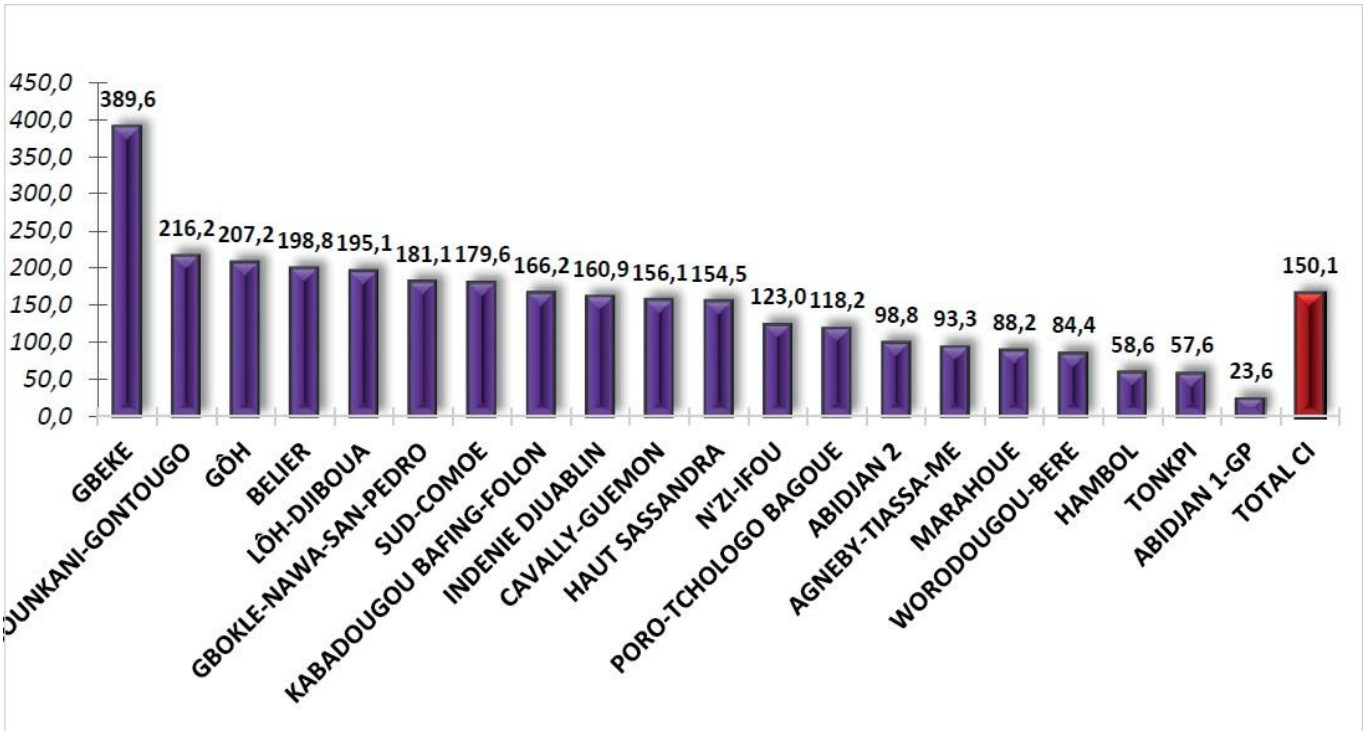


Source : RASS_2019

Le nombre de décès maternel reste toujours un phénomène préoccupant. **La Côte d'Ivoire semble être loin de réaliser l'objectif d'atteindre un taux de 70 décès pour 100 00 naissances en 203. De plus, le taux de mortalité est en hausse sur la période 2018 et 2019. Il est passé de 114,2 à 150,1 pour mille selon le RASS 2019.**

Les principales causes de la mortalité maternelle identifiées en Côte d'Ivoire étaient les hémorragies (25%), l'hypertension (16%), les complications liées aux avortements non médicalisés (10%) et la septicémie (10%). Le nombre de décès maternel reste toujours un phénomène préoccupant.

Graphique 9 : Ratio de décès maternels pour 100000 naissantes vivantes en 2019 selon la région sanitaire



Source : RASS_2020

Sur les 20 régions sanitaires, 17 régions, enregistrent encore des taux éloignés de la cible, tandis que Trois (03) régions enregistrent de bonnes performances.

En effet, La mortalité maternel reste encore un phénomène fortement présent dans les régions sanitaires du GBèkè (389,6 pour 100 000), du Boukani (216,2 pour 100 000) et du Goh (207,7 pour 100 A contrario, Abidjan (23,6 pour 100 000), le Tonkpki (57,6 pour 100 000) et le Hambol (58,6 pour 100 000), enregistrent des taux de mortalité maternelle en deçà de la cible.

Indicateur 3.1.2 : Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié.

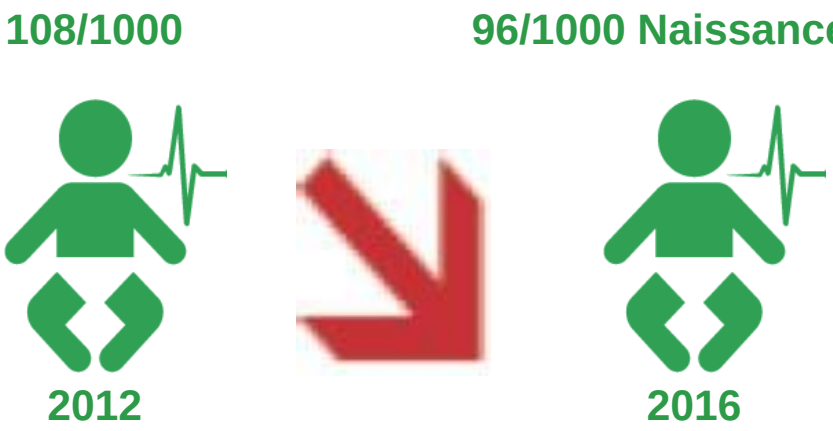
Les statistiques de routine du ministère de la santé et de l'hygiène publique 2019, montrent que la proportion d'accouchement assistées par du personnel de santé qualifié observe une tendance haussière entre 2016 et 2019. Elle est passé est de 57,4% en 2016 à 64,1% en 2018, puis à 69,4% en 2020, soit une légère en hausse d'environ 5 points de pourcentage entre 2018 et 2020.

Entre 2012 et 2016, la part des accouchements ayant eu lieu avec l'assistance d'une accoucheuse traditionnelle a diminué. Elle est passée de 19,9 % en 2012 (27,9 % en milieu rural) à 11,5 % en 2016 (17,4 % en milieu rural). En outre, de très fortes baisses sont observées dans le Centre (4,4 % contre 35,7 % en 2012).

Cible 3.2 : D'ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus.

Indicateur 3.2.1 : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

En 2016, selon les résultats du MICS 2016, le taux de *mortalité des enfants de moins de 5 ans* était de 96 pour 1000 naissances vivantes contre 108 décès pour 1000 naissances en 2012. S'il n'existe pas de statistique récente, il convient toutefois de noter que des efforts sont fait dans l'optique de l'amélioration de la santé de l'enfant. Concernant la prise en charge du nouveau-né, le Gouvernement a ouvert trois unités (CHU de Treichville, CHU de Cocody et CHR de Korhogo) de prise en charge des petits poids de naissance (PPN) par la méthode Soins Mère Kangourou (SMK) qui a permis de prendre en charge 219 PPN (115 au CHR de Korhogo et 104 au CHU Treichville) avec 171 succès soit 78% (Rapport suivi SMK-2019).



Source : MICS 2016

Indicateur 3.2.2 : Taux de mortalité néonatale

Selon le RASS 2018, l'incidence de la mortalité néonatale était de 281 ‰, en 2017. En outre en 2017, le paludisme était la première cause de morbidité des enfants de moins de 5 ans (11,8% des décès était attribuable au paludisme). Toutefois, cette part a baissé en 2017 de 16,2 points de pourcentage par rapport à 2012. En effet, la part du paludisme dans les causes de décès des enfants de moins de 5 ans est passé de 38 % en 2012 à 11,8 % en 2017. Dans 45 % des cas, la cause sous-jacente des décès néonataux était liée à l'état nutritionnel de l'enfant et de la mère.

Les dernières données disponibles du Groupe d'estimations épidémiologiques chez la mère et l'enfant (MCEE) Indiquent qu'en 2019, les principales causes de la mortalité postnatale étaient la pneumonie (19,2 %), la diarrhée (15,7 %) le paludisme (11,8 %), les blessures (9,7 %) et le VIH/ sida (4,5 %). Les autres causes représentaient 35,8% des causes de décès néonatale.

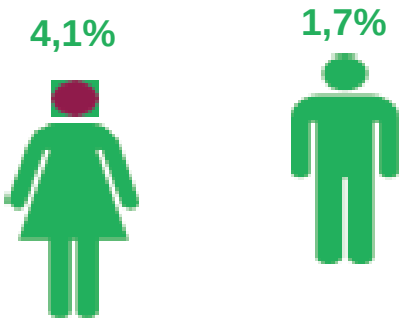
Cible 3.3 : D'ici à 2030, mettre fin à l'épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles

Indicateur 3.3.1 : Nombre de nouvelles infections au VIH pour 1000 personnes séronégatives, par sexe, âge et appartenance à un groupe de population à risques.

La Prévalence du VIH/SIDA en **2018 est de 2,9% selon l'enquête CIPHIA.**



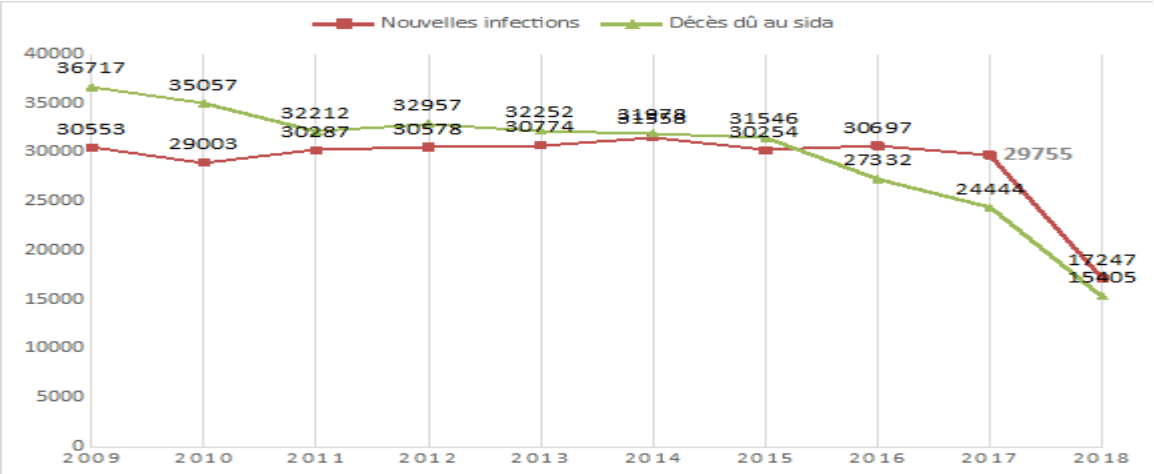
Les femmes sont plus exposées que les hommes.



Source : Enquête CIPHIA 2018

Les nouvelles infections au VIH ont connu une baisse significative entre 2015 et 2018, passant de 30254 à 17247. Cependant, on observe que les nouvelles infections ont évoluées de 14%. Depuis 2016, les nouvelles infections n'ont cessé de décroitre, avec la plus grande observée entre 2017 et 2018 (42%).
Au niveau des décès causés par le VIH, on enregistre également une baisse entre 2015 et 2016. Contrairement aux nouvelles infection les décès liés au VIH ont enregistré une baisse continue sur la période. De 31546 en 2015, ils sont passés à 15405 en 2018. Le taux enregistre également sa plus grande décroissance entre 2017 et 208 (37%).

Graphique 11 : Evolution des nouvelles infections et décès (estimation spectrum 2018) Côte d'Ivoire



Source : Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, entre 2016 et 2018

Ce résultat est le fruit de la mise en œuvre de plusieurs activités en direction des populations clés, des populations cibles et des enfants. Il s'agit notamment des mesures visant la mise sous traitement ARV des travailleuses de sexes (TS), Le dépistage des usagers de drogues (UD) et leur prise en charge.

Indicateur 3.3.2 : Incidence de la tuberculose pour 100 000 habitants.

Selon le Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, entre 2016 et 2018, on observe une tendance à la baisse des cas de tuberculose notifiée. En effet, on enregistre une variation de 7% entre 2016 et 2018. Par ailleurs, au 3ème trimestre de l'année 2019, l'on note 15 780 nouveaux cas et rechutes de tuberculose toutes formes notifiées, soit 94% de la cible pour l'année (projection annuelle 21 040).

Cible 3.7 : D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d'information et d'éducation, et veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux

Indicateur 3.7.1 : Proportion de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) qui utilisent des méthodes modernes de planification familiale.

Selon le Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, en matière de planification familiale, il est à souligner l'engagement de l'État à contribuer financièrement à l'achat de produits contraceptifs et l'absence notable de loi sur la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR). Les résultats enregistrés restent mitigés. On constate entre autres que : (i) la prévalence contraceptive moderne reste encore faible (22,7 % en 2018) ; (ii) le pourcentage des besoins satisfaits en matière de contraception des femmes mariés est de 40,2% en 2018 et (iii) l'indice synthétique de fécondité est de 4,5 enfants par femme en 2018.

Indicateur 3.7.2 : Taux de natalité chez les adolescentes (15 à 19 ans) pour 1000 adolescentes du même groupe d'âge.

Selon le Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, L'introduction de la Santé Adolescent et Jeunes (SAJ) dans 157 structures sanitaires non dédiées aux adolescents et jeunes a permis d'offrir un service de santé holistique aussi bien aux adolescents et jeunes scolarisés que non scolarisés. Il est à noter une réduction de 29,82% du nombre de grossesses précoces en milieu scolaire de 2014 à 2019 avec toutefois une hausse de 33,06% des IST chez les adolescents et jeunes de 2015 à 2019.

Cible 3.8 : Faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d'un coût abordable

Indicateur 3.8.1 Couverture des services de santé essentiels Proportion de la population cible bénéficiant de la couverture des services de santé essentiels

Selon le Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, La mise en œuvre de la stratégie de Financement Basé sur la Performance (FBP) dans le but d'améliorer l'efficience du secteur afin de parvenir à la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) a connu une progression en termes de couverture des districts sanitaires. En effet, le nombre de district couverts est passé de 04 en 2016 à 16 en 2017, puis à 19 en 2018. A ce jour, 401 établissements sanitaires sont sous contrat de Financement Basé sur la Performance. 12% de la population bénéficie de couverture maladie et le taux de disponibilité des médicaments essentiels est de l'ordre de 85%. Cependant, la survenue de la COVID 19 a quelque-peu ralenti la fréquentation des centres d'enrôlement du fait des mesures barrières imposées pour la circonstance par le Gouvernement.

Objectif 4 : assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'Egalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie

L'objectif 4 porte sur l'accès à l'éducation. Il vise à assurer que à terme, tous les individus bénéficient sans discrimination d'une éducation et des possibilités d'apprentissage tout le long de leur vie, qui leur permet d'être socialement productifs. Il recommande également que cette éducation permette l'acquisition des compétences fondamentales, techniques ou professionnelles.

Cible 4.1 : D'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d'égalité, un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant d'acquis.

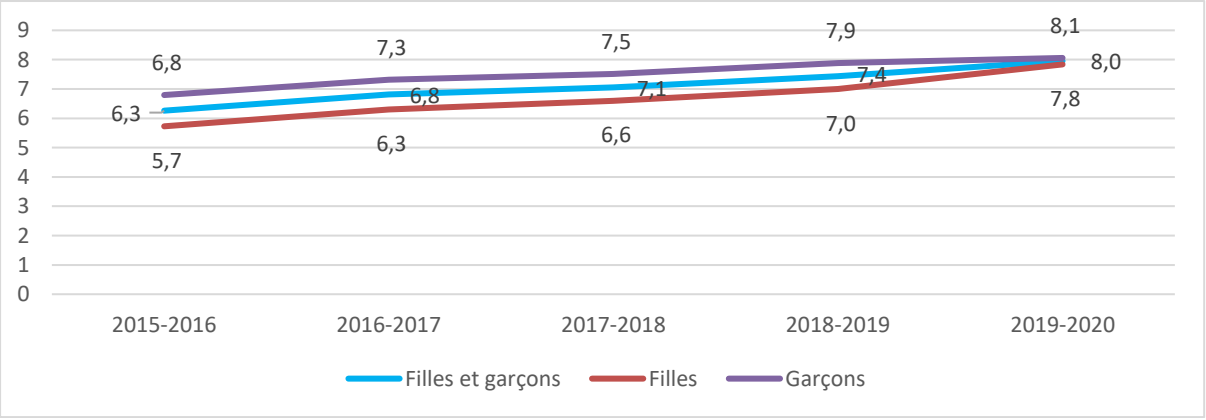
Cette cible est suivie à travers le taux d'achèvement (TA) et le taux brut de scolarisation TBS) au primaire et au secondaire 1er cycle.

Indicateur 4.1.1 : Le taux d'achèvement



- Selon les statistiques de poches_MENET_2020, le taux d'achèvement du primaire, est passé de 80.5% en 2019 à 85% en 2020.
- Le taux Brut de Scolarisation, connait également une hausse. Il est passé de100,5% en 2019 à 114% en 2020.
- De même le taux d'achèvement du premier cycle secondaire, connait une baisse. De 56,7% en 2019, il est passé à 54% en 2020.

Graphique 12 : Nombre d'années de scolarité entre 2015 et 2019

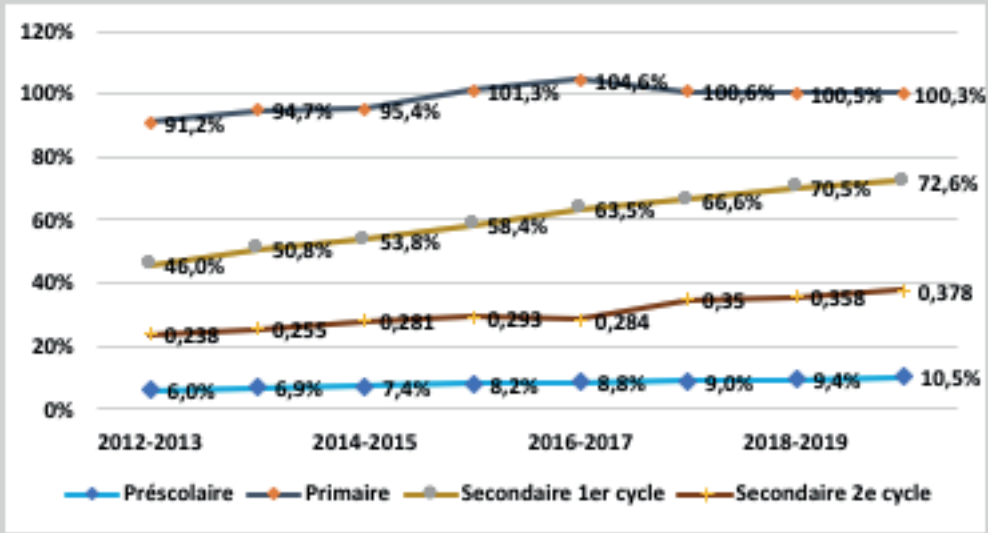


Source : Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD

Indicateur 4.3.1 Taux de participation des jeunes et des adultes à un programme d'éducation et de formation scolaire ou non scolaire au cours des 12 mois précédents, par sexe

Cet indicateur est approximé par le taux brut de scolarisation au premier cycle du secondaire : de 70,5% en 2019, il est passé à 69% en 2020. Sur la période, on note un niveau de réalisation de 72,60%, soit un écart de 3,6. La cible est dépassée du fait d'efforts conjugués de la sensibilisation des parents sur la scolarisation de la jeune fille et du développement d'un programme de construction de nouveaux collèges. Des efforts sur la sensibilisation des parents et dans la construction des nouveaux établissements devront se poursuivre pour consolider les réalisations existantes déjà.

Graphique 13 : Evolution des taux bruts de scolarisation par niveau d'enseignement entre 2012 et 2019



Source : Auteurs à partir des données du MENET-FP-DSPS, Statistiques de poche de 2012-2013 à 2019-2020

CIBLE 4.6 : D'ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter

Indicateur 4.6.1 : Proportion de la population d'un groupe d'âge donné ayant les compétences voulues à au moins un niveau d'aptitude fixé a) en alphabétisme et b) arithmétique fonctionnels, par sexe.

Alphabétisation



- Le pourcentage d'alphabétisation des jeunes hommes de 15-24 ans, selon la MICS 2016, était de 63,8% et 43,1% respectivement en milieu rural et en milieu urbain.
- Les femmes sont quelque peu défavorisées. En 2016, le taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans était de 47,2%, soit 27,3% en milieu rural et 60,9% en milieu urbain.
- Selon l'ERI-ESI, en 2017 le taux d'alphabétisation des 15 ans et plus dans n'importe quelle langue était de 71,5%
- Taux d'alphabétisation des 15 ans et plus dans n'importe quelle langue est de, 76,6% et 66,1%, chez les Hommes et femmes respectivement.

Objectif 5 : Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

L'objectif 5 vise à autonomiser les femmes et les filles afin qu'elles atteignent leur plein potentiel. Cet objectif nécessite donc d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence contre elles.

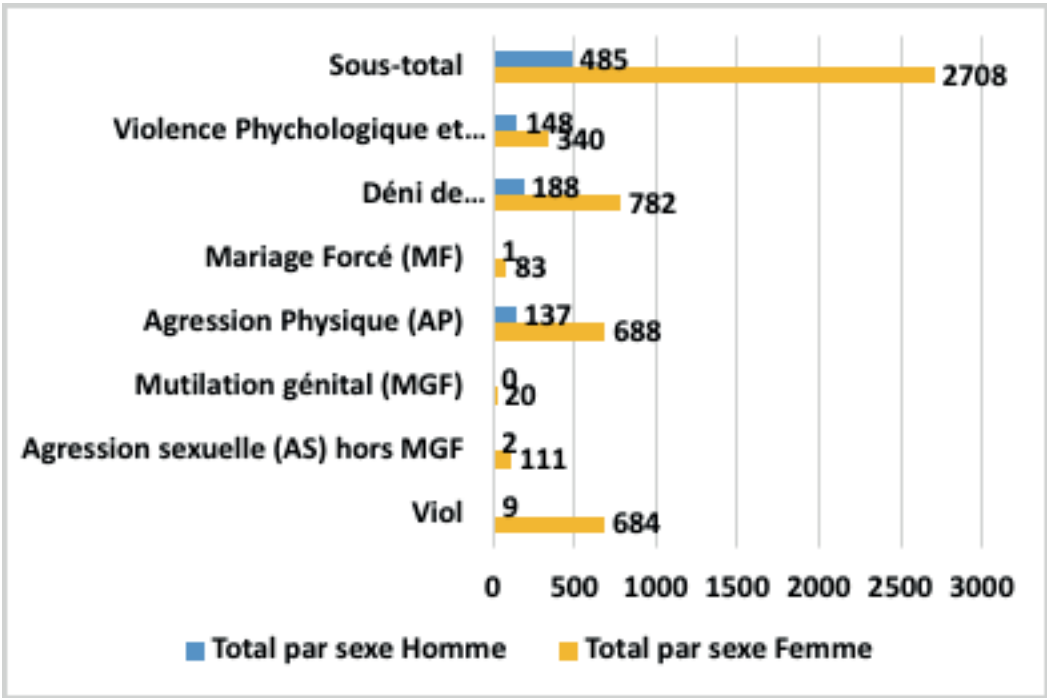
Cible.5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et d'autres types d'exploitation.

Indicateur 5.2.2 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes de violences sexuelles.



Le Phénomène de VBG reste toujours présent en Côte d'Ivoire. En effet, en 2019, on dénombrait 3193 cas de VBG perpétrées sur les femmes (2708) ou les Hommes (485).
Le graphique ci-dessous présente par répartition selon le sexe des différents types de violence. De son analyse, on note que quel que soit le type de violence les femmes sont les plus touchés.

Graphique 14 : Répartition des VBG selon le type



Source : GBIMS_2019

Cible. 5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine

Indicateur 5.3.2 Proportion de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi une mutilation ou une ablation génitale, par âge

Selon le rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, entre 2016 et 2018es MGF/E contribuent à augmenter la morbidité et la mortalité des mères en raison des risques de contamination et de certaines infections et complications obstétricales qu'elles entrainent. En 2016, selon la MICS 36,7% des femmes de 15-49 ans avaient subi des MGF/E contre 38,2% en 2012. En outre, Le pourcentage de filles âgées de 0-14 ans ayant subi une forme quelconque de Mutilation Génitale Féminine/Excision, tel que rapporté par les mères âgées de 15-49 ans est de 10,9%. Le risque de MGF/E est en diminution en milieu urbain mais augmente en milieu rural avec des disparités régionales très grandes au niveau des régions. Le Nord-Ouest (75,2%), le Nord (73,7%), l'Ouest (62,1%) et le Centre-Nord (42%) ont les taux de prévalence les plus élevés.

Par ailleurs, les statistiques collectées par le système d'informations, de gestion, de collecte de données en matière de VBG (GBVIMS) montrent que les MGF restent l'une formes de VBG de plus en plus en voie de disparition, comparée aux autres formes. En effet, elles représentaient en 2018, sur 2744 VBG, 23 cas concernaient les MGF.

Cible. 5.5 Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d'égalité

Indicateur 5.5.1 Proportion de sièges occupés par des femmes dans (a) les parlements nationaux et (b) les gouvernements locaux



- La législature 2017-2021 compte 29 femmes sur un total de 255 sièges, soit une proportion de 11.3% de sièges occupés par les femmes, contre 10.6%, dans la précédente législature (2011-2016).
- Au niveau du Sénat, on a 19 femmes, dont 11 nommées par le Chef de l'Etat, sur un total de 99 Sénateurs, soit 19.2% de femmes dans l'effectif des sénateurs.
- Au niveau des mairies, on dénombre 16 femmes maires sur un total de 201 sièges, soit un taux 7.9%, et 1 femme présidente de Conseil régional.

Indicateur 5.5.2 Proportion de femmes occupant des postes de direction

Cet indicateur a été approximé par la proportion de femme au gouvernement et la proportion des femmes ayant des postes de responsabilité dans la fonction publique et les établissements publics. Selon le Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, on observe une faible représentativité des femmes occupant des postes de responsabilité au Gouvernement. Elle a baissé en passant de 20,68 % en 2017 à 16,66 % en 2018. Toutefois, elle a connu une augmentation entre 2018 et 2020, pour s'établir à 17.39%. Par ailleurs, pour les postes de responsabilités dans la fonction publique et les établissements publics, occupés par les femmes, ils ne représentent qu'environ 26% de l'ensemble des postes de responsabilité sur la même période (2017-2020).

Cible 5.6 : Assurer l'accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu'il a été décidé dans le Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme d'action de Beijing et les documents finals des conférences d'examen qui ont suivi.

Indicateur 5.6.1 Taux de prévalence de la contraception

Selon le Rapport national de mise en œuvre du plan national de développement axe sur les ODD, Même s'il progresse sur le plan national, le taux de prévalence de la contraceptive moderne (TPCM) reste faible. Il tournait autour de 20,9 % en 2018, avec de fortes variations entre les régions (Abidjan : 19,4 % ; Nord- Ouest : 4,8 %) et un écart de plus de 15 points par rapport à la cible retenue pour 2020 (36 %) par le Plan d'action national budgétisé de planification familiale 2015-2020. En 2017 ; 95 % des établissements sanitaires (96,1 % de ceux du secteur public) disposaient d'un service de Planification Familiale offrant au moins trois méthodes de contraception modernes, soit une hausse de 4 points de pourcentage par rapport à 2016 (SARA 2016).



Objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

L'eau potable est définie comme une eau que l'on peut boire sans se rendre malade. Ainsi une eau claire n'est pas forcément potable. L'objectif 6 appelle à prendre des mesures pour assurer l'accès de tous et équitable à l'eau potable, à des services d'assainissement et de l'hygiène à un coût abordable ainsi qu'à la prise en compte des problèmes relatifs aux écosystèmes aquatiques.

Cible 6.1 : D'ici à 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable, à un coût abordable

Indicateur 6.1.1 : Proportion de la population utilisant des services d'alimentation en eau potable gérés en toute sécurité.

L'utilisation de services d'eau potable géré en toute sécurité renvoie à l'utilisant d'une source d'eau potable de base améliorée, située sur place, disponible en cas de besoin et exempte de contamination fécale (et chimique prioritaire). Les sources d'eau potable "améliorées" comprennent : l'eau courante dans le logement, la cour ou la parcelle ; les robinets publics ou les bornes-fontaines ; les forages ou les puits tubulaires ; les puits creusés protégés ; les sources protégées ; l'eau conditionnée ; l'eau livrée et l'eau de pluie. En outre, une source d'eau est considérée comme étant "située sur place" si le point de collecte se trouve dans le logement, la cour ou la parcelle.

Dans ce rapport, l'utilisation de services d'eau potable géré en toute sécurité sera approximé à l'utilisation d'une source d'eau améliorée.

Cet indicateur est issu des différents rapports de l'INS (RGPH 2014, MICS 2016 et ERI-ESI 2017). D'un rapport à l'autre sa mesure diffère dans le RGPH, il sera analysé par l'accès à l'eau à une source de boisson amélioré, tandis que dans la MICS, l'indicateur est mesuré de façon exacte. Dans l'ERI-ESI l'indicateur calculé est l'accès à l'eau potable.



En 2014, le RGPH révélait que 76.5% de la population avait accès à une source d'eau améliorée de boisson. En 2016, selon la MICS, près de 4 ménages sur 5 (80,7%) utilisaient une source améliorée d'eau potable. En 2017, ce taux est passé à 84,5% soit un peu plus de 8 personnes sur 10 réparti entre 92.1%, et 75.8%, en milieu urbain et rural (ERI-ESI).

Cible 6.2 : D'ici à 2030, assurer l'accessibilité équitables de tous, à des services d'assainissement et d'hygiène et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérables.

Indicateur 6.2.1 Proportion de la population utilisant des services d'assainissement gérés en toute sécurité, notamment des équipements pour se laver les mains avec de l'eau et du savon.

Dans le cadre de ce rapport, cet indicateur sera mesuré à travers deux indicateurs : i) la proportion des ménages disposant d'un endroit de lavage des mains et ii) proportion de la population disposant de latrines.

Malgré l'augmentation du taux d'accès aux services de sources d'eau améliorée, la problématique de l'assainissement se pose surtout en milieu rural. Les femmes et les jeunes restent les plus exposées.



Ménage disposant d'un lieu de lavage des mains avec de l'eau et le savon : 96% des ménages disposaient en 2016, d'un endroit précis pour le lavage des mains où l'eau et le savon ou d'autres produits de nettoyage étaient présents, selon la MICS_2016.



Proportion de la population ayant accès à des latrines : La proportion de la population utilisant des latrines reste faible, en effet 43.4 % de la population en 2017, soit un peu plus de 4 personnes sur 10, avait accès, selon L'Enquête Régionale sur l'Emploi et le Secteur Informel (ERI_ESI).

3.2 PILIER PROSPERITE



Objectif 7 : Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes

Cet objectif ambitionne d'assurer l'accès universel à des services énergétiques à tous, à un coût abordable, fiables et durables et de promouvoir l'utilisation des combustibles non polluants pour cuisiner afin d'améliorer l'efficacité énergétique et d'accroître l'utilisation de l'énergie renouvelable.

Cible 7.1 : D'ici à 2030, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable

Indicateur 7.1.1 : Proportion de la population ayant accès à l'électricité.



Accès à l'Electricité en milieu Urbain :

En milieu urbain selon l'ERI-ESI, 92.1% de la population a accès à l'électricité, en 2017.

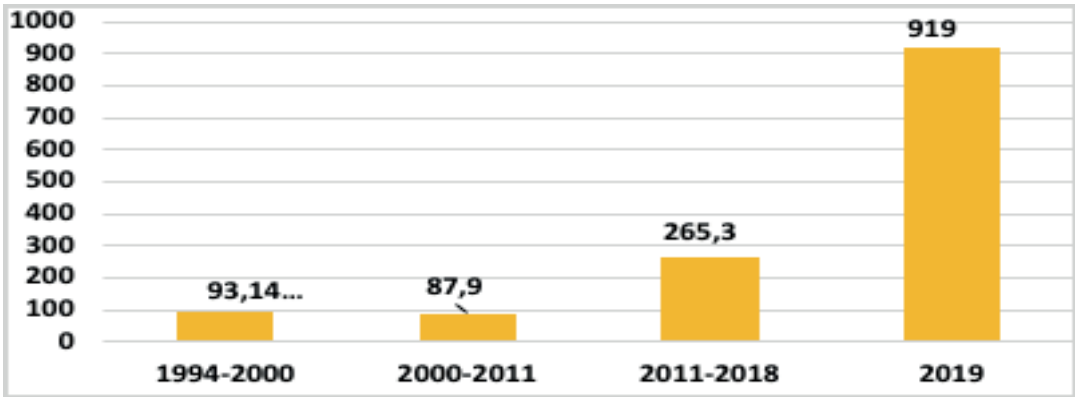


Accès à l'Electricité en milieu Rural.

Dans le milieu rural, c'est 64,3% soit environ 2/3 de la population qui a accès à l'électricité en 2017.

A fin décembre 2019, on note 5859 localités rurales (69%) qui ont été électrifiées, contre 4940 (58%) en 2018. Cette évolution a été possible entre autres grâce à la mise en œuvre du PSGouv. Ce programme a permis l'électrification de 3 041 localités de 2012 à 2019 contre 2 818 localités électrifiées sur la période 1960-2011.

Graphique 15 : Evolution du nombre moyen de village électrifié par an de 1994 à 2019



Source : MPEER, 2020

Indicateur 7.1.2 Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres.

La proportion de la population qui dépend principalement de combustibles et de technologies propres est calculée en divisant le nombre de personnes utilisant des combustibles et des technologies propres pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage par le nombre total de personnes déclarant utiliser des combustibles, du chauffage ou de l'éclairage, exprimé en pourcentage. Dans le cadre de ce rapport, il ne sera présenté que la Proportion de la population ayant accès à des combustibles propres pour la cuisson.

Utilisation de l'énergie propre pour la cuisson

Les combustibles propres et des technologies de cuisson, de chauffage et d'éclairage, s'entendent comme les combustibles émettant moins de CO2, et moins polluantes. Pour cet indicateur, la proportion les combustibles propres considérés sont le Gaz, l'électricité et l'électricité.



Elle s'élevait en 2017 à 28.4%, soit un peu moins de 3 personnes sur 10 selon l'ERI-ESI. On enregistre en outre, comparativement au milieu rural, une relative vulgarisation de ce type de combustible dans les ménages en milieu urbain. La proportion de la population utilisant des combustibles propres pour la cuisson est de 50.2%en milieu urbain contre 3% dans le milieu rural (les 97% utilisant des systèmes de cuisson dangereux et inefficace, basés essentiellement sur le bois).

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

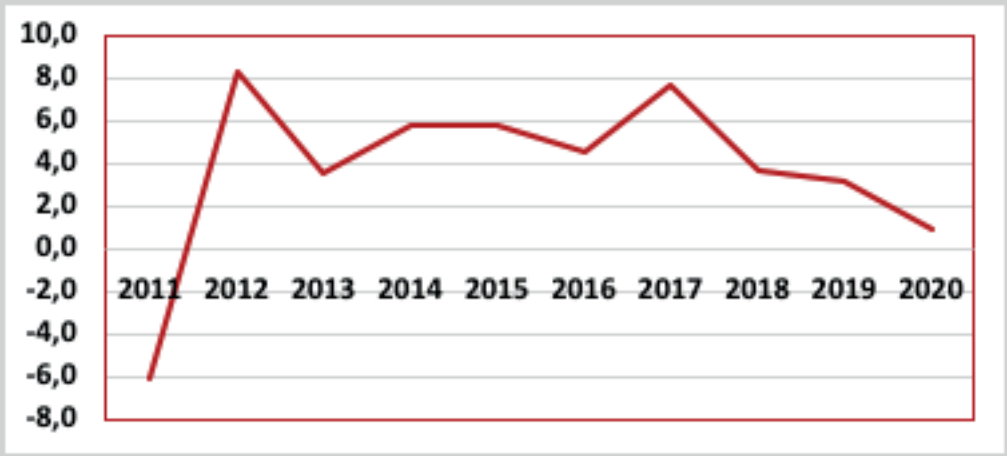
Cible 8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et l'innovation, notamment en mettant l'accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d'œuvre.

Indicateur 8.2.1 Taux de croissance annuelle du PIB réel par personne pourvue d'un emploi

Cet indicateur nous renseigne sur les taux de croissance annuels de la productivité du travail. La productivité du travail s'entendant comme le volume total de production mesuré par le PIB par unité de travail (mesuré en termes du nombre de personnes en emploi) pendant une période donnée.

La Productivité du travail a connu après l'épisode de la crise politique de 2011 où elle a enregistré un taux négatif de 6% une croissance positive depuis 2013, jusqu'en 2017. A partir de cette date, on a enregistré une tendance baissière de la productivité du travail en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des niveaux de plus en faible du PIB par unité de travail. Ce qui nous interpelle par sur tous les intrants dans le processus de production, notamment, l'efficacité du capital humain, et les différentes innovations.

Graphique 16 : PIB réel par travailleurs exprimé en US à valeur constante en 2011

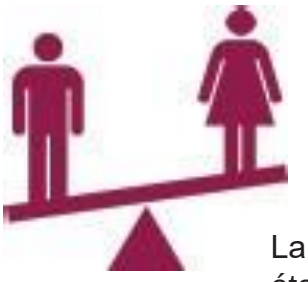


Source : nos calculs avec les données de la Banque mondiale

Cible 5.3. D'ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale

Indicateur 8.5.1 Rémunération horaire moyenne des salariés hommes et femmes, par profession, âge et situation au regard du handicap.

845,5 FCFA **627,2 FCFA**



La Rémunération Horaire moyenne des salariés en 2017, selon l'ERI-ESI était de 853,4 FCFA.

Les femmes restent toujours défavorisées avec une différence en terme de salaire horaire de 145,7 FCFA par rapport aux hommes.

Les données de l'ENE 2019 nous fournissent les informations sur le revenu mensuel moyen. Il ressort de celles-ci que le revenu mensuel moyen, obtenu à l'issu d'une durée moyenne de formation de 8 ans, est de 107 748 FCFA. Il ressort également que les inégalités de revenus sont perceptibles au niveau du genre. En effet, les hommes reçoivent en moyenne128 016 FCFA, contre 78 541 FCFA pour les femmes.

Indicateur 8.5.2 Taux de chômage, par sexe, âge et situation au regard du handicap



Selon l'ENE 2019, les personnes touchées par le chômage sont estimées à 259 602 individus, ce qui correspond à un taux de chômage de 2,9%. Le taux de chômage est en légère baisse par rapport à 2017 où il s'établissait à 3,2% (ERI-ESI).

Le Chômage reste toujours plus élevé chez les femmes que chez les hommes, même si on enregistre une baisse du taux chez les femmes entre 2017 et 2019.

2.9% **3.9%** **2.4%** **3.7%**



2017 (ERI-ESI) **2019 (ENE)**



Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation

L'objectif 9 vise à favoriser une industrie durable et encourager la recherche et l'innovation. Il envisage de permettre une augmentation du niveau de vie et fournir des solutions aux défis du développement de chaque pays, en particulier des pays en voie de développement.

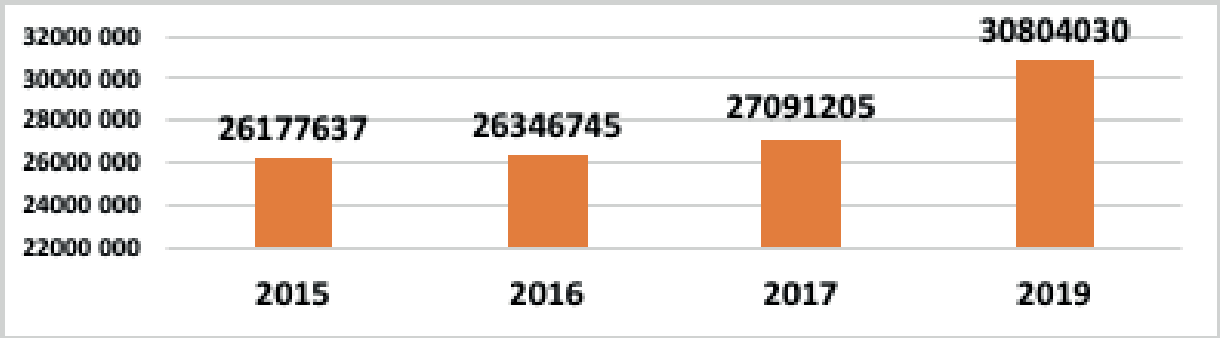
Cible 9.1 : Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente

Indicateur 9.1.2 Nombre de passagers et volume de fret transportés, par mode de transport

Au niveau du sous-secteur portuaire et maritime

Le principal indicateur retenu pour mesurer les progrès accomplis dans le secteur est le volume de fret maritime transporté par an. Cet indicateur a connu une hausse de 17.6% point de pourcentage sur la période de 2015 à 2019. Cet accroissement s'explique en partie par l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi inauguré en février 2019. Ces travaux ont permis d'accueillir des navires porte- conteneurs sans limitation de longueur avec seize (16) mètres de tirant d'eau.

Graphique 18 : volume annuel du fret (2015-2019)



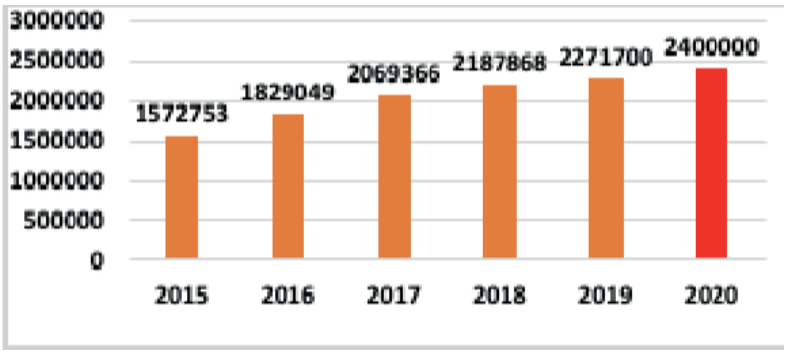
Source : Ministère de transports

Au niveau du sous-secteur aérien

On enregistre entre 2015 et 2019 un accroissement de l'effectif des passagers de 44.4%. En 2019, le volume de passager était de 2271700, soit à un écart de 8 points de pourcentage par rapport à la cible (2 400 000 passagers) attendus en 2020.

Graphique 19 : Volume de passager, secteur aérien





Source : Ministère des transports



Au niveau du sous-secteur ferroviaire.

En termes d'échanges, le volume de fret ferroviaire transporté s'est amélioré. Il est passé de 798 000 tonnes en 2015 à 1 015 874 en 2019, soit une hausse de 27.3%, dépassant ainsi la cible de 1 016 208 tonnes en 2019.

Cette embellie est essentiellement due au transport de clinker, de conteneurs et d'huile végétale en forte croissance, auparavant acheminés par camion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Au niveau du sous-secteur du transport public routier et lagunaire

La Société de Transport d'Abidjan (SOTRA) grâce à sa flotte a transporté plus de 123 millions de passagers en 2018 contre 86 millions en 2017 et 85 millions en 2016. Elle prévoit en transporter 300 millions en 2020. Cette embellie s'explique par l'accroissement du parc auto de la SOTRA avec l'acquisition de 950 en 2018. Cette opération va se poursuivre à hauteur de 500 nouveaux autobus par an jusqu'à la fin de l'année 2020.

Au niveau du transport lagunaire, deux (2) opérateurs privés ont été agréés depuis 2016 pour l'exploitation du plan d'eau lagunaire, à savoir : CITRANS et la STL. Les activités sont marquées par l'existence de 12 gares lagunaires (5 de la société STL, 3 de la société CITRANS et 2 de la SOTRA) avec une mise à flot de 47 bateaux bus (20 bateaux bus SOTRA, 16 bateaux bus STL et 11 bateaux bus CITRANS).

Cible 9.2 Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d'ici à 2030, augmenter nettement la contribution de l'industrie à l'emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national, et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés.

Indicateur 9.2.1 Valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière, en proportion du PIB et par habitant.

Le secteur manufacturier, est tiré par les industries agro-alimentaires, dont la part dans le PIB est passée de 14,3% en 2012 à 17,2% en 2017.

Indicateur 9.2.2 Emploi dans l'industrie manufacturière, en proportion de l'emploi total.

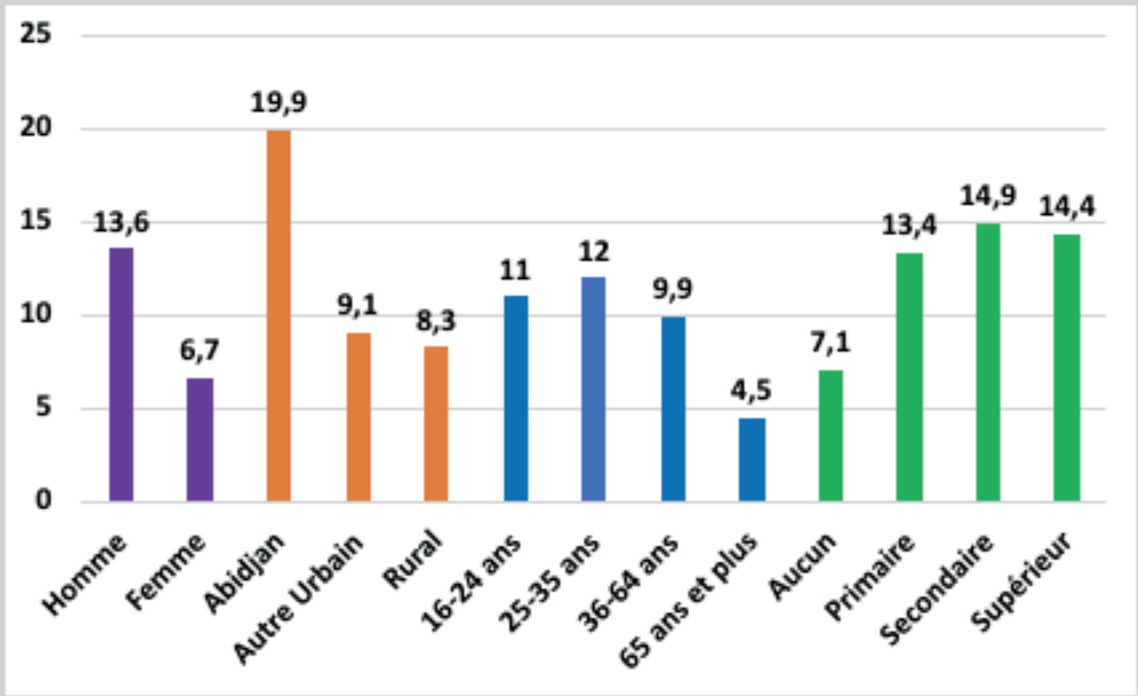
Les emplois, en Côte d'Ivoire selon les comptes nationaux de l'INS, sont dominés par les activités des secteurs de l'agriculture (y compris la sylviculture et la pêche) et de la vente qui fournissent 2/3 des emplois. L'analyse selon les quatre principales branches d'activités montre que l'agriculture (44,3%) est suivie par le commerce et les services en termes de nombre d'emplois avec respectivement 22,9% et 22,1% des emplois. Les emplois dans l'industrie ne représentent que le dixième de l'ensemble des emplois (10.7%) avec 13.6% chez les hommes et 6.7% chez les femmes, soit un ratio du simple au double.

Graphique 20 : Répartition des emplois selon les 4 principales branches d'activités



Source INS ENE 2019

Graphique 21 : Répartition des emplois dans l'industrie selon les caractéristiques socio-démographiques



Source : ENE_2019



Objectif 10 : Réduire les inégalités dans le pays et d'un pays à l'autre

Cible 10.1 D'ici à 2030 assurer progressivement et durablement une croissance des revenus des 40 % de la population

Indicateur 10.1.1 : Taux de croissance des dépenses de ménages ou du revenu par habitant pour les 40% de la population les plus pauvres et pour l'ensemble de la population



Les Enquêtes de Niveau de vie des ménages (ENV) de 2008 et 2015 révèlent que les dépenses des 40% de la population les plus pauvres sont passées de 12, 6% en 2002 à 18,9% en 2015. Si l'on regarde les 10% de la population les plus pauvres, leur part dans la consommation totale est de 2,7% en 2015 contre 1,7% en 2002. Celle des 10% les plus riches se situe à 28,9% en 2015 contre 40,0% en 2002.

Cible 10.2 : D'ici à 2030 autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique.

Indicateur 10.2.1 Proportion de personnes vivant avec un revenu de plus de 50 % inférieur au revenu moyen, par âge, sexe et handicap



Selon l'EHCVM, 39.88% de personnes réparties entre 40.5% Hommes et 36.7% de femmes vivent avec un revenu de plus de 50% inférieur au revenu moyen.



Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts tous, sûrs, résilients et durables

Cible 11.1 D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis

.

Indicateur 11.1.1: Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des implantations sauvages ou des logements inadéquats.



Selon l'ENV 2015, 2,1% des ménages vivent dans des logements inadéquats (baraque). Cette proportion varie selon le statut de pauvreté. À Abidjan, 8% des pauvres vivent dans les baraques.

La proportion de la population vivant dans un logement décent qui était de 33,92 % en 2016 puis à 38,34 % en 2017 est passée à 51,2 % en 2019. Ces performances sont inhérentes aux actions mises en œuvre et au renforcement du cadre législatif et réglementaire. Le nombre de nouveaux logements sociaux et économiques disponible est passé de 4 353 logements en 2017 à 10 126 logements au premier semestre 2020. De plus, 1633 terrains équipés à bas coûts ont été livrés à leurs souscripteurs.

Ces réalisations ont contribué à améliorer l'indicateur de la proportion des répondants étant satisfaits de la disponibilité de logement adéquat qui est passé de 47,7% en 2016 à 49% en 2019, soit un (1) ménage sur deux (2) vivant dans un logement décent en zone urbaine.

3.3 PILIER PLANET



Objectif 12 : Etablir des modes de consommation et de production durables

Une croissance et un développement durables nécessitent de minimiser l'utilisation des ressources naturelles et des matières toxiques, ainsi que les déchets et polluants générés, tout au long du processus de production et de consommation. L'objectif 12 de développement durable encourage des modes de consommation et de production plus durables grâce à différentes mesures, dont des politiques spécifiques et des conventions internationales portant sur la gestion des matières toxiques pour l'environnement.

Cible12.5 : D'ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation.

Indicateur 12.5.1 Taux de recyclage national, tonnes de matériaux recyclés

L'indicateur n'est pas capté à ce jour, faute de données disponibles. Toutefois, depuis 2015, la Côte d'Ivoire a élaboré une stratégie nationale et un plan de gestion des déchets qui intègre la composante de recyclage et de valorisation de ceux-ci. De plus, un plan national d'urgence contre les pollutions accidentelles des eaux par hydrocarbures et autres produits chimiques dangereux a également été élaboré pour couvrir le milieu marin et répondre aux insuffisances du plan POLLUMAR mis en œuvre depuis plusieurs années.

Cible 12.7 : Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales.

Indicateur : 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre des politiques et plans d'action en faveur des pratiques durables de passation des marchés publics

Dans le cadre de l'amélioration des procédures de passation des marchés publics pour une meilleure absorption des crédits et l'atteinte des objectifs de développement, la passation des marchés est anticipée en rapport avec l'année budgétaire ou à la durée d'exécution du marché. En effet, comme indiqué dans l'Art.18 du Code des marchés publics, toutes les opérations de marchés publics sont soumises de façon réglementaire à la planification, sous peine de nullité. A cet effet, les outils de planifications suivants sont élaborés : (a) le Plan Général de Passation des Marchés (PGPM) ; (b) le Plan Général Simplifié de Passation des Marchés (PGSPM) ; (c) le Plan de Passation des Marchés (PPM) et ; (d) le Plan Simplifié de Passation des Marchés (PSPM).



Objectif 13 : Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

Les changements climatiques constituent la plus grande menace au développement, et leurs effets généralisés et sans précédent pèsent de manière disproportionnée sur les plus pauvres et les plus vulnérables. L'objectif 13 appelle à prendre des mesures d'urgence non seulement pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, mais aussi pour renforcer la capacité d'adaptation face aux dangers et aux catastrophes naturelles liés au climat. Pour prendre des mesures urgentes visant à lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

Cible 13.3 : Améliorer l'éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l'adaptation aux changements climatiques, l'atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d'alerte rapide.

Indicateur 13.3.1 Nombre de pays ayant intégré dans leurs programmes d'enseignement primaire, secondaire et tertiaire les questions relatives à l'adaptation aux changements climatiques, à l'atténuation des effets de ces changements et à la réduction de leur impact, ainsi qu'aux systèmes d'alerte rapide.

La Côte d'Ivoire a intégré dans les programmes d'enseignement du système scolaire, des manuels pédagogiques qui traitent les nouvelles thématiques du Développement durable. De plus, il a été développé au niveau de l'enseignement supérieur, des curricula de formation pour l'obtention de master en environnement et développement durable et de Doctorat en Développement durable dans les universités (Université Félix Houphouët Boigny Cocody, Nangui Abrogoua, Lorougnon Guédé, etc.) et plu- sieurs grandes écoles ivoiriennes. Par ailleurs, les capacités des formateurs de l'Ecole National d'Administration (ENA) ont été renforcées par l'institut de la francophonie pour le développement durable.

Indicateur 13.3.2 Nombre de pays ayant fait état du renforcement de leurs capacités institutionnelles, systémiques et individuelles pour favoriser les mesures d'adaptation et d'atténuation, le transfert de technologie et les actions en faveur du développement.

Au titre des réformes, les stratégies élaborées se présentent comme suit :

- Stratégie Nationale REDD+ : dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la reconstitution du couvert forestier, la Côte d'Ivoire a adopté une stratégie nationale REDD+. Cette stratégie, élaborée de façon participative avec l'inclusion de toutes les parties concernées, présente la vision, les politiques et mesures, les missions, le mode de fonctionne-

ment, les orientations technologiques et la collaboration avec les partenaires ;

- Stratégie Nationale pour l'Agriculture Intelligente face au Climat (SNAIC) en Côte d'Ivoire : elle couvre la période 2018 – 2025 et a pour objectif global de « développer à l'échelle nationale une agriculture intelligente en vue d'accroitre la productivité agricole, d'assurer la sécurité alimentaire et la résilience climatique du secteur » ;

- Stratégie nationale de réduction des polluants atmosphériques de courte durée de vie ayant un impact sur le climat (SLCPs) ;

- Initiative cacao-forêts : cette initiative vise à mettre fin à la déforestation dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, à travers la sécurisation des forêts, le renforcement de la résilience du secteur cacaoyer au climat et le maintien et l'amélioration des revenus et moyens de subsistance des agriculteurs et utilisateurs de la forêt.



Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

L'objectif visé par cet ODD est de Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Cet indicateur revêt une importance capitale eu égard aux enjeux de l'économie bleue. Il offre un cadre pour gérer durablement les écosystèmes marins et côtiers et les protéger de la pollution résultant des activités terrestres. Ce cadre prévoit aussi de pallier les effets de l'acidification des océans. Renforcer la préservation et l'utilisation durable des ressources de l'océan au moyen de lois internationales contribuera également à atténuer une partie des défis auxquels sont confrontés nos océans.

Cible 14.4 : D'ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, l'objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d'obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques.

Indicateur 14.4.1 Proportion de stocks de poissons dont le niveau est biologiquement viable

La Côte d'Ivoire a adopté en 2016, la loi relative à la pêche et l'aquaculture qui vise à favoriser la gestion durable des ressources halieutiques et le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Cette loi permet de mieux lutter contre la pêche illicite non autorisée, non réglementée, en corsant les amendes qui sont multipliées par 5 voire 10.

Le Pays a également initié plusieurs programmes d'élevage pour répondre à son autosuffisance en ressources halieutiques : (i) 166 000 alevins de tilapia souche Bouaké et 83 000 alevins de mâchoirons sont produits au niveau des stations d'alevinage de Jacqueville et Dabou et mis à la disposition des pisciculteurs et plus de 1,265 millions d'alevins tilapia souche Bouaké sont produits dans le cadre du Projet d'Appui à la Relance des Filières Agricoles en Côte d'Ivoire (PARFACI) ; (ii) en prélude à la diffusion du tilapia oreochromis niloticus souche Brésil, 10 fermes pilotes ont été sélectionnées pour la conduite des tests de grossissement en milieu paysan de 2000 alevins ; et (iii) 915 géniteurs dont 395 mâles et 520 femelles issus du grossissement direct des alevins venus du Brésil et plus de 226 000 alevins produits sont disponibles à la station piscicole CNRA de Bouaké.



Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité

Cible 15.6 : Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques et promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l'échelle internationale.

Indicateur 15.6.1 Nombre de pays ayant adopté des cadres législatifs, administratifs et opérationnels destinés à assurer un partage juste et équitable des bénéfices.

La Côte d'Ivoire a adhéré au protocole de Nagoya en 2013 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la convention sur la diversité biologique. Des initiatives sont également prises au niveau national dans le document de stratégie nationale de la diversité biologique en son objectif 17 « D'ici à 2020, l'accès aux ressources génétiques, aux connaissances et pratiques présentant un intérêt pour la diversité biologique, est régi par des mécanismes assurant le partage des avantages qui en découlent ».

Cible 15.9 : D'ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité.

Selon le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du Climat (GIEC 2007), le changement climatique pourrait faire baisser le PIB de l'Afrique de 2 à 4 % d'ici à 2040 et cette baisse pourrait atteindre 10% voire 25% en 2100. Mise en perspective, une perte entre 2 % et 4% du PIB de la Côte d'Ivoire représenterait entre 380 et 770 milliards de FCFA en valeur constante de 2017.

Plus grave, le changement climatique pourrait faire basculer 2% à 6% de ménages supplémentaires dans l'extrême pauvreté d'ici 2030. A titre comparatif pour la Côte d'Ivoire, ceci correspondrait à près d'un million de personnes supplémentaires qui basculeraient dans l'extrême pauvreté (personnes vivant avec moins de 1,90 USD par jour). Une personne qui aujourd'hui vit juste au-dessus du seuil de pauvreté, peut basculer dans la pauvreté quand une inondation détruit sa petite entreprise ou une sècheresse décime un troupeau.

Indicateur 15.9.1 Progrès réalisés vers les objectifs nationaux établis conformément à l'objectif 2 d'Aichi pour la biodiversité du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020.

En application de l'objectif 2 d'Aichi, la Côte d'Ivoire a élaboré sa stratégie nationale de la diversité biologique nationale ainsi qu'un plan d'action opérationnel pour la diversité sur la période 2016-2020 et plusieurs actions en découlant sont mises en œuvre. De plus, la préservation de la biodiversité est renforcée dans la planification nationale (PND 2016-2020 ; Axe 4 ; Extrant 4.4).

3.4 PILIER PAIX



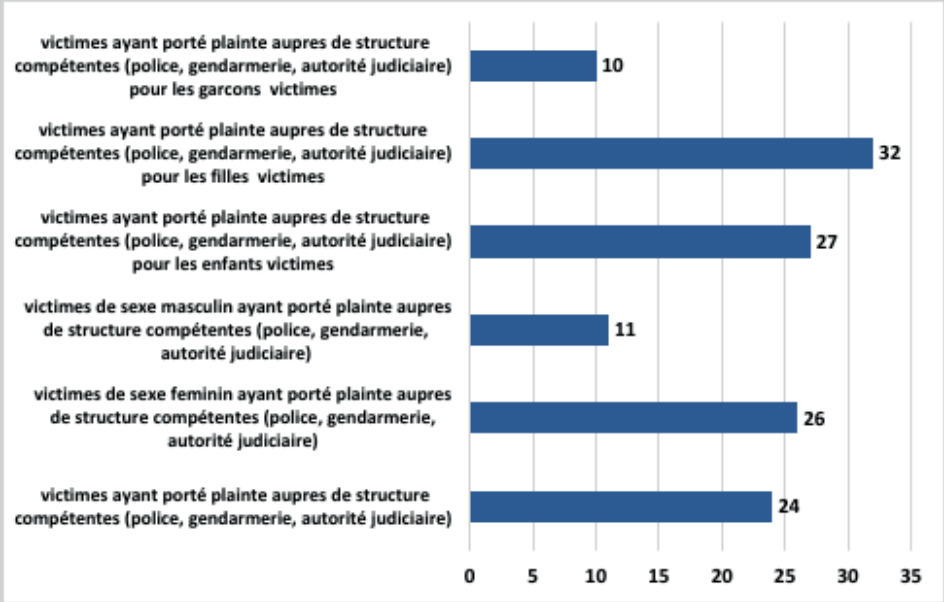
Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces

Cible 16.3. Promouvoir l'état de droit aux niveaux national et international et donner à tous l'accès à la justice dans des conditions d'égalité

Indicateur 16.3.1 : Proportion de victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou à d'autres mécanismes de règlement des différends officiellement reconnus.

Cet indicateur permet de mesurer l'accessibilité au système juridique ou judicaire des personnes survivantes.

Figure 22 : Proportion des victimes ayant porté plaintes



Source : GBVIMS

Indicateur 16.3.2 Proportion de la population carcérale en instance de jugement

L'indicateur utilisé pour mesurer la proportion de la population carcérale en instance de jugement dans le contexte national est le taux de détention préventive. Ce taux est passé de 49,28% en 2015 à 33,79% en 2018 et à 33,01 en 2019., selon le Ministère de la Justice et des droits e l'Homme.

Ces résultats sont dus à la mise en œuvre de mesures clés dans le secteur, entre autres le renforcement de la coordination entre les maisons d'arrêt et de correction et les cabinets d'instruction sur la situation des détenus, la mise en place d'un comité chargé de suivre le respect des délais de détention préventive, la redynamisation de la gestion informatisée des entrées et sorties dans les maisons d'arrêt et de correction et l'organisation des sessions de renforcement des capacités des agents. Ceci a per- mis de réduire sensiblement la proportion de la population carcérale en instance de jugement.

Cible 16.5. Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes

Indicateur 16.5.1 : Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents

Cet indicateur se mesure à partir du nombre de personnes ayant versé un pot de vin. Ainsi, selon l'enquête GPS 2015, 19,16% des personnes visités estiment avoir versé un pot de vin à un agent public en 2015. Selon l'enquête GPS. En 2017, ce sont 16.8% de la population, répartie entre 12.3% d'Hommes et 4.5% de femmes qui ont estimé avoir versé un pot de vin à un agent public.

Indicateur 16.5.2 Proportion d'entreprises ayant eu au moins une fois affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents

Selon l'enquête sur l'état de la corruption à Abidjan (ECA) réalisée en 2015 par l'INS, 18% de chefs d'entreprise dénoncent des pots de vins versés à un agent public en échange d'un service ou d'une faveur.

De façon générale, les évolutions observées au niveau de l'indice de perception de la corruption depuis 2012 témoignent des efforts du Gouvernement en matière de lutte contre la corruption. En effet, la Côte d'Ivoire est passée de la 130ème place sur 176 pays en 2012, à la 107e place sur 168 pays en 2015 puis à la 105e place sur 180 pays en 2018.

Cible 16.6. Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux

Indicateur 16.6.1 : Dépenses publiques primaires en proportion du budget initial approuvé, par secteur (ou par code budgétaire ou autre critère similaire)

Une baisse tendancielle des dépenses de fonctionnement en proportion du budget initial approuvé est observée passant ainsi de 47,39% en 2015 à 40,24% en 2017.

Indicateur 16.6.2 Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été satisfaisante

Selon l'enquête GPS 2015 de l'INS, 12,8% de la population a été satisfaite de la dernière expérience avec les services publics suite à des plaintes relatives à des agressions physiques, 7,1% suite à des plaintes relatives à des cas ou tentative de vols ; 5,1% suite à des faits relatifs à des destructions volontaires de biens, 30% à des cas d'harcèlement sexuel et 42,18% à des cas de viol et tentatives de viol.

Cible 16.9. D'ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances

Indicateur 16.9.1 Proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés par une autorité d'état civil, par âge

Le pourcentage des enfants de moins de 5 ans enregistrés à l'état civil s'accroit depuis 2012. En effet, Il est passé de 65% en 2012 ; à 72% en 2016 et à 75% en 2017. Dans la perspective de renforcer cette dynamique, la Loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil et la Loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance ont été adoptées et promulguées.

Cible 16.10. : Garantir l'accès public à l'information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux

Indicateurs 16.10.2. Nombre de pays qui adoptent et mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles, réglementaires et politiques pour garantir l'accès public à l'information.

Afin de garantir ce droit, le Gouvernement ivoirien s'est doté d'un cadre juridique et institutionnel à travers l'adoption de la Loi n° 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ce cadre, l'ensemble des parties prenantes ont participé à des activités de vulgarisation de la loi et ont été formées sur les dispositifs légaux et réglementaires relatifs à l'accès à l'information. Ainsi, 271 responsables de l'information chargés de recevoir, de traiter et de répondre aux demandes des usagers ont été désignés et formés. Entre 2016 et 2018, la CAIDP a reçu 243 saisines dont 17 clôturées suivies de décisions et 226 réglées par la médiation.

Les efforts du gouvernement ont consisté en la mise en place d'une stratégie dite « de gouvernement ouvert », avec l'instauration d'un certain nombre de plateformes d'accès à l'information (data.gouv.ci, http:/eadministration.gouv.ci, …). En ce qui concerne la proportion de réponses données par le gouvernement aux demandes formelles d'informations ou de documents chaque année, l'examen des rap- ports d'activités produits par les organismes publics ont fait apparaitre que ceux-ci ont reçu en 2018, 25 553 demandes contre 8.820 en 2017.

Chapitre III : PERSONNES VULNERABLES, LAISSEES POUR COMPTE ET LE GENRE A TRAVERS LES ODD

Ce chapitre porte sur une analyse situationnelle du genre et des personnes vulnérables, dans la mise en œuvre des ODD. Il comporte trois sections portant sur la définition des concepts VBG et de Vulnérabilités, l'analyse situationnelle du genre, et la cartographie des personnes vulnérables.

4.1. CONCEPTS DE VBG

Selon la définition des Nations Unis qui est standard, « la violence basée sur le genre est un terme générique pour tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu'un, et qui est basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes ». C'est-à-dire :

- **Viol :** pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même superficielle), à l'aide du pénis ou d'une autre partie du corps. S'applique également à l'insertion d'un objet dans le vagin ou l'anus.
- **Mutilations Génitales Féminines (MGF) / Excision :** Ablation des organes génitaux externes d'une fille pour des raisons non-médicales.
- **Agression physique (AP) :** Violence physique n'étant pas de nature sexuelle. Entre autres exemples : coups, gifles, strangulation, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usage d'armes, quelles qu'elles soient, attaques à l'acide ou tout autre acte occasionnant des douleurs, une gêne ou des blessures. Ce type d'incident n'englobe pas les MGF/E.
- **Mariage forcé (MAF) :** Mariage d'une personne contre sa volonté.
- **Déni de ressources, d'opportunités ou de services (DROS) :** déni de l'accès légitime à des ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des services éducatifs, sanitaires ou autres services sociaux. On parle de déni de ressources, d'opportunités et de services, par exemple, lorsqu'on empêche une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus d'une personne sont confisqués de force par son compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu'une femme se voit interdire l'usage des moyens de contraception, lorsqu'on empêche une fille d'aller à l'école, etc. Les cas de pauvreté générale ne devraient pas être consignés.
- **Violences psychologiques / émotionnelles :** Infliction de douleurs ou de blessures mentales ou émotionnelles. Entre autres exemples : menaces de violence physique ou sexuelle, intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal, attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de biens précieux, etc.

4.2. ANALYSE SITUATIONNELLE DU GENRE

L'Analyse des données genre, est issue du Système de Gestion des Informations sur les Violences Basées sur le Genre (acronyme anglais GBVIMS), créé par des agences des nations unies à savoir l'UNFPA, et le HCR rejoints par UNICEF et l'OMS, et l'ONG international (IRC) avec pour objectif d'harmoniser les données collectées sur les VBG dans un contexte humanitaire. La base est alimentée par un réseau d'organisation productrice de données, issues du gouvernement, du Système des nations unies, des ONG nationales et internationales, et constitué de plusieurs Plateformes VBG (PVBG) ins- tallés dans les différents districts et régions, avec un total de de 58 PVBG.

Les statistiques porteront sur les personnes survivantes aux différentes VBG et sur leurs auteurs. Elles seront relatives a :

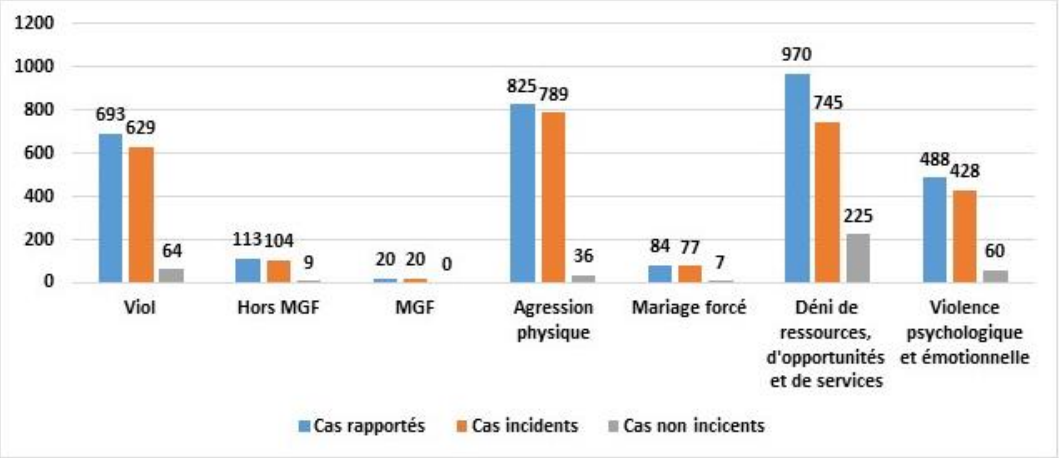
- La classification des VBG selon leurs typologies ;
- La catégorisation des différents VBG ;
- Le profil des différents survivants des VBG ;
- La répartition selon l'âge et spatiale du phénomène.

Les dénis de ressources d'opportunité et de services, Les agressions physiques et le viol, restent les types d'agressions les plus important en Côte d'Ivoire, en 2019. Ils représentent 30. %, 25.8% et 21.7% des VBG perpétrés. Les acteurs des prises en charge des VBG ont assistés à 3193 cas de VBG au cours de l'année 2019, contre 2618, cas en 2018. Parmi les cas rapportés, 87,44% sont des cas incidents contre 12,56 % des cas non incidents. Cela prouve que les personnes survivantes se réfèrent de plus en plus aux structures de pris en charge psychosociales.

Ce comportement peut s'expliquer par le nombre des sensibilisations effectuées, la création de plusieurs mécanismes de prévention, le renforcement et la création plateforme multisectorielle de lutte contre les VBG. 0,10 % des cas non incidents concernent les Denis de Ressources, d'Opportunités ou de Services. En effet, ce type de VBG fait très souvent l'objet de gestion communautaire et de règlement à l'amiable. C'est seulement lorsque les autres recours ont échoué que les structures psychosociales sont saisies.

En considération la catégorisation des types de VBG, il ressort que Sur 806 violences sexuelles rapportées, 620 cas sont des violences sexuelles exercées sur des enfants soit un pourcentage de 76,92%. Un regard particulier doit être porté sur le cas des enfants victimes de violences sexuelles.

Graphique 25 ; Catégorisation des types de VBG



Source : GBVIMS_201

Profil des différentes survivantes des VBG

Sur les 2618 cas de VBG rapportés, en 2018, 92,24% des cas de VBG ont été commis sur les personnes de sexe féminin dont 34,98 % sont des filles. En 2019, ce sont 84% de femme, qui ont été concernés par les VBG, soit un peu plus de 8 femmes sur 10 qui ont été victimes.

Les VBG ont touchés 49.4% de la population âgée de moins de 18 ans et 50.6% de la population dont l'âge se situe au-dessus de 18 ans. Parmi, les 3193 cas de VBG rapportés, ce sont 84%. En prenant en compte la répartition spatiale des différents VBG commis, il ressort que le phénomène est plus perpétré en milieu urbain (74.4%) que rural (25.6%). Ce qui nous amène à dire que les VBG restent un phénomène fortement urbain. Parmi les VBG, seule la mutilation génitale reste un phénomène encore rural, avec 95% de cas de mutilation enregistré.

En 2019, sur les 693 cas de viols, 77 % ont été commis sur les enfants, (moins de 18 ans), contre, 71.2% en 2018, avec un effectif de 644 cas de viols. La petite enfance reste une cible qui n'est pas du tout épargnée avec un total de 22 cas de viols en 2019, contre 17 cas en 2018. La présence de ce phénomène au niveau de cette tranche d'âge pourrait s'expliquer par le fait de la sensibilité des enfants.

Les VBG en général reste un phénomène fortement féminisé. On note que 86.4% des victimes sont des femmes. Quant à la mise en place de la personnalité de base, et vu les conséquences du viol sur les enfants, cet état de fait doit interpeller les acteurs à chaque niveau d'intervention (prévention, réponse, plaidoyer) 95% des mutilations génitales féminines sont également pratiquées sur les moins de 18 ans, avec 60% pratiquée sur les filles de 10 à 14 ans.

76% des agressions sexuelles, sont faites sur les moins de 18 ans, avec 98% réalisées sur les filles. Ce qui nous fait dire que les enfants et plus spécifiquement les filles sont plus victimes de violences sexuelles que les adultes. 98.1% des cas de mariage forcé rapportés sont des personnes de sexe féminin avec une prédominance du phénomène dans la tranche d'âge de 15 à moins de 18 ans (44%). Le phénomène du mariage forcé est quasi -inexistant chez la population masculine, hormis le seul cas enregistré dans la tranche d'âge de 18 à 24 ans.

4.3. CARTOGRAPHIE DES PERSONNES VULNERABLES, LAISSEES POUR COMPTE OU A RISQUE D'ETRE LAISSEES POUR COMPTE

4.3.1 Notion de Vulnérabilité

La définition de la vulnérabilité renvoi à la notion de « vulnérable ». Terme emprunté du latin « vulnerabilis » qui se définit, d'une part, comme ce « qui peut être blessé, attaqué, qui offre prise ; d'autre part, comme ce « qui blesse », second sens aujourd'hui peu employé. Généralement certains facteurs sont utilisés comme induisant la vulnérabilité, notamment, la géographie, le handicap, l'origine raciale, la religion, le sexe, l'âge.

Un lien est généralement établi entre les personnes en situation de handicap et la vulnérabilité, En effet, ces individus sont généralement l'objet d'attaque (viols, tuerie, rituels, enlèvement, marginalisation). A titre d'exemple, nous avons le cas des femmes handicapées, qui sont les plus exposées aux violences physiques, et sexuelles, tout comme les enfants. Les personnes atteintes de nanisme peuvent être la cible de rituels et on prête aux albinos des pouvoirs de guérisons, ce qui fait d'eux la cible de viols de rituels.

Selon l'OMS est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est définitivement, ou passagèrement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. En Côte d'Ivoire, la loi **N°98-594 du 10 Novembre 1998**, a permis une classification des personnes en situation de handicap. Ainsi, au titre de ladite loi, sont considérés comme les personnes en situation de handicap, les personnes présentant les caractéristiques suivantes :

- Personne handicapée moteur
- Mal voyant handicapé visuel
- Sourd muet handicapé auditif
- Dépigmentation génétique albinos
- Les bègues

Celui qui réunit plusieurs types de handicap est un cas de polyhandicap. A cette liste, de plus en plus il est ajouté les personnes atteintes de nanisme et les albinos. Les personnes en situation de handicap sont classées en deux grands groupes que sont les handicapés physiques et les handicapés psychiques. En plus de cette catégorisation personnes, nous avons aussi considéré le cas des personnes du troisième âge et les orphelins des deux parents.

4.3.2 Cartographie des personnes laissées pour compte ou à risque d'être laissées pour contre

Le rapport Bilan Commun de Pays (2020) a permis l'identification des personnes laissées pour compte où a risque de l'être à partir du croisement des facteurs de vulnérabilité, notamment la discrimination, la géographie, la vulnérabilité aux chocs, les statuts socio-économiques et la gouvernance, et par le croisement des indicateurs des 17 OOD ont été croisées avec celles de l'Index Universel des Droit de l'Homme (IUDH) et de l'Examen Périodique Universel (EPU) du Haut-Commissariat des Nation Unies pour les Droits de l'Homme (HCNUDH) et d'autres documents en lien avec les vulnérabilités dans la mise en œuvre des ODD. Cela a permis d'identifier six groupes de personnes laissées pour compte ou risques de l'être :

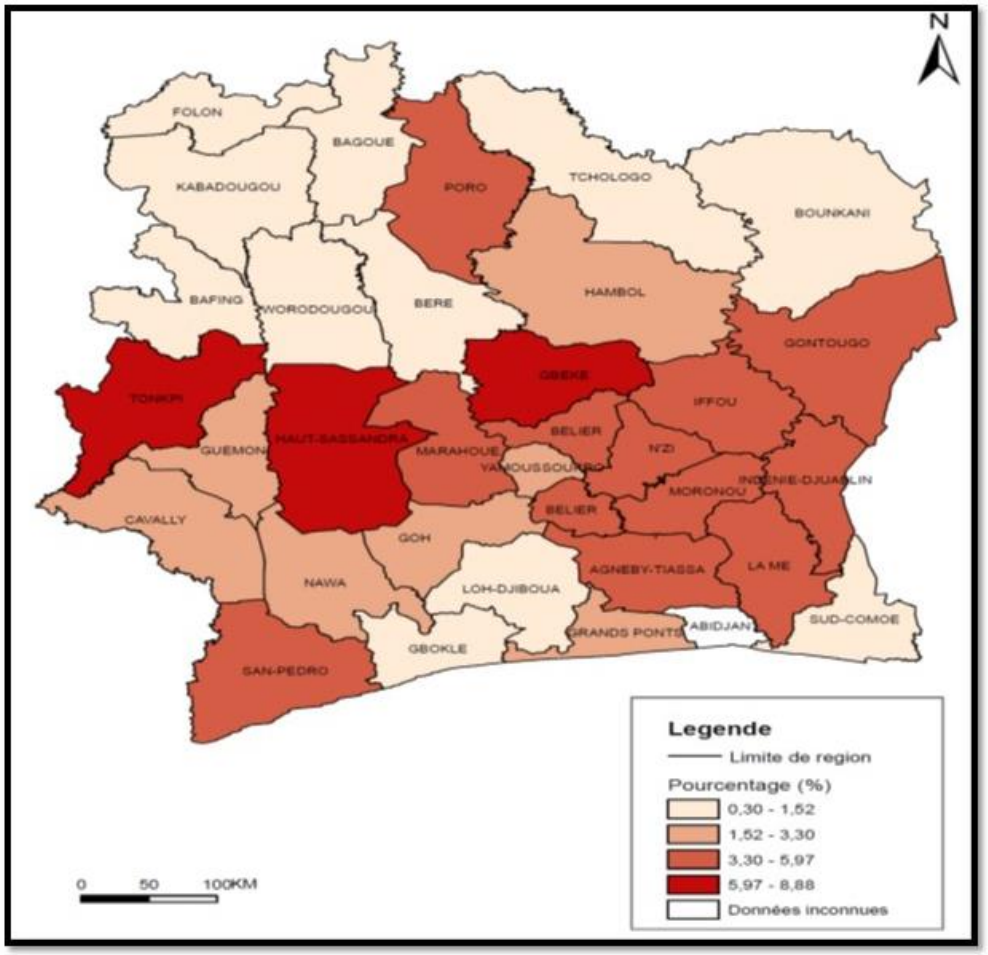
- Les ménages pauvres en milieu rural, notamment des zones les plus pauvres.
- Les jeunes (hommes et femmes) vivant dans la précarité

- Les personnes vivantes avec le VIH
- Les personnes en situation de handicap
- Les migrants et populations à risque d'apatridie.
- Les personnes du troisième âge et les orphelins des deux parents.

4.3.2.1 Les ménages pauvres en milieu rural, notamment des zones les plus pauvres.

En Côte d'ivoire, la pauvreté reste un phénomène rural. En effet, l'incidence de la pauvreté en milieu urbain en 2018 était de, 24,7%, alors qu'en milieu rural, c'est 54,7% des ménages qui sont pauvres, soit un taux du simple au double. Et 85.2% des ménages pauvres sont dirigées par un Homme contre 14.8% dirigés par les femmes. Ces ménages (pauvres) sont plus présents dans le Gbêkê (9%), le Tonpki (8.5%) et confrontés à plusieurs privations (ODD1 à ODD7).

Carte 3 : Répartition des ménages dirigées par les femmes et pauvres en milieu rural



Source : EHCVM

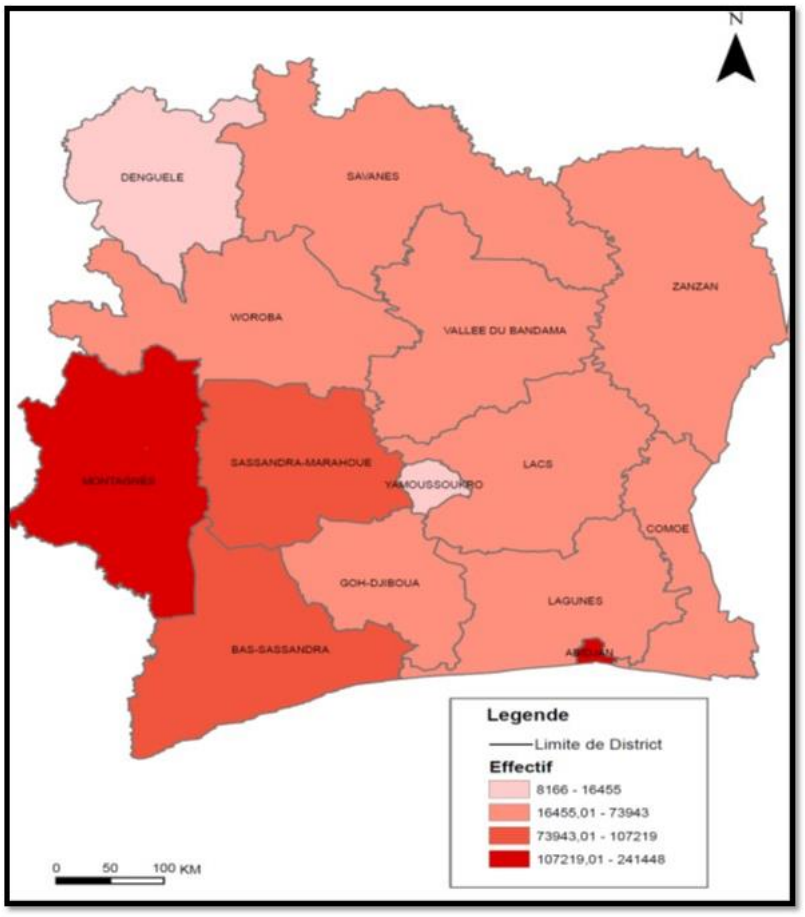
4.3.2.2. Les jeunes (hommes et femmes) vivant dans la précarité.

Le terme de précarité a été pris dans un cadre prenant en compte les personnes Jeune de 15-24 ans ni en emploi, ni en éducation et ni en formation (Neets), comme figurant dans la cible 8.6 « D'ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation », avec pour indicateur ODD8.6.1 : Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non scolarisés et sans emploi, ni formation.

Selon l'Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel ERI-ESI réalisée en 2017, 1 513 884 individus, soit 34,8% parmi les jeunes dans la précarité, ne sont ni en situation d'emploi, ni en formation et sans opportunités socio-économiques viables (ODD 4, 8 et 10), avec une proportion de 44,2% chez les jeunes filles et 25,2% chez les jeunes hommes.

En 2019, selon l'Enquête Nationale sur l'Emploi (ENE), les jeunes ni à l'école, ni en formation, ni en emploi (Neets) sont au nombre de 1 093 790 pour la tranche 15-24 ans, 2 322 383 pour la tranche 15-35 ans et 2 638 379 pour la tranche 15-40 ans. Ces chiffres correspondent respectivement aux proportions de 27,9%, 27,5% et 26,1% au niveau national.

Carte 4 : Répartition des jeunes de 15-24 ans ni en emploi, ni en formation, ni en éducation ni en emploi, par district



Source : Enquête Nationale sur l'Emploi_2019

Tableau 2 : Répartition des NEETS

Caractéristiques sociodémographiques	Jeune de 15-24 ans ni en emploi, ni en éducation et ni en formation (Neets)		Jeune de 15-35 ans ni en emploi, ni en éducation et ni en formation (Neets)		Jeune de 15-40 ans ni en emploi, ni en éducation et ni en formation (Neets)	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Sexe						
Homme	314569	16,7	647267	16,0	748416	15,0
Femme	779221	38,4	1675115	38,2	1889964	36,9
Niveau d'instruction						
Aucun	517618	45,5	1151833	35,8	1344829	33,1
Primaire	270942	35,9	524905	28,8	582820	26,4
Secondaire	278940	15,2	540695	19,1	593645	18,8
Supérieur	26289	13,2	104950	18,8	117084	17,3
Ensemble	**1093790**	**27,9**	**2322383**	**27,5**	**2638379**	**26,1**

Source ENE_2019

4.3.2.3 Les personnes vivant avec le VIH-SIDA

En 2020, ce sont encore 428 827 personnes qui vivent avec le VIH, dont 64,5% de femmes et 7,4% d'enfants de 0 à 14 ans. En 2019, on enregistre 12 187 nouvelles infections à VIH et 12 893 décès liés à l'épidémie. On note par ailleurs une prédominance féminine de l'épidémie observée dès l'adolescence. Il en est de même en ce qui concerne les nouvelles infections où les femmes représentent 59,1% des cas. Aussi, la prévalence du VIH est-elle plus élevée chez les femmes avec 3,32% contre 1,46% chez les hommes (Spectrum 2020). La transmission mère-enfant (TME) du VIH qui est de 10,3% s'observe encore à des niveaux beaucoup trop élevés.

4.3.2.4 Les personnes en situation de Handicap

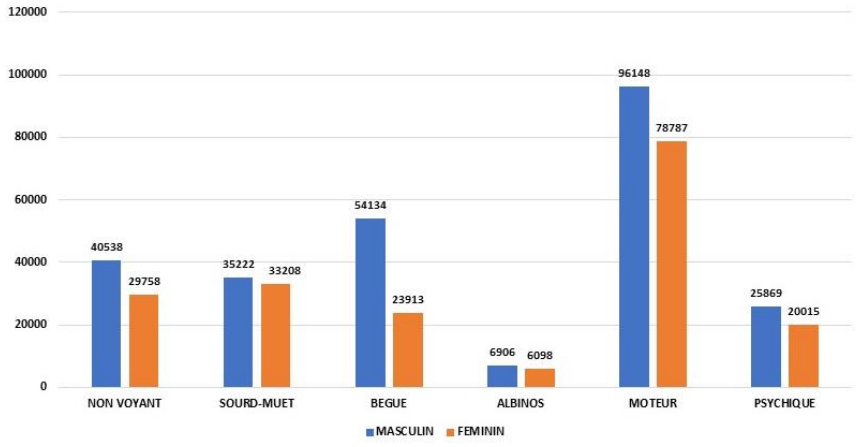
L'indentification et l'analyse des personnes en situation de handicap réalisées dans le cadre de cette étude s'est appuie sur deux sources : Les données issues des recensement (1998 & 2014), et les données de sources administratives, collectées auprès des structures en charge des personnes handicapées, généralement les ONG, et centre de santé publique spécialisés.

4.3.2.4.1 Les données des recensements

En 1998, le RGPH avait estimé à 85 517 personnes, le nombre de ceux qui vivaient avec un handicap [2]. En 2014, soit un peu de 16 ans après, le nombre est passé à 450 000 personnes en situation de handicap, repartie entre 90% d'handicapés physiques et 10% d'handicapés psychiques, contenant 57.4% d'hommes et 42.6% de femmes et environ 70% de ces personnes handicapées qui vivent en milieu rural.

Selon la catégorisation des types d'handicap physique, on a une prédominance des handicaps moteurs (38.8%), soit 174.935 personnes réparties entre 96148 Hommes et 78 787 de femmes, suivi du handicap « Bègue (17.4%). Les non voyant (15.6%) et les sourd-muet (15.2%) ont des taux similaires oscillant autour de 15.6%. Le faible taux est observé chez les Albinos (2.9%). On observe également une part non négligeable des personnes en situation d'handicap psychique, s'élevant à 45 884, répartie entre 25869 Hommes et 20015 femmes.

Graphique 26 : Répartition des personnes handicapés selon le type

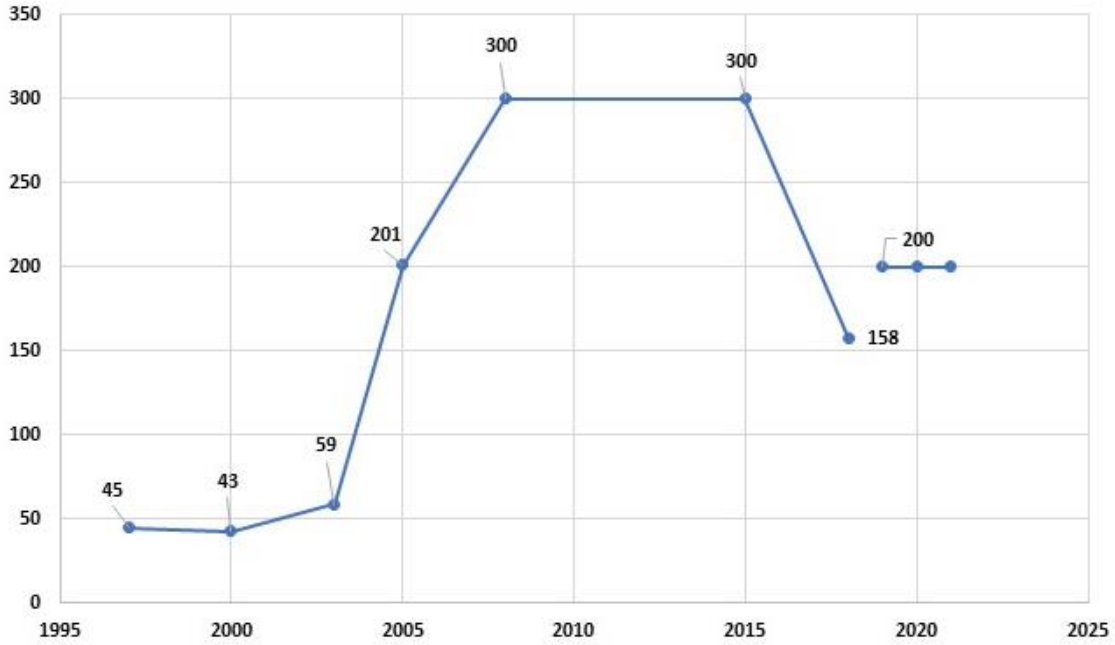


Source : Direction de la Promotion des Personnes Handicapées _RGPH 2014

2 Handicap défini conformément à la loi N°98-594 du 10 Novembre 1998, en faveur des personnes handicapées, prenant en compte le handicap physique, psychique, visuel, auditif, et les infirmités motrices cérébrales.

La Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016 protège les droits des personnes en situation de handicap en ses articles 32 et 33. Au plan international, le pays a ratifié également la Convention aux droits des personnes handicapées. L'insertion des personnes en situation de Handicap a connu une nette progression avant 2015, date à partir de laquelle, on a observé une baisse de moitié de l'effectif en 2018. Depuis 2020, on assiste à une stagnation de l'effectif des recrutés autour de 200 personnes.

Graphique 27 : Evolution des personnes handicapées recrutées à la fonction publique



Source : Direction de la Promotion des Personnes Handicapées.

L'Enquête Harmonisée sur les Conditions Vie des Ménages conduite par l'INS en 2018, nous a permis d'identifier au sein des population, les individus souffrant de certains handicaps, telle la vue, les sourds, les personnes éprouvant des difficultés à accomplir certaines tâches comme se laver et celles ne pouvant prendre les marches de l'escalier. Ainsi sur une population estimée à 21693116 millions d'habitants en 2018, 1.14% soit 247 794 personnes ne peuvent pas du tout voir.

Les hommes en général restent les plus touchés (96 991) contre 11 898 cas chez les femmes. Aussi on remarque que le handicap visuel ne touche pas les enfants de moins de 5 ans. Quant aux individus ne pouvant entendre (Sourde), une faible (0.44%) proportion de la population en souffre. Pour les handicaps Moteurs comme l'incapacité à monter les marches de l'escalier et à accomplir certaines tâches comme se laver, ce sont 0.44% et 0.38% de la population estimée qui en sont touchée. Et pour ces deux types de handicap, les femmes sont les plus touchées que les hommes.

Tableau 3 : Effectif des personnes en situation de Handicap

Type du Handicap	Ne peut pas du tout voir (vue)	Ne peut pas du tout entendre	Ne peut pas du tout monter les escaliers	Ne peut pas du tout accomplir certaines tâches comme se laver
Homme	96 991	29926	25907	24541
Femme	11 898	31662	38517	27800
moins de 5 ans	0	673	673	731
5 à 11ans	8 537	23505	22665	22586
12 à 17 ans	23 286	10736	8721	7051
Total	**247 794**	**96502**	**96483**	**82709**

Source : EHCVM_2018

4.3.2.4.2 Les données de sources administratives : Collecte auprès des structures en charge des personnes en situation de Handicap.

Le ciblage des individus vulnérables et pauvres reste une étape importante dans la mise en place des politiques et mesures idoines à même de juguler les maux des dites populations. Pour identifier les personnes en situation de handicap, une collecte de données auprès des structures étatiques et des ONG accueillant les personnes vulnérables a été réalisées. Il s'agit :

- La Direction des personnes Handicapées
- La Page Blanche ;
- Le Centre Psychiatrique de Bingerville ;
- Le Centre Don Orion de Bonoua ;
- L'Institut des Aveugles de Yopougon ;
- L'Institut D'hygiène Publique (INSP) ;
- L'Union des Organisations des Parents des Personnes en Situation de Handicap de Côte d'Ivoire (UNOPAHCI).

4.3.2.4.2.1 Structure de prise en charge des handicapés : Le Centre Don Orione de Bonoua

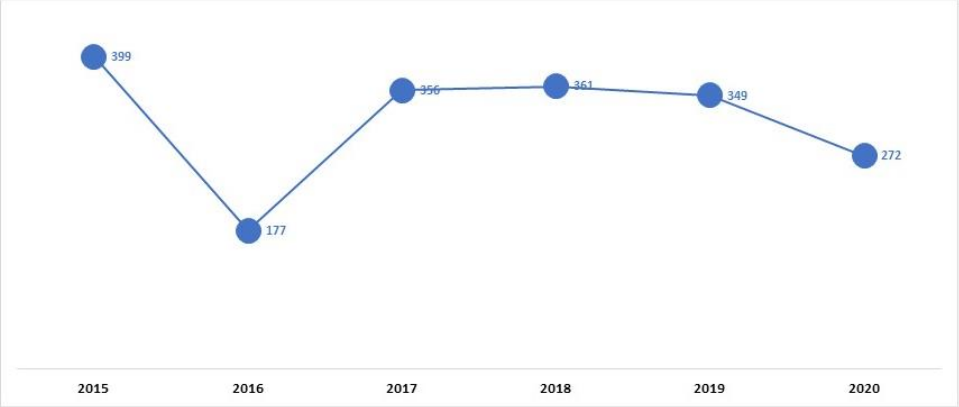
Le centre Don Orione de Bonoua est une structure à but non lucratif créé à l'origine pour la prise en charge médicale des handicapés moteurs, qui a étendu ses activités dans le domaine médicales, disposant en son sein des services de la chirurgie orthopédique, et ophtalmologie, en plus des services de radiologie, cardiologie, de neurologie, de gynécologie, d'ORL. Le centre prend en charges de nouvelles affections de l'appareil locomoteur, des cas d'infirmités cérébrales.

Ce centre, du fait des coûts sociaux et des prises en charges octroyés en matière de santé reste une cible privilégiée pour des personnes généralement démunies, les personnes pauvres et ceux en situation de Handicap. Bien qu'étant un centre à vocation social, il convient toutefois de préciser que les soins ne sont pas gratuits ; la contribution financière des patients s'élève à hauteur de 60%. Le reste étant supporté par le Centre, (20%) et des ONG (20%).

Ainsi, de 2015 à 2020, 1914 personnes marginalisées et pauvres, réparties entre 1059 hommes et 855 femmes ont été enregistrées dans le centre. Ce qui fait que le centre reste fortement fréquenté par les hommes (55.5%) que les femmes (45.5%) sur la période sous revue. Depuis,

2019, on observe une tendance baissière de la fréquentation, passant de 349 à 272 personnes en 2020, soit une chute de 22% des effectifs.

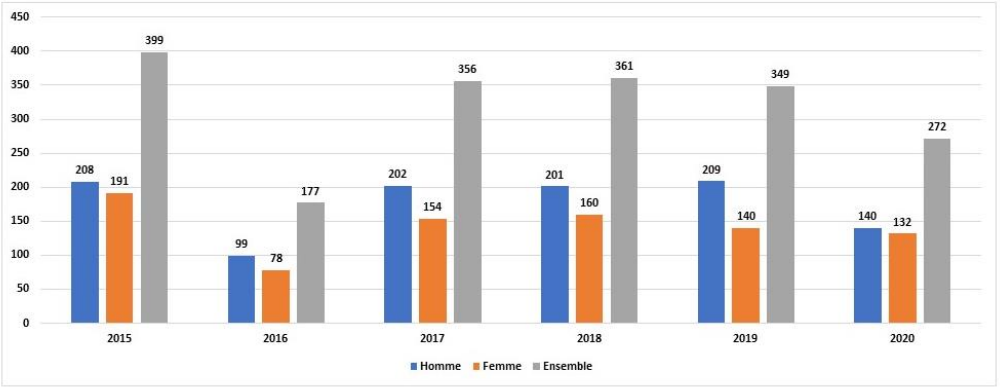
Graphique 28 : Evolution des personnes marginalisées et pauvres prises en charges



Source : Centre Don Orione.

Lorsqu'on considère les personnes en situation de handicap, ce sont 14058 individus qui ont visité le centre, sur la période 2015 à 2020, soit un effectif annuel autour de 2343 personnes, répartie entre 62.2% de femmes et 37.8% d'hommes. Ce qui fait cas d'une prédominance féminine d'en matière d'accès au centre.

Graphique 29 : Evolution des marginalisées et prise en charge selon le sexe



Source : Centre Don Orione.

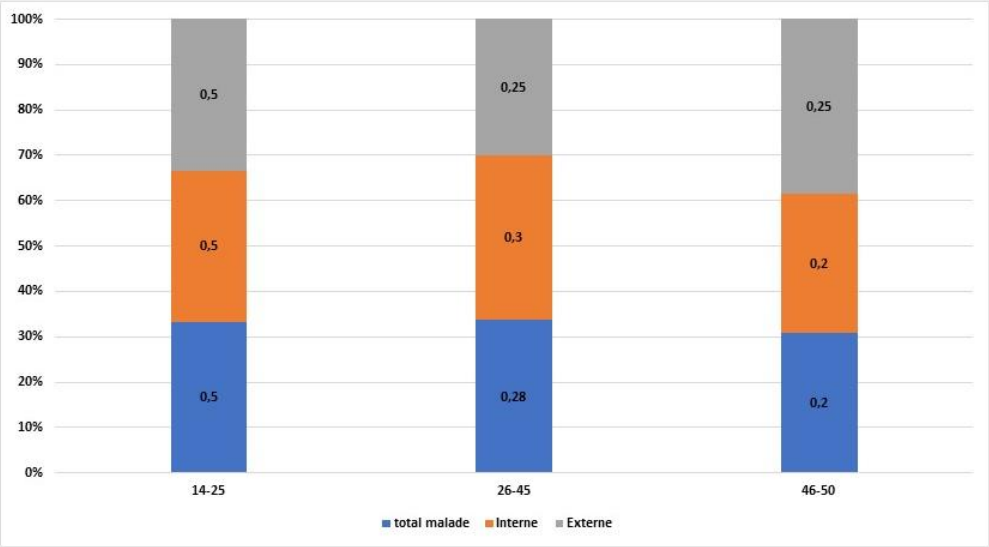
4.3.2.4.2.2 Centre Psychiatrique de Bingerville et Institut National de Santé Publique (INSP)

L'identification des personnes atteintes de troubles Psychiatriques psychologiques a été réalisée grâce à la collecte des données réalisées auprès des centres Psychiatriques de Bingerville et de l'INSP. La Côte d'Ivoire, fait des efforts pour la prise en charge des personnes vulnérables atteintes de démence ou « folie » ou des malades souffrant de troubles Psychiatriques. Il existe deux grands centres :

- Hôpital psychiatrique de Bingerville (hôpital public pour adultes), à Abidjan
- L'Institut National de Santé Publique (INSP) (Le centre de guidance infantile d'Adjamé, et le Service d'Hygiène mentale pour adultes).

L'Hôpital Psychiatrique de Bingerville reste l'un des centres les plus importants et spécialisé dans le traitement des troubles psychiatriques et psychologiques. Ce centre propose les prestations de soins suivantes : Consultations psychiatriques, Hospitalisations psychiatriques stationnaires, Thérapie comportementale et cognitive, Psychothérapie institutionnelle, Art-thérapie, Service social, éducatrices spécialisées et psychologues vacataires. L'hôpital psychiatrique dispose d'un personnel de 123 membres dont 14 médecins à savoir 07 spécialistes et 07 généraux. Il est équipé de 100 lits, d'une cantine et de douches. La capacité d'accueil de ce centre est de 1200 personnes internes, et 960 personnes externes.

Graphique 30 : Pourcentage total des malades selon l'âge et le site de traitement

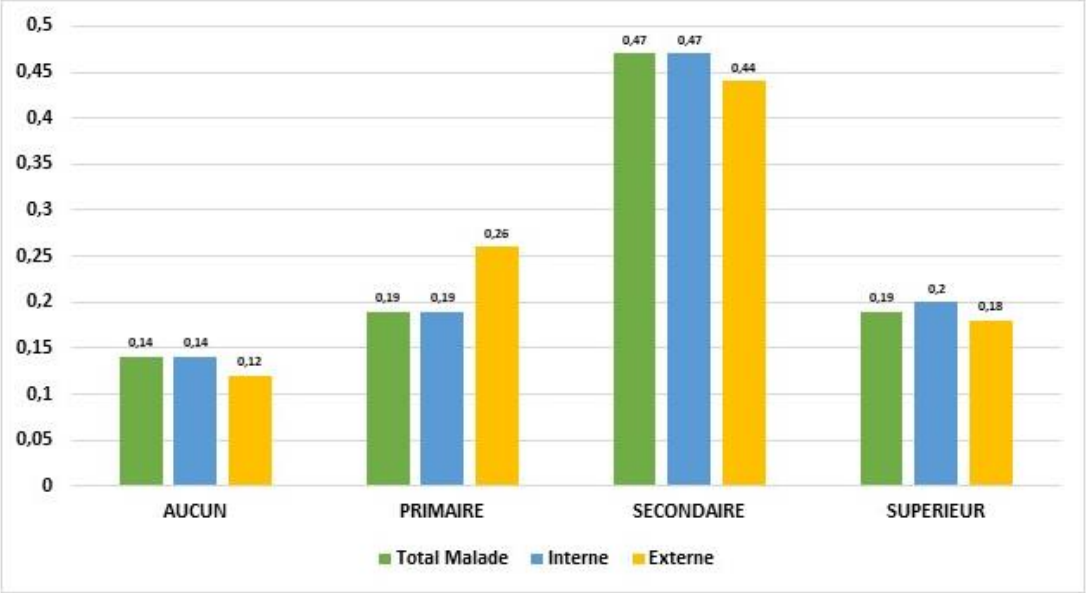


Source : Nos calculs avec les données du Centre Psychiatriques de Bingerville

L'effectif annuel des personnes atteintes de troubles psychiatriques consultées dans le Centre de Bingerville est de 2160 personnes, répartie entre 55% de femmes contre 45% d'hommes. La gent féminine reste donc la plus touchée, même si la proportion des hommes n'est toutefois pas aussi négligeable. L'âge moyen des malades varie entre 14 et 50 ans, avec une prédominance de cas (50%) chez les adolescents de 14 à 25 ans, une proportion un peu plus faible (28%) chez les 26 à 45 ans et de (22%) chez les 46 à 50 ans.

Etant donné la faible capacitée d'accueil du centre, deux types d'hospitalisation sont faites à savoir les malades traités en interne qui représentent 55% des effectifs et les malades non hospitalisés, 960. Soit 45%, qui suivent leur traitement en dehors du centre. Aussi, que ce soit en interne comme en externe, on remarque que la proportion des personnes les plus touchés reste toujours les adolescents, qui font la moitié des effectifs.

Graphique 31 : Pourcentage total de malades selon le niveau d'instruction et le site de traitement



Source : Nos calculs avec les données du Centre Psychiatriques de Bingerville

La grande majorité, soit 85% des personnes atteintes de troubles mentales sont des personnes instruites, avec des niveaux d'éducation allant du primaire (19%), secondaire (47%) et le supérieur (19%). En interne (47%) comme en externe (44%). La proportion des malades psychiatriques sans niveau d'instruction reste très faible, et se situe à moins d'un quart (0.13%).

La durée de traitement est de trois mois, et on a enregistré une croissance fixe de 30 personnes guéries mensuellement de 2015 à 2020. Le coût de la prise en charge est de 25000, par personne, par mois, les malades ne bénéficient malheureusement pas de services de formation adapter pour leur réinsertion. La prise en charge des malades se fait à travers plusieurs moyens. C'est dans cette optique que l'on a :

- 30% qui sont pris en charge par l'Etat
- 50% qui sont pris en charge par leurs familles respectives
- 20% qui sont pris en charge par des structures (ONG, Ambassade …)

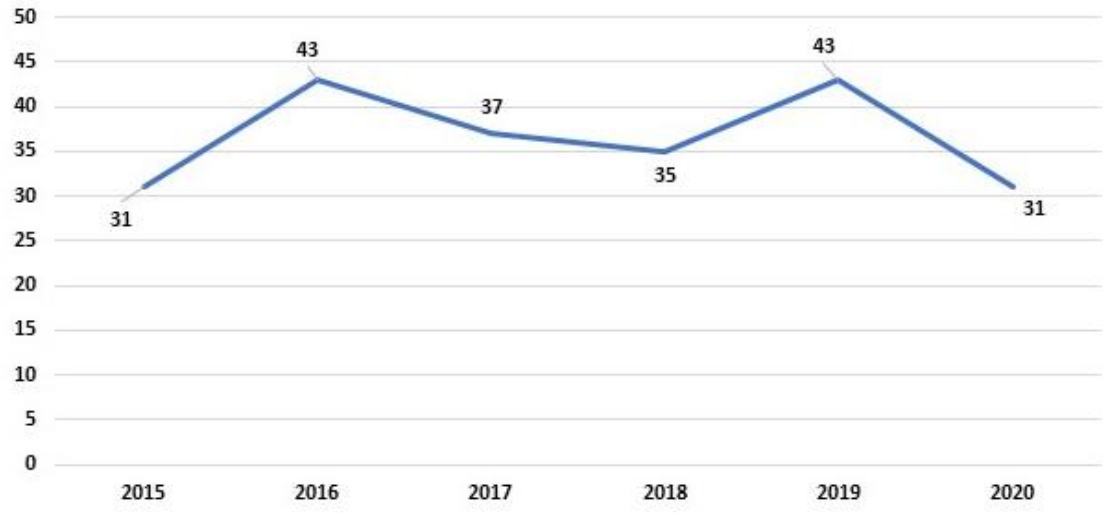
Notons que le coût de la prise en charge est de 25000, par personne, par mois, les malades ne bénéficient malheureusement pas de services de formation adapter pour leur réinsertion. L'analyse des caractéristiques socio-démographiques des personnes atteintes de troubles psychiatriques enregistrés dans le centre de Bingerville, chaque année est de 2160.

4.3.2.4.2.3 Collecte de données à la page Blanche

La Page Blanche a été créée en 1991 par l'Areea. Elle s'occupe de la prise en charge des enfants handicapés ou polyhandicapés intellectuels (autistes-Imc «infirme moteur cérébral») et trisomiques ainsi que des enfants souffrant de troubles du langage et du comportement, et des pensionnaires épileptiques. Généralement l'âge des pensionnaires varie de 5 à 14 ans et sont plus concentré sur le handicap psychique Depuis la création de l'association, 1200 enfants ont été encadrés.

En 2021 la Page Blanche compte un effectif de 35 enfants. Elle vie de dons et de cotisations des parents des pensionnaires. En comparant l'effectif des enfants en situation d'handicap psychiques scolarisés, il ressort que les plus faibles effectifs (31 élèves) ont été enregistrés en 2015 et 2020. En 2016 et 2019, on a enregistré les plus grands effectifs, avoisinant 43 élèves.

Graphique 32 : Effectifs des enfants (0-14 ans) handicapés psychique scolarisés



Source : Page Blanche

4.3.2.4.2.4 Situation d'Education des personnes en situation du Handicap : Cas de l'Institut National Ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA).

La collecte de donnée réalisée à l'INIPA a permis d'identifier pour l'année 2018/2019, 140 élèves, répartie entre 54 élèves pour le primaire avec, 28 filles et 26 garçons et 86 pour le secondaire avec toujours une prédominance masculine (49) d'apprenants. Hormis, ces élèves qui ont fréquenté l'INIPA durant l'année 2018/2019, certains ont fréquenté les établissements classiques.

Tableau 4 : Répartition des élevés aveugles par établissements externes

ETABLISSEMENTS	EFFECTIFS		TOTAL
	F	G	
LYCEE PIERRE GADIE (L.M.P.G)	2	13	12
LYCEE ANDOKOI (L.M.Y.A)	13	11	24
GROUPE SCOLAIRE NEWTON	21	21	42
COLLEGE AMITIE (G.S.I.A)	0	3	3
I.M.G.H	0	1	1
TOTAL	**36/37**	**49**	**85/86**

Source : INIPA_2018/2019

4.3.2.4.2.5 Représentativité des apprenants en situation de handicap dans la Formation Professionnelle.

Selon les statistiques du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, pour ce qui est d l'année 2019-2020, ce sont 117 apprenants en situation de handicap répartie entre 49 femmes et 68 hommes qui ont été formés, dans les différents établissements de formation professionnelles à savoir 87 apprenants pour le public et 49 du privé.

Tableau 4 : Effectif des apprenants en situation de handicap de la FP :

DRFP	PRIVE		TOTAL	PUBLIC		TOTAL	ENSEMBLE
	F	M		F	M		
ABENGOUROU					5	5	5
ABIDJAN NORD	2	6	8	2	12	14	22
ABIDJAN SUD	1	3	4	5	14	19	23
BONDOUKOU	1	2	3				3
BOUAKE	4		4	22	3	25	29
DABOU	3		3				3
DALOA				1	5	6	6
DIMBOKRO					3	3	3
GAGNOA	1		1	2	8	10	11
KORHOGO					1	1	1
MAN	2	1	3		1	1	4
ODIENNE	1		1		2	2	3
SAN PEDRO	2	1	3				3
SEGUELA					1	1	1
ENSEMBLE	**17**	**13**	**30**	**32**	**55**	**87**	**117**

Source : DPS / Enquête Statistique 2019-2020.

Tableau 5 : Effectif des apprenants en situation de handicap par sexe, et diplômes préparés

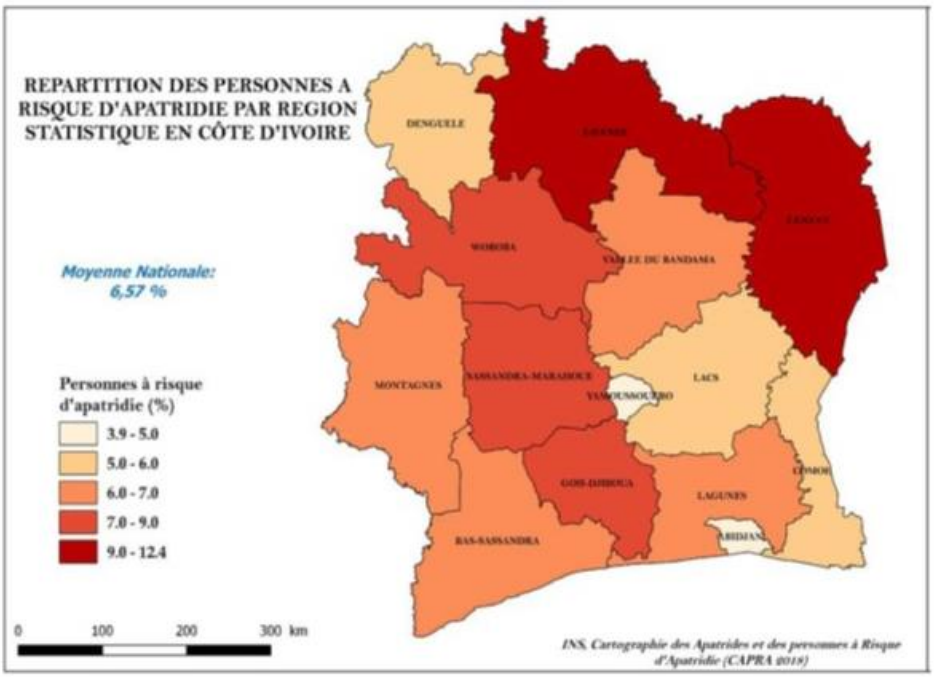
DIPLÔME /SEXE	HANDICAP MOTEUR	HANDICAP SENSORIEL	AUTRES TYPES	ENSEMBLE
BTS	32	28	4	64
F	12	11	1	24
M	20	17	3	36
CAP	19	24	3	46
F	9	13	1	23
M	10	11	2	23
CERTIFICAT	1	2	2	5
F	1	1		2
M		1	2	3
PREPA CAP	1	1		2
M	1	1		2
ENSEMBLE	**53**	**55**	**9**	**117**

Source : DPS / Enquête Statistique 2019-2020.

4.3.2.5 Les populations à risque d'apatridie.

Apatride : désigne selon l'article 1er de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ou individu dont la nationalité n'est pas déterminée. Personne à risque d'apatridie : une personne qui est dans l'impossibilité de réunir les documents ou conditions nécessaires pour se voir attester ou attribuer une nationalité. Autrement dit cette personne est dans l'impossibilité d'établir la preuve d'une nationalité. Pour bien mesure le phénomène, une étude a été réalisé en 2019 avec le concours l'UNHCR pour la cartographie des personnes à risques d'apatridie. Il ressort de cette étude que la prévalence, que la prévalence du risque d'apatridie est de 6.57 % des personnes vivant sur le territoire ivoirien, soit une estimation de 1 656 330 personnes à risque d'apatridie. La carte suivante présente la distribution spatiale par district de la prévalence du risque d'apatridie. Il ressort de l'observation de cette carte que les districts des Savanes et du Zanzan sont ceux dans lesquels le risque d'apatridie est le plus élevé avec des valeurs qui varient entre 9% et 12.4%. Ces valeurs atteignent environ le double de la moyenne nationale (6.57%). Les Districts d'Abidjan et de Yamoussoukro sont les zones dans lesquelles la pré- valence du risque d'apatridie (3.9 % et 5 %) est moins élevée.

Carte 5 : Distribution spatiale de la prévalence de l'apatridie



Source : INS

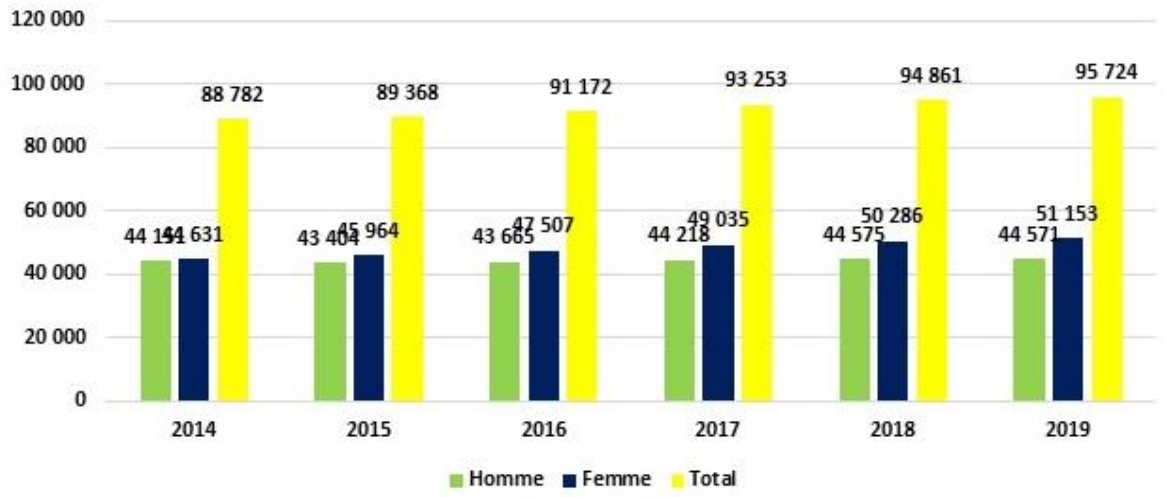
4.3.2.6 Les populations du troisième ou quatrième âge

Les « personnes âgées», d'après le dictionnaire démographique multilingue, constituent l'ensemble des hommes et femmes qui ont atteint ou dépassé l'âge de 60 ans. Cette frange de la population se subdivise en deux grands groupes. Le premier groupe, appelé « personnes de troisième âge », se compose des personnes qui ont un âge compris entre 60 et 74 ans révolus. Le second groupe compte l'ensemble des personnes dont l'âge est au moins égal à 75 ans et se nomme « personnes de quatrième âge».

4.3.2.6.1 Evolution de la population de la tranche d'âge de 74 à 79 ans de 2014 à 2019

On remarque une légère croissance de la population totale de cette tranche d'âge, de 88782 en 2014, on a 95724 en 2019. Les hommes sont moins nombreux que les femmes, durant les années d'étude, on remarque une augmentation des différents effectifs.

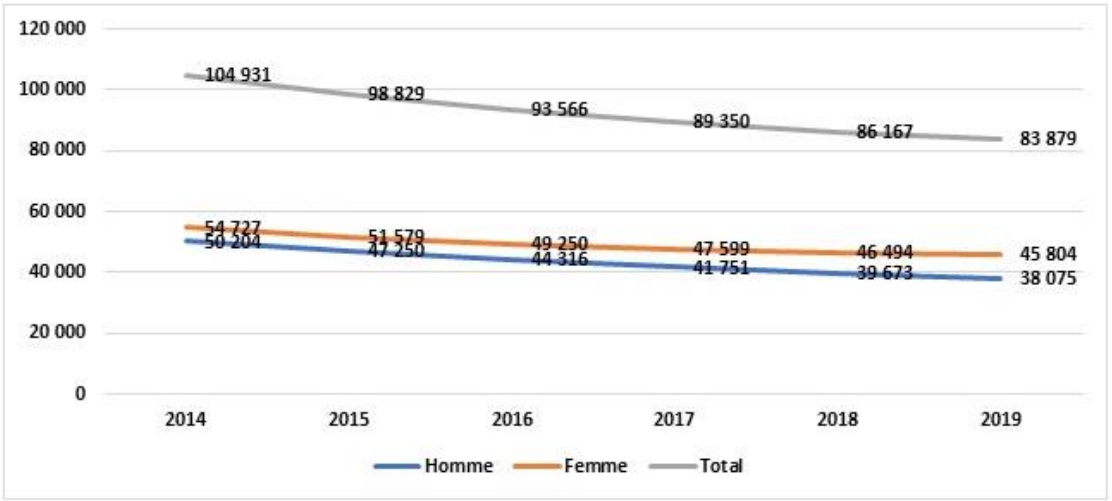
Graphique 33 : Répartition des effectifs des personnes du 3ème âge selon le sexe



4.3.6.2. Evolution de la population de plus 80 ans de 2014 à 2019

De façon générale, nous assistons à une baisse de cette population, de 104931 en 2014, nous avons 83879 en 2019, soit une baisse de 79,9%. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur toutes les années de l'étude, en 2019, la population féminine était de 45804 contre 38075 pour la population masculine. Mais, nous remarquons que les deux nombres sont en baisse au fur et à mesure des années. Les femmes sont passées de 54727 individus en 2014 à 45804 en 2019 et les hommes de 50204 personnes à 38075 en 2019.

Figure 39 : Population du quatrième âge selon le genre de 2014 à 2019



4.4. POPULATIONS CLES

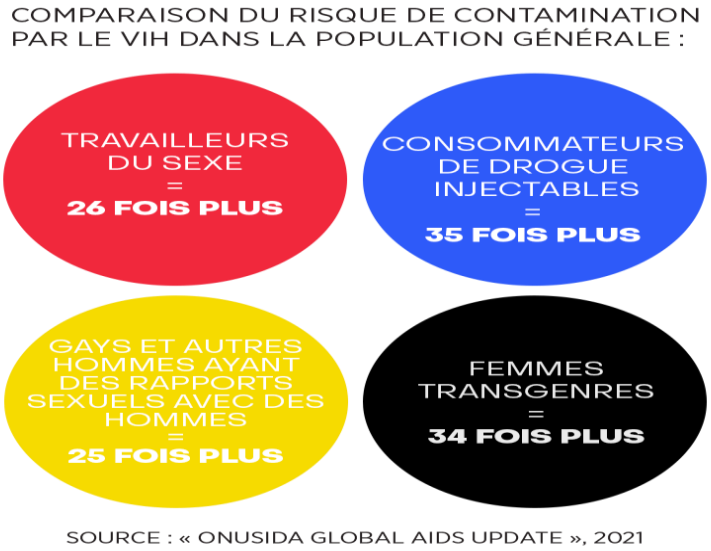
4.4.1. Définition de la notion de populations clés

L'expression “populations clés” désigne les populations les plus exposées au VIH/sida. Il s'agit de groupes de populations qui présentent les plus hauts taux de prévalence d'une population donnée, qui sont généralement marginalisés socialement et qui représentent les cibles prioritaires des programmes de lutte contre le VIH/sida.

Selon l’ONUSIDA et l’Etat de Côte d’Ivoire, les cinq (05) principaux groupes de populations clés qui sont particulièrement vulnérables au VIH et qui n’ont souvent pas accès à des services adéquats sont les :

- Hommes ayant des rapports Sexuels avec d’autres Hommes (HSH),
- Professionnel(le)s du Sexe (PS) ou Travailleuses du Sexe (TS),
- Personnes transgenres ou (TG),
- Consommateurs de drogues (CD) ou Usagers de drogues (UD),
- Détenus ainsi que les personnes incarcérées

Le schéma ci-dessous donne une illustration de leur qualité de populations clés.



A l’instar des autres cibles comme les Détenus y compris les personnes incarcérées, les utilisateurs de drogues (UD), les travailleuses du sexe (TS), les interventions de lutte contre le VIH/sida existent en direction des personnes transgenres et HSH en Côte d’Ivoire. Ces deux (2) cibles prioritaires dans les interventions VIH, se retrouvent dans le sigle « LGBT » qui signifie **L**esbian **G**ay **B**isexuel et **Tr**ansgenre. Ainsi dans ce sigle les données programmatiques sont axées plus sur les Gays/HSH et les Transgenres (TG).

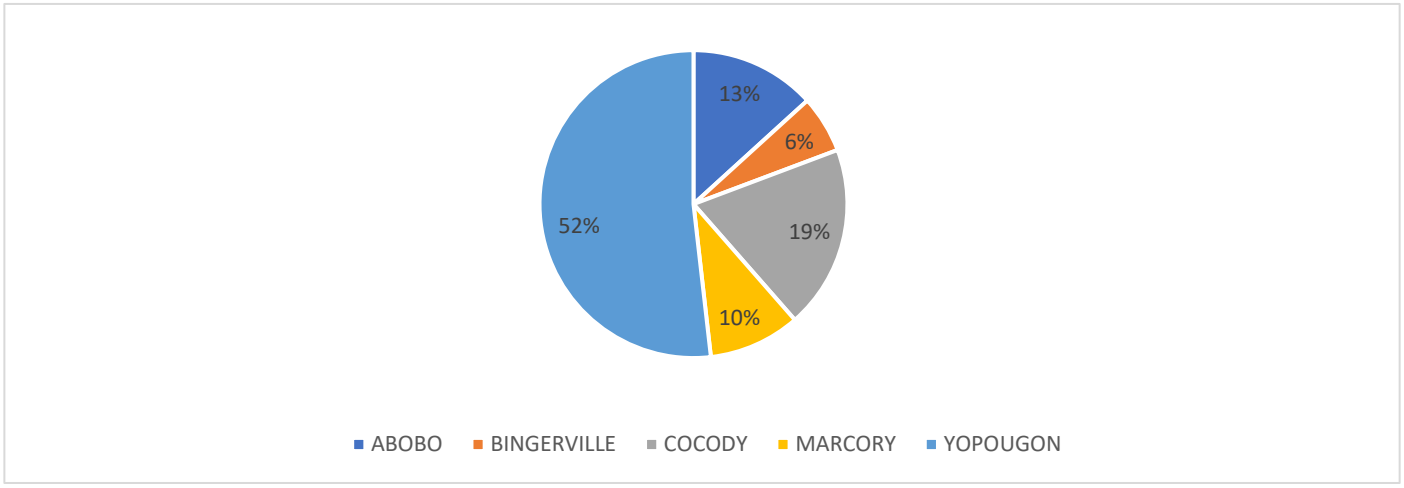
Les interventions ont démarré avec la cartographie des sites de rencontre et lieux de socialisation des personnes Transgenres (TG) dans 06 communes d’Abidjan et 24 districts sanitaires de l’intérieur du pays ; Et la cartographie programmatique en direction des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) à Abidjan.

4.4.2. Cartographie des sites de rencontre et lieux de socialisation des personnes Transgenres (TG)

Dans l'option une meilleure prise en charge des Transgenres, il a été commandité des études de cartographies des sites de rencontre et de socialisation desdites cibles. Ainsi, dans six (06) communes de la ville d'Abidjan, avec les financements de USAID/PEPFAR, via FHI 360 et à l'intérieur du pays, dans 23 districts sanitaires couverts par Heartland Côte d'Ivoire. Cette cartographie de sites de rencontre et de lieux de socialisation des personnes Transgenres (TG) s'est faite avec l'appui financier du Fonds Mondial par le truchement de Alliance Côte d'Ivoire et l'appui technique de l'Ong ENDA Santé.

Respectivement, **à Abidjan**, ce sont **83 sites TG confirmés**. **52% de ces sites sont situés à Yopougon**, commune la plus grande et plus ''chaude'' d'Abidjan. Ce sont surtout des **petits commerces tenus par des paires (38%)**, des **espaces chauds (35%)** mais également des **domiciles privés (11%)** ou des **sites associatifs (10%)** comme les sièges d'ONG ou des Drops In centers (DIC).

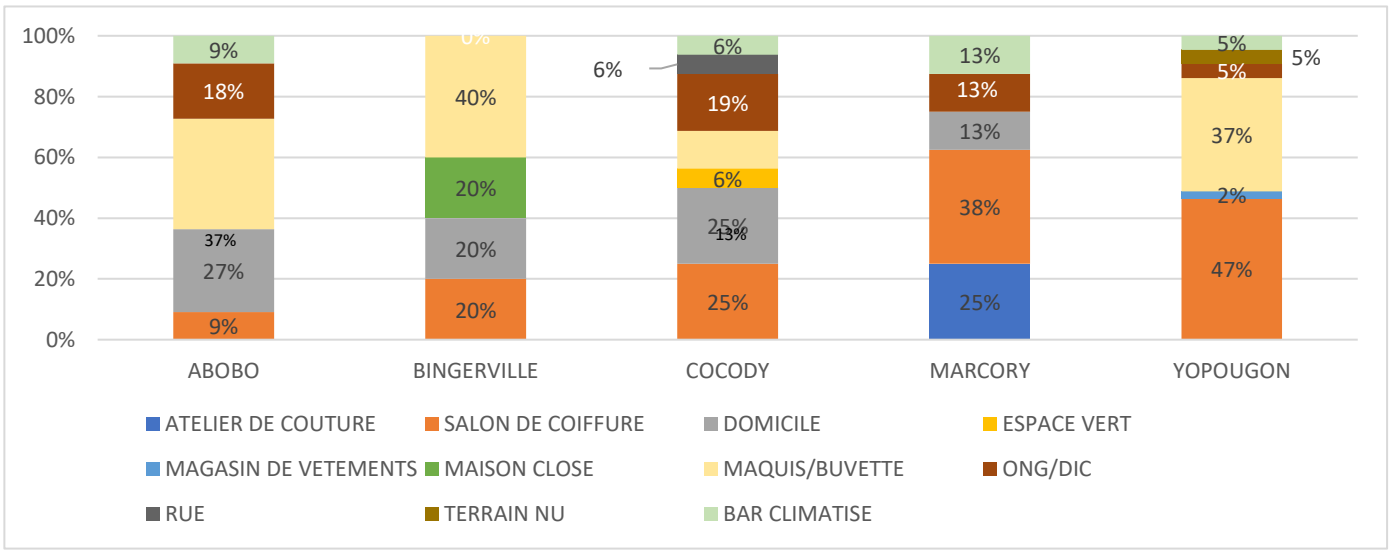
Figure 40 : Cartographie des sites de rencontres



Source : l'Ong ENDA Santé

Ces sites ont été classifiés selon une typologie contextuelle et déjà utilisée dans les cartographies antérieures : **Espaces publics ouverts** (Rue/Gare/Marché), **Petits commerces** (salon de coiffure, cyber café etc.), **Points chauds** (maquis, bars climatisés, restaurants), **Sites prostitutionnels** (maisons closes, hôtels, loge et cabaret) et les **Résidence privées ou domiciles privés**.

Figure 41 : Cartographie des sites de rencontres selon les communes

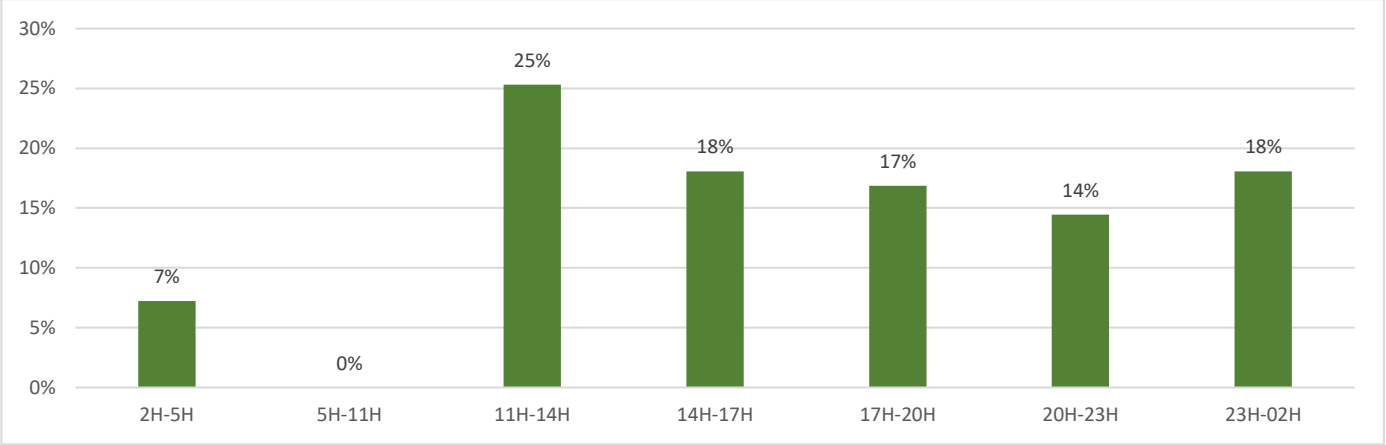


Source : l'Ong ENDA Santé

Les liens entre TG et autres populations clés semblent forts. En effet, en plus des TG on rencontre sur ces sites des **HSH (dans 98% des sites)**, des **TS (69%)** et des **UD (49%)**.

Figure 42 : Fréquentation horaires des sites de rencontres

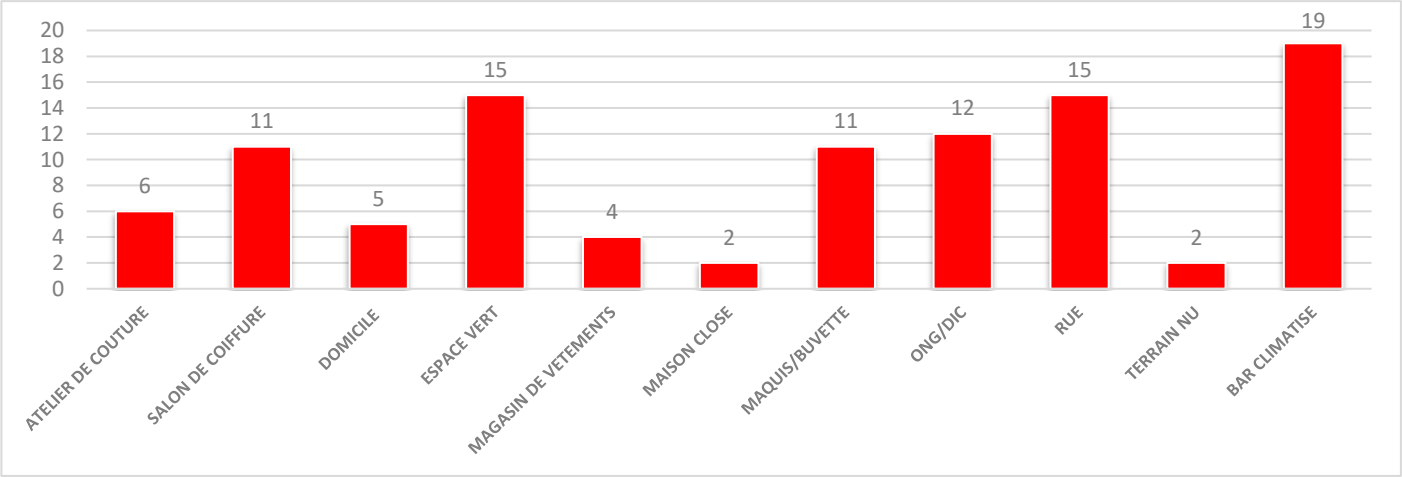
Les sites sont globalement plus fréquentés les **vendredis (18%)** et **samedis (48%)** entre **11H et 14H (25% des sites)**.



l'Ong ENDA Santé

Ces horaires d'affluence sont en lien direct avec la typologie des sites et **l'effectif moyen aux moments d'affluence varie entre 2 et 19**.

Figure 43 : Cartographie des sites de rencontres selon lieu



Source : l'Ong ENDA Santé

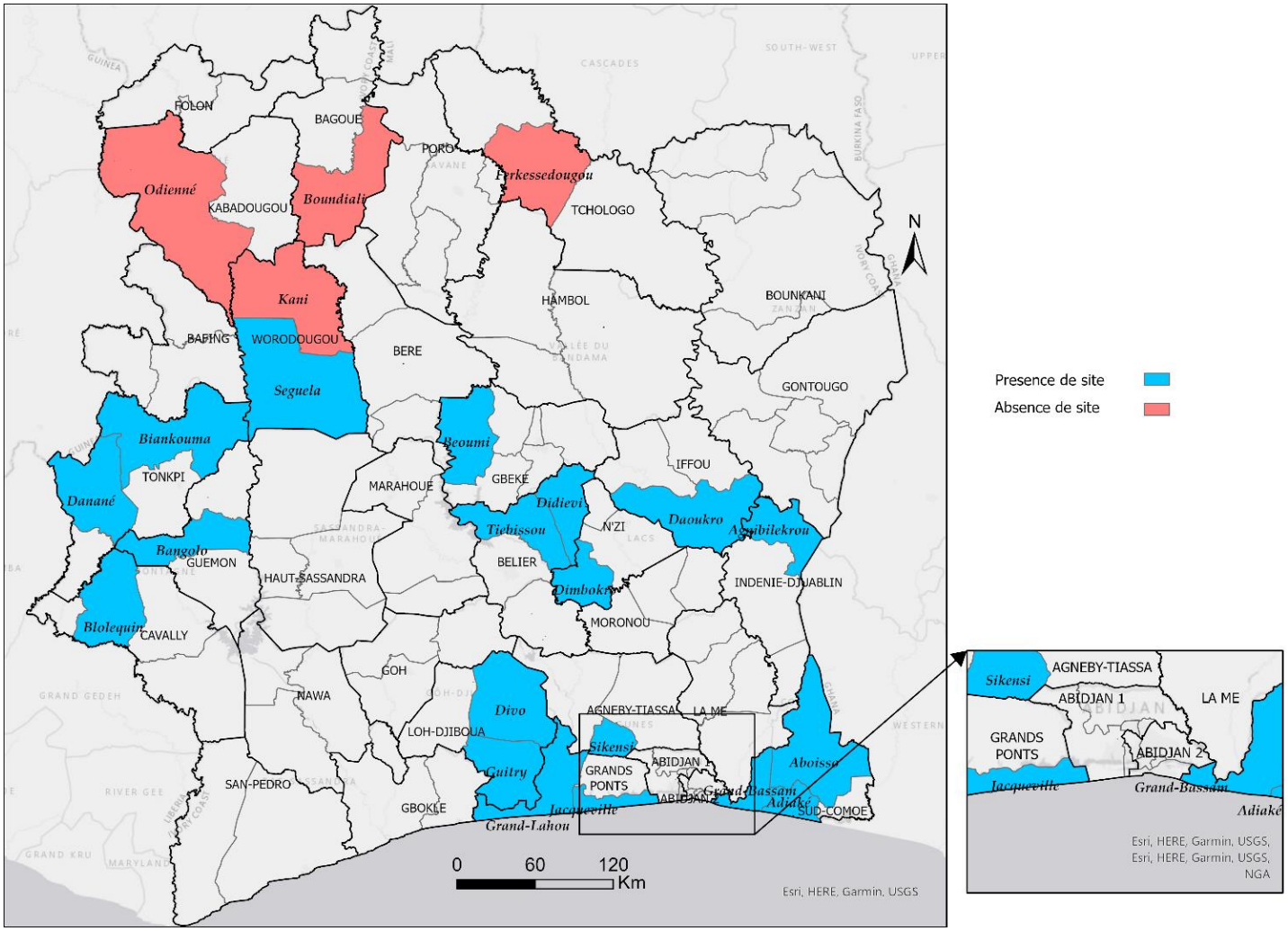
La **couverture de l'offre de services de prévention et de dépistage sur ces sites est faible** : 46% des sites n'ont jamais reçu d'offre de dépistage, seulement 30% des sites ont été visités par les EP TG au cours des six derniers mois quand 58% n'ont, eux, jamais reçu de visite d'EP.

On constate également que globalement les **sites ne sont pourvus ni en gel, ni en préservatif (féminins comme masculins)** : 70% des sites ne disposent jamais de préservatifs masculin, 58% de gel lubrifiant et 46% de préservatif féminin.

Les personnes interrogées expriment d'ailleurs en termes de priorité, le besoin en préservatifs et gels lubrifiants (53%). **On recense également comme besoin important l'accès à des services de santé plus adéquats (18%) et l'appui psychologique et la lutte contre les VBG (11%).**

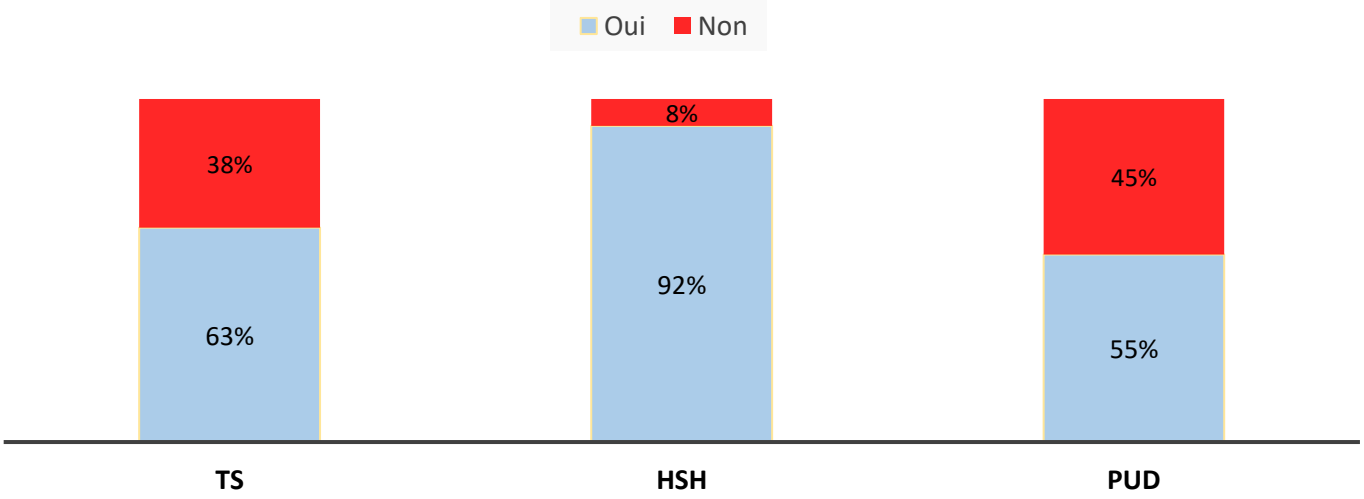
Quant à l'intérieur du pays, les activités de la cartographie des sites de rencontre et de socialisation des personnes transgenres (TG) ont permis de dénombrer **64 sites confirmés dans l'ensemble 23 districts**. Les quatre (04) districts sanitaires n'abritant aucun site ont été retrouvés dans les régions sanitaires du nord du pays : Bagoué (district sanitaire de Boundiali) et Tchologo (district sanitaire de Ferkessédougou), Kabadougou (district sanitaire d'Odiéné) et Worodougou (district sanitaire de Kani).

Figure 44 : Cartographie des sites de rencontres et de socialisation des TG



Source : l'Ong ENDA Santé

Au sein de ces sites on rencontre également les autres populations (70% des sites hébergent toutes les populations clés, **92% des HSH**, **63% des TS** et **55% des UD**) montrant la solidité des liens entre les

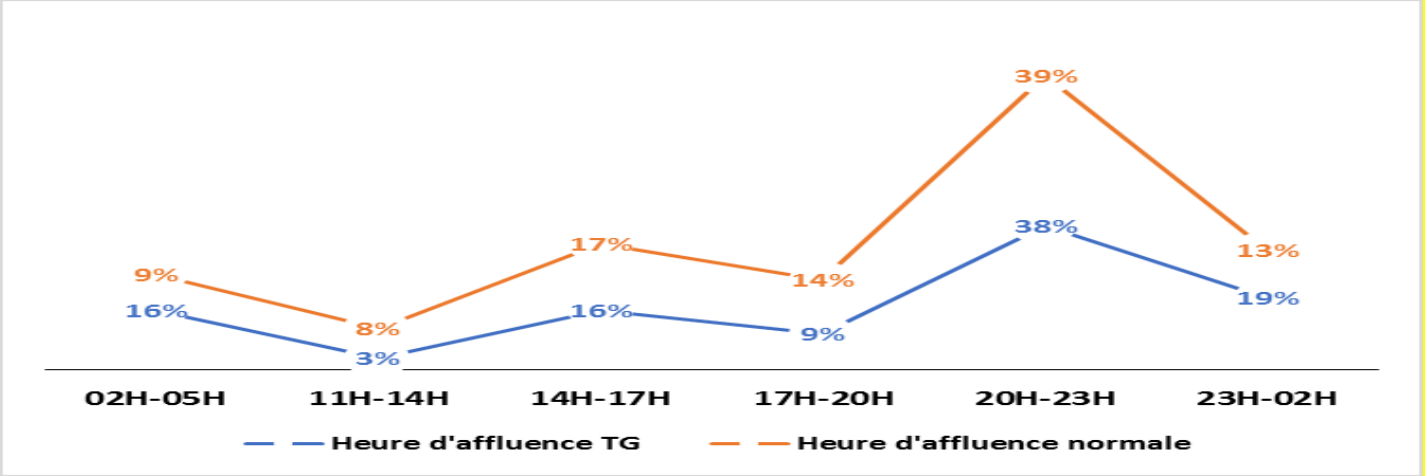


Rapport d'étude ENDA SANTE ci : cartographie programmatique et estimation des tailles des HSH a Abidjan utilisant la méthode PLACE avancée. Avril 2017

TG et autres populations clés.

Les sites sont globalement plus fréquentés par les personnes TG les **samedis (59%) entre 20H et 23H** (38% des sites) avec des spécificités selon la typologie des sites **Maquis (23H-05H à 60%), Domiciles (14H-20H à 42%), Salon de coiffure (17H-20Hà 50%)**.

Figure 45 : Fréquentation horaires des TG



L'effectif moyen aux moments d'affluence est de 6 avec un minimum de 2 et un maximum de 13.

Concernant la disponibilité en préservatif masculin, on note que **87% des sites fréquentés ont déjà été déjà approvisionnés en préservatifs contre 13% qui ne l'ont jamais été au cours des 6 derniers mois**.

4.4.3. Cartographie Programmatique et Estimation de la Taille des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH)/Gays à Abidjan.

Les informations ci-dessous sont tirées du rapport portant sur la Cartographie programmatique et estimation des tailles des hsh Abidjan utilisant la méthode place avancée rapport d'etude **ENDA SANTE CI** 2017

4.4.3.1. Cartographie programmatique en direction des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH)/Gays à Abidjan

Afin de garantir l'efficacité des interventions, il était important de disposer de données factuelles pouvant orienter la prise de décisions. **A cet effet, l'Université Caroline du Nord (UNC) dans le cadre d'une contractualisation a mandaté Enda Santé pour la mise en œuvre d'une cartographie** programmatique orienté vers les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) à Abidjan.

Concernant les sites physiques, sur un **total de 877 sites recherchés, 575 sites ont été retrouvés fonctionnels tandis que 112 sites n'ont pu être retrouvés, 64 sites étaient fermés, 69 n'ont pu être visités bien que retrouvés et 57 sites se sont avérés être des doublons. 216 sites ont été effectivement confirmés comme points chauds HSH** par les informateurs de sites**.**

La typologie des sites est diverse mais il ressort dans l'ensemble que dans la ville d'Abidjan les principaux types de sites sont les **bars formels (31,48%), les maquis (24,7%) et les domiciles**

(12,04%). Cocody est la commune qui renferme le plus grand nombre de sites (21,30%) devant les communes de Yopougon et Abobo avec chacune 19,44% des sites. On rencontre une proportion plus grande de domiciles à Port-Bouët (34,62%), Abobo (24%) et Adjamé (20%) qu'à Yopougon où la grande majorité des sites sont des maquis (38,10%).

Ces sites HSH sont en général des sites mixtes. En effet, 68% des sites confirmés HSH sont également fréquentés par les travailleuses du sexe (TS). Plus de 30% sont également fréquentés par les usagers de drogue injectables. Selon 69% des informateurs, leurs sites sont des lieux où les HSH qui ont des rapports sexuels pour de l'argent viennent chercher des clients.

Les plus fortes affluences sont enregistrées les weekends, c'est-à-dire les vendredis (96,76% des sites), samedi (96,30% des sites) et dimanche (96,730% des sites) à partir de 17 heures et ce, jusqu'au petit matin à 6 heures. Pour ces trois jours, les moments les plus « chargés » se situent de 21h à 24h (71% des sites le vendredi, 69% le samedi et à 68% des sites le dimanche).

Concernant les sites de rencontre virtuelle, 261 hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) résidant à Abidjan et majoritairement recrutés sur Facebook (30,65%) et Planet Roméo (29,89%) ont participé à l'enquête en ligne. Les applications mobiles telles que *Whatsapp* et *Grindr* sont aussi très utilisées (respectivement 48,66% et 38,31% de l'effectif).

4.4.3.2. Estimation de la Taille des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH)/Gays à Abidjan

La population de hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) d'Abidjan est estimée à **5.892**

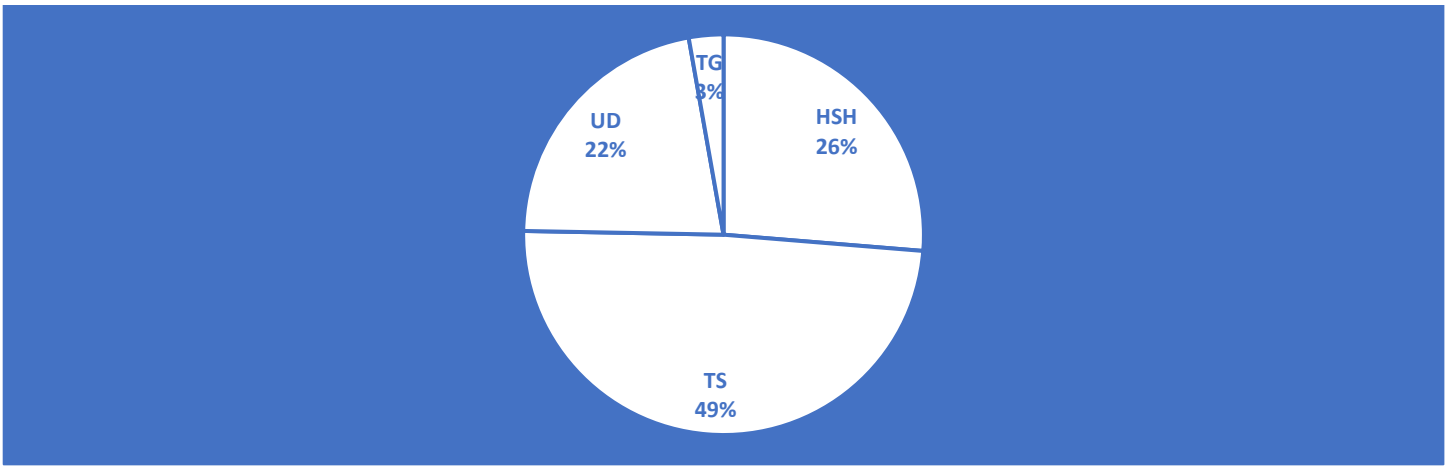
4.5. Violences faites aux populations clés

Les informations de cette partie sont issues du Rapport de l'Observatoire des Droits Humains de CI Enda Sante CI PROJET Funds mondial FC/NMF3 Janvier 2021 au 15 Avril 2022. A l'instar des autres populations clés, les personnes transgenres et hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) sont victimes de violences basées sur le genre. Les données de l'observatoire communautaire de la santé, piloté par ENDA Santé Côte d'Ivoire, du 01 janvier 2021 au 15 avril 2022 révèlent ce qui suit :

4.5.1. Répartition des populations clés par cibles

La répartition des populations clés victimes de violences basées sur le genre a permis de recenser **49% de TS, 26% de HSH, 22% de UD et 3% de TG.**

Figure 46 : Proportion des LGBT parmi les populations victimes des VBG



Source : ONG ENDA Santé (2021)

4.5.2. Répartition des populations clés par tranche d'âge

La répartition des population clés fait état de **8%, 29%, 43% et 21%** qui ont respectivement les tranches d'âge suivantes **[15-19], [20-24], [25-34] et [35-49].** De façon spécifique, les données liées aux personnes transgenres sur les tranches d'âge permettent de disposer des informations ci-dessous. **7% de [15-19], 21% de [20-24], 57% de [25-34] et 14% de [35-49].** Pour ce qui concerne les HSH, les données relatives aux tranches d'âge donnent **9% pour les tranches de [15-19] et [35-49], 39% pour les [20-24] et 42% pour les [25-34].**

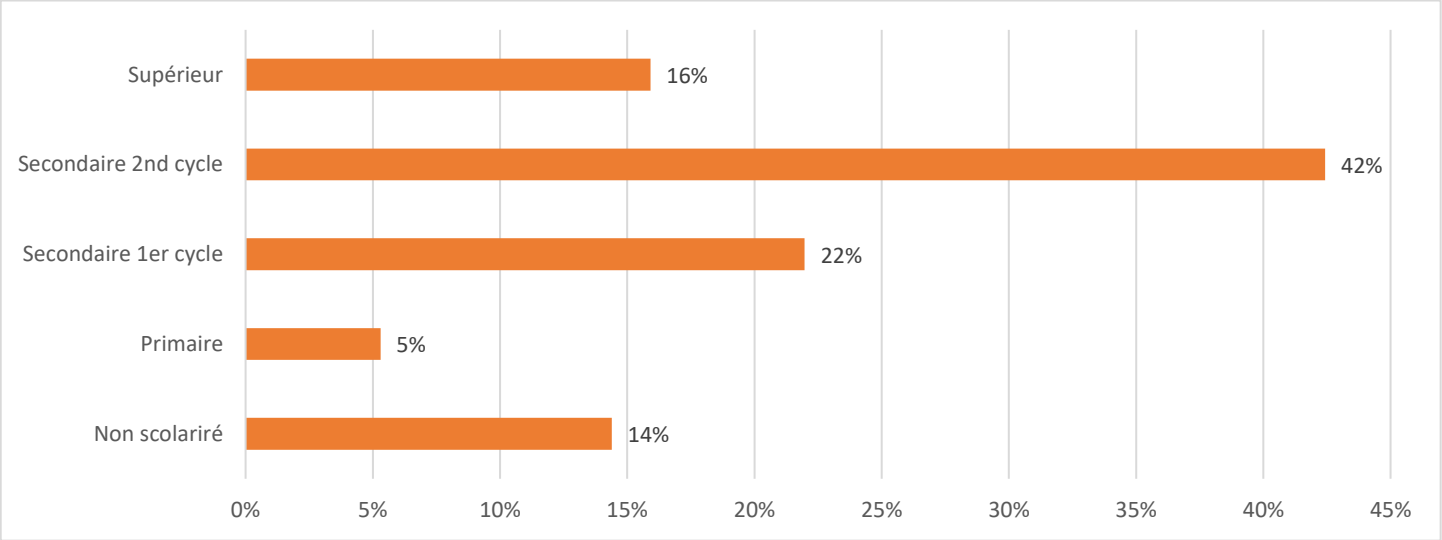
4.5.3. Répartition des populations clés par sexe

Quant à la répartition des populations clés de manière générale selon le sexe biologique, les données ont permis d'enregistrer **51% de sexe féminin contre 49% de sexe masculin**. En rapportant la même information aux personnes transgenres, on enregistre **14% de sexe féminin (homme trans) contre 86% de sexe masculin (femme trans)**. Chez les HSH, l'ensemble des individus enregistrés est de **sexe masculin, soit 100%.**

4.5.4. Répartition des populations clés par niveau d'étude

La question du niveau d'étude des populations clés a été également analysée. **26% sont non scolarisé et ont un niveau primaire, 24% ont un niveau secondaire premier cycle contre 17% pour le second cycle et 6% avec un niveau supérieur.** Au niveau des transgenres, **43% sont non scolarisées, 7% ont un niveau primaire, 29% ont un niveau secondaire (premier cycle) et 21% ont un niveau secondaire (second cycle). Aucun au niveau supérieur.** Quant aux HSH, **14% sont non scolarisées, 5% au niveau primaire, 22% au secondaire (premier cycle), 42% ont un niveau secondaire (second cycle) et 16% le niveau supérieur.**

Figure 46 : Répartition des populations clés selon le niveau d'instruction

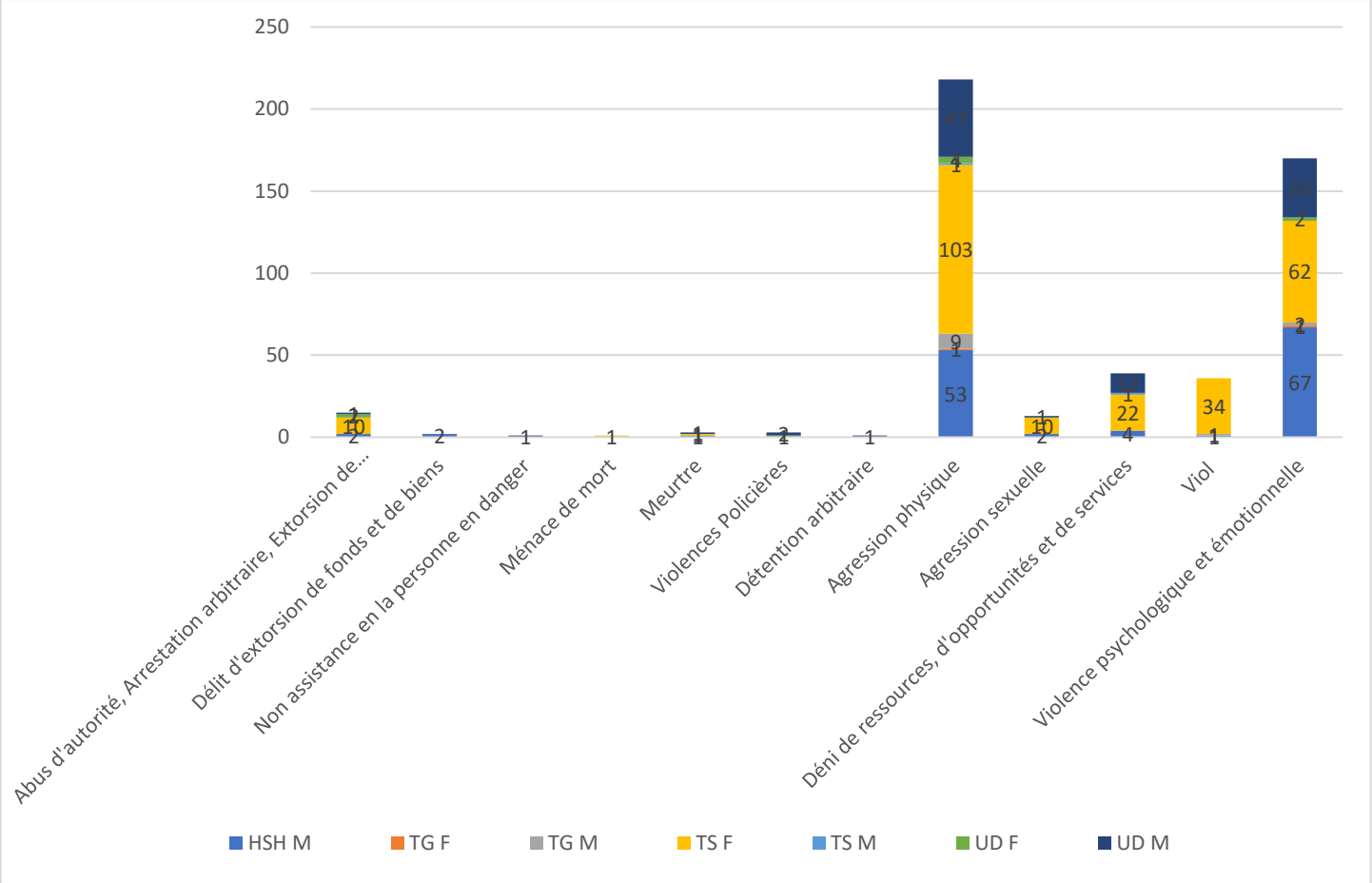


Source : l'Ong ENDA Santé (2021)

4.5.5 Répartition des violations selon les cibles et le sexe

Le graphique met en lumière les différentes violations et/ou atteintes des droits humains perpétrées sur les populations clés. Au regard de ce qui suit, **les agressions physiques représentent la majorité des violations faites aux populations clés (43%). Puis, il s'en suit les violences psychologiques et émotionnelles (34%), les Dénis de ressources, d'opportunités et de services (8%), les viols (07%), les agressions sexuelles et abus d'autorité, arrestation arbitraire, et extorsion de fonds (03%).**

Figure 47 : Répartition des violations selon les cibles et le sexe



Source : l'Ong ENDA Santé (2021)

Le graphique met en lumière les différentes violations et/ou atteintes des droits humains perpétrées sur les populations clés. Au regard de ce qui suit, **les agressions physiques représentent la majorité des violations faites aux populations clés (43%). Puis, il s'en suit les violences psychologiques et émotionnelles (34%), les Dénis de ressources, d'opportunités et de services (8%), les viols (07%), les agressions sexuelles et abus d'autorité, arrestation arbitraire, et extorsion de fonds (03%).**

4-4-4- Situation au niveau de la législation et l'accès aux services des LGBT

Les droits des Homosexuelles en Afrique, regroupés sous le sigle (LGBT) connaissent des fortunes diverses en fonction de la zone géographique, et de la nature du régime notamment.

En Afrique de l'Ouest[1], le Nigéria pays le plus peuplé, les relations sexuelles de même sexe sont condamnées par 14 ans de prisons. Dans 14 Etats du nord où la loi islamique est de vigueur (Charia), les LGBT sont condamnés à mort par lapidation.

Dans d'autres pays comme la Côte d'ivoire où l'homosexualité n'est pas illégale, les LGBT doivent se battre pour faire reconnaitre juridiquement les discriminations dont ils sont victimes. En fin d'année 2021, le gouvernement Ivoirien initiant une réforme visant à étendre le champ de la lutte contre les discriminations au personnes LGBT et les femmes dans le code pénal, n'a pas été suivi par les parlementaires qui ont récusés l'expression « orientation sexuelle » qui réfère aux LGBT notamment. Jusque-là, un régime de protection générale leur est accordé sous

[1] Source : https://information.tv5monde.com/info/afrique-quels-droits-pour-les-homosexuels-432977

l'emprise de la constitution de novembre 2016, portant constitution de la troisième république[2]. Ce régime de protection générale s'étend au milieu du travail/emploi ; s'étend au domaine de la santé[3], de l'accès à la propriété, de l'accès à la justice, de l'accès à l'éducation, de l'accès à la liberté d'association sans discrimination, des droits sociaux essentiels promus par les traités et conventions internationales dont la côte d'ivoire est partie et qu'elle a ratifiée. Il n'existe pas de lois criminalisant l'homosexualité en Côte d'Ivoire.

La quasi-totalité des pays du Nord -Musulman (Maroc-Tunisie -Algérie- Egypte) condamne de peines privatives de liberté les homosexuels.

Figure 48 : Situation des droits des Homosexuels en Afrique.



Source :

[2] Par son attachement aux principes universels du respect de la dignité, de la vie humaine, tout un titre (Titre I) a été consacré aux droits, libertés et devoirs (article 1 à 47). L'article 4 de la Constitution dans son contenu se présente comme une disposition anti-discrimination essentielle qui prévoit que : « tous les ivoiriens naissent libres et égaux en droit (…) ».

[3]Article 9 de la constitution Loi n ° 2016-886 du 8 novembre 2016

5.1TRANSVERSALISASSION DU GENRE DANS LES ODD

Dans cette partie du rapport, il s'agira de faire un état des lieux de la mise en œuvre des ODD genre au travers des différents ODD. Un accent particulier sera mis sur certains ODD pour lesquels les indicateurs ont pu suffisamment être désagrégés en genre.

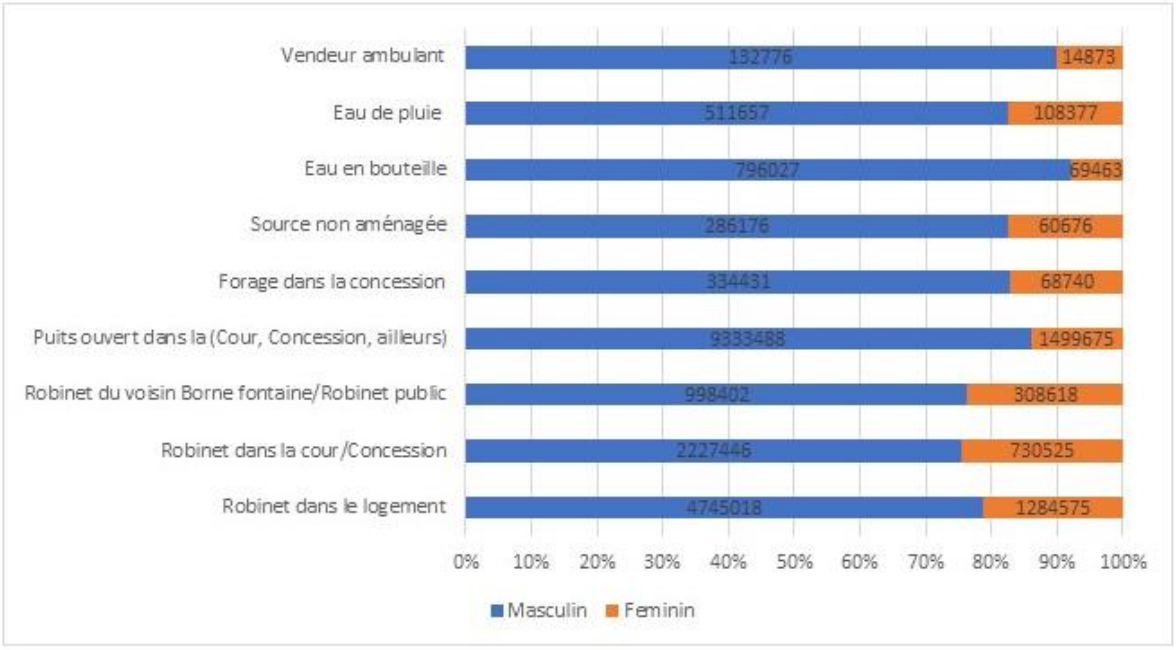
Comme nos analyses le montre, les femmes et les filles restent affectées de manière disproportionnée par les retombées socio-économiques de la pandémie, aux prises avec la perte d'emplois et de moyens de subsistance, le dérapage de l'éducation et le fardeau accru du travail de soins non rémunéré. Les services de santé des femmes, déjà mal financés, ont été confrontés à des perturbations majeures et ont porté atteinte à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Les progrès réalisés pour les femmes ont été érodés par la pandémie.

5.5.1 Focus sur l'accès à l'eau et à l'assainissement des femmes



Les sources d'approvisionnement en eau de boisson de la population en saison sèche comme des pluies sont aussi diverses que variées allant des sources d'eau améliorée (robinet, eau en bouteille, etc) contre ceux non amélioré. L'analyse des effectifs des Individus vivant dans des ménages selon leur source d'approvisionnement, nous donne de voir que les femmes tout comme les hommes ont accès à l'eau.

Graphique 34 : Source d'approvisionnement du ménage (individu) en saison sèche en eau de boisson selon sexe



Source : EHCVM

Sur un total de 5929605 ménages s'approvisionnant en eau de robinet en saison sèche, nous avons 4682949 dirigés par un homme soit 78.9% contre 1246656 dirigés par une femme soit 21.02%. Pour le robinet dans la cour (concession), sur 2835755, nous avons 2137077 dirigés par un homme soit 75.3% et 698678 dirigés par une femme soit 24.6%. Pour les robinets publics (robinet du voisin, borne fontaine), sur un total de 1349487, nous avons 1024473 dirigés par un homme soit 75,91% contre 325014

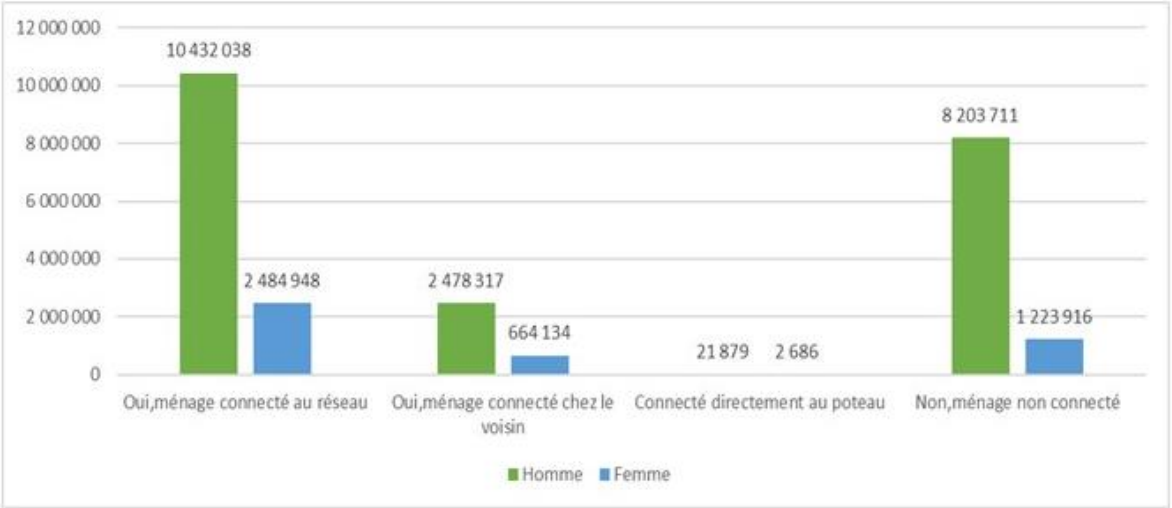
dirigés par une femme soit 24%. Pour les ménages qui dépendant de l'eau de robinet public (robinet du voisin, borne fontaine), sur un total de 1307020 individus, 23.6% sont dirigés par les femmes.

5.5.2. Focus sur les sources d'éclairage et l'accès à l'électricité des ménages.



Sur 12916986 d'individus connectés au réseau électrique, 2484948 vivent dans des ménages dirigés par des femmes, soit 19.2% ; 21 % d'individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes s'approvisionnent en électricité chez le voisin. Pour ceux connectés directement au poteau électrique, ce sont 10.9% de d'individus vivant dans des ménages dirigés par les femmes qui utilisent cette source d'approvisionnement.

Graphique 34 : Individus vivant dans des ménages connectés à l'électricité selon le sexe du chef

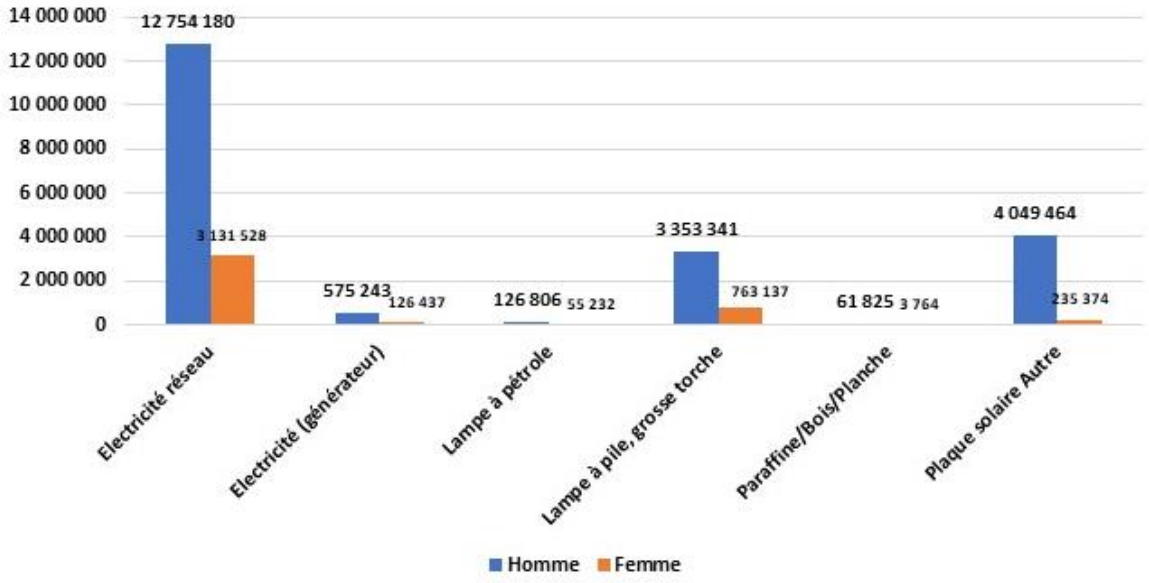


Source : EHCVM_2018

Principale source d'éclairage des ménages

On Observe une la quasi-totalité des femmes sont encore à l'étape de cuisson avec le bois et ou la forme traditionnelle. Elles n'utilisent pas les énergies propre/Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres. En effet, 19.7% d'individus vivant dans des ménages dirigés par des femmes utilisent l'électricité du générateur (lampadaire électrique), quand 18.1% utilisent la lampe à pétrole, 5.7% pour les plaques solaires.

Graphique 35 : Type d'éclairage utilisés selon le genre du chef de ménage



Source : EHCVM2018

5.5.2 Forte disparité dans les indicateurs d'emplois



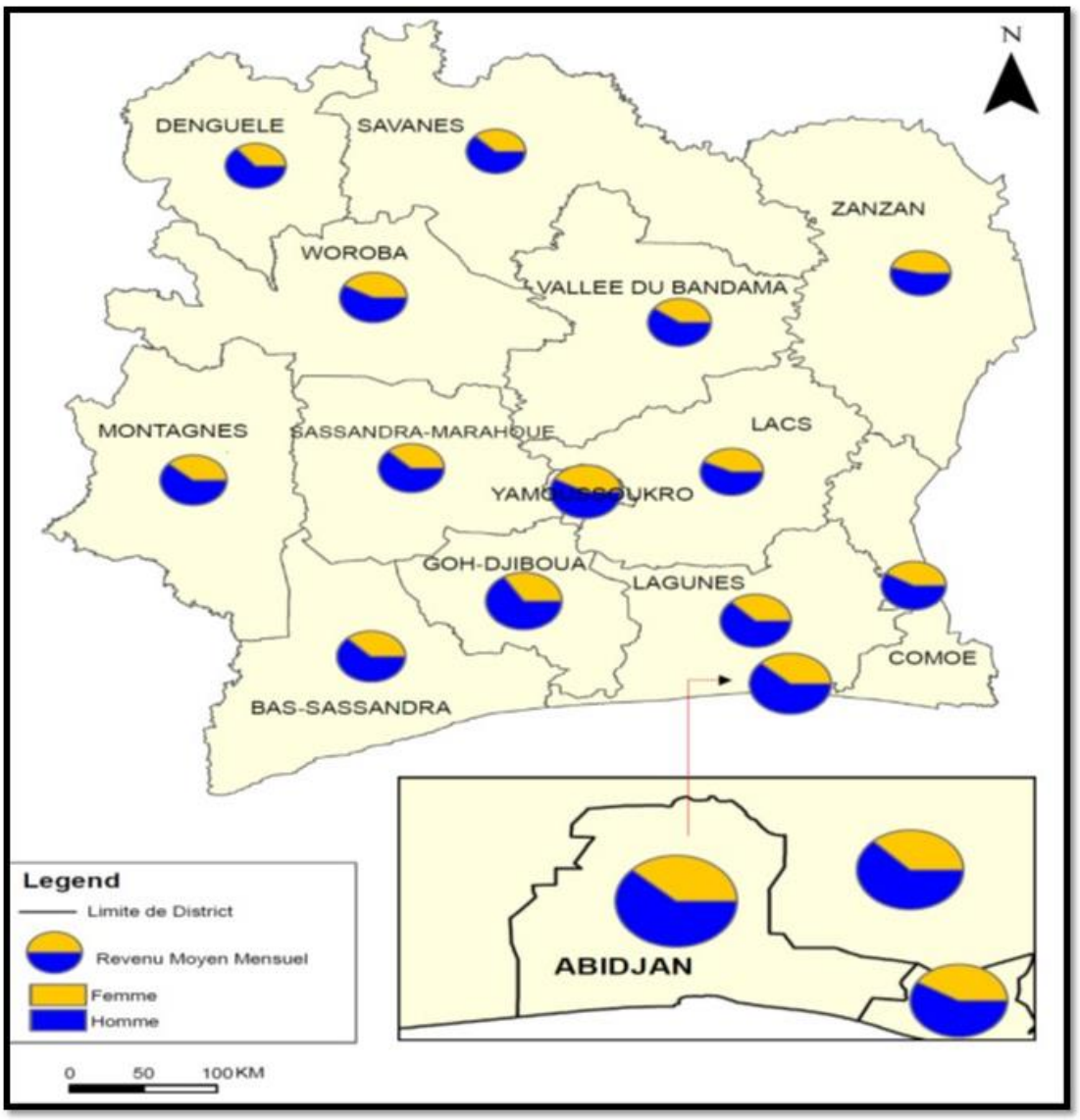
Une forte disparité au niveau de l'emploi des femmes. Le taux de chômage au niveau des femmes. Le chômage des jeunes est plus important chez les femmes (4,6 %) que chez les hommes (3,1%). 91,4% des emplois des femmes et 86,7% des emplois des hommes sont informels.

5.5.2.1 Inégalité dans le revenu entre la femme et l'homme

Le revenu mensuel moyen tiré de l'emploi principal est plus élevé chez l'homme que chez la femme. De fait, les femmes gagnent 78 541 FCFA et les hommes 128 016 FCFA, soit près de 40% moins. Sans surprise, ce sont les femmes qui en plus grande proportion enregistrent les bas salaires et qui gagnent moins que le SMIG. De fait 31,4% des femmes ont un bas salaire, ce chiffre étant de 20,2% pour les hommes. Quant 'au SMIG, ce sont 54,2% des femmes qui gagnent moins que le salaire minimum interprofessionnels garanti contre 37,1% des hommes.

Quel que soit le district, le milieu, le niveau d'instruction, ou même la catégorie socio-professionnelle, le revenu des femmes reste toujours inférieur à celui des hommes. Toutefois, des disparités sont observées entre femmes suivant les caractéristiques citées précédemment. Ainsi, le revenu des femmes est plus élevé à Abidjan (105 993 FCFA) et plus faible dans le Denguélé et les Savanes presque à parité égale 55 000 FCFA. Il est plus élevé chez les femmes du niveau d'étude du supérieur 193 000 FCFA, et beaucoup moins chez celles qui n'ont aucun niveau (65 000 FCFA), soit plus de trois fois plus. Du point de vue de la catégorie socio-professionnelle, ce sont les femmes salariées qui enregistrent les plus gros salaires, suivies des travailleurs inclassables et des employeuses (109 000 FCFA) ; les faibles salaires étant détenus par les femmes travailleurs familiaux (51 000 FCFA).

Carte 6 : Salaire mensuel moyen des emplois en FCFA selon le sexe



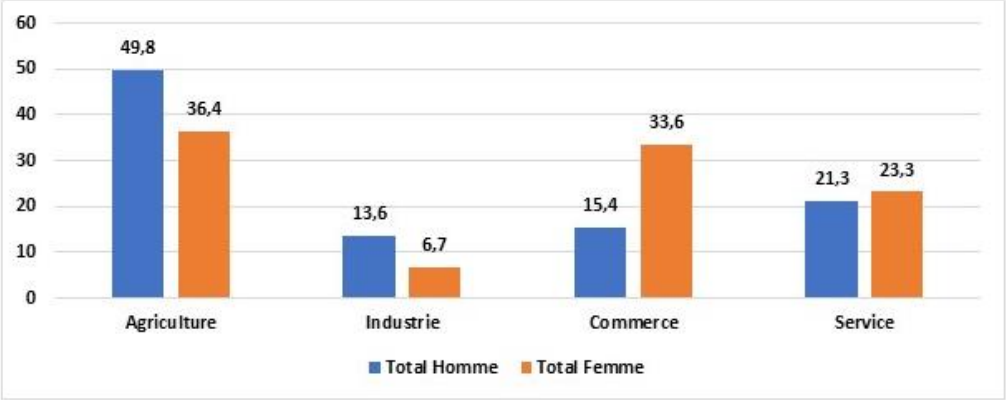
Source : ENE 2019

5.5.2.2 Branches d'activité des jeunes Femmes (16-40 ans)

L'analyse par branche d'activités est faite selon un regroupement en quatre principaux secteurs notamment : Agriculture, Industrie, Commerce et Services à partir de la NAEMA[3]. Les résultats montrent que les emplois sont tournés vers l'agriculture, répartie entre (46,2% pour les hommes et 34,1% pour les femmes). Les femmes sont plus intéressées aux activités commerciales, et très minoritaires dans les activités industriels (7%) quasiment le double de la proportion des hommes.

3 Nomenclature des Activités des Etats Membres d'Afristat

Graphique 36 : Répartition de la population par branche d'activités d'activité



Source : ENE_2019

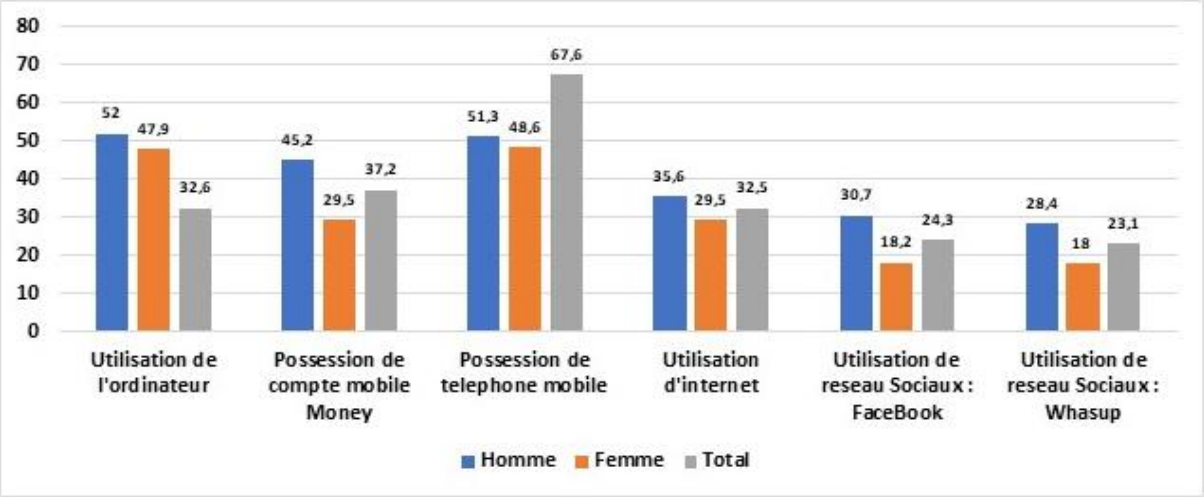
5.5.2.3 Temps domestique et hebdomadaire des femmes

La durée de travail consacrée par la femme (16-40 ans) reste préoccupante. Les femmes effectuent 40 heures de travail dans leur emploi et 19 heures de travaux domestiques par semaine, soit un total de 58 heures, ce chiffre étant de 52 heures pour les hommes, soit 7 heures de plus. Toutefois en considérant uniquement l'emploi, la durée horaire hebdomadaire des hommes reste toujours élevée comparativement aux femmes. Au contraire, la durée hebdomadaire des travaux ménagers des femmes reste toujours supérieure à celle des hommes

5.5.2.4 Les Femmes en arrière-plan vis-à-vis des TICS

Que ce soit l'utilisation de l'ordinateur, la possession d'un téléphone mobile et d'un compte mobile Money, et même l'utilisation d'internet ainsi que de certains réseaux sociaux, les Femmes sont toujours en arrière-plan par rapport aux Hommes.

Figure 37 : Utilisation des Tics en fonction du sexe



Source : EMSI_2019